This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
L343 .L65f 1891 STOR
La neurosis : estudio clinico y terapeu
24503306426

J. BALLESTA
MEXICO

LANE
MEDICAL LIBRARY

Gift
Dr. A. V. Samaniego

LA NEUROSIS

PRINCIPALES CORRESPONSALES

ALAVA.—*Vitoria.*—B. Robles.—Lopez Munain.
ALBACETE.—Sebastian Ruiz.
ALICANTE.—A. Marcili.—F. Alemañy.—*Alcoy.*—P. Botella —Gimeno.
ALMERÍA.—Mariano Alvarez Robles.
AVILA.—José Carrascoso.
BADAJOZ.—Francisco Alvarez Gonzalez.—Mauri Claramont y compañía.
BALEARES.—*Palma.*—Francisco Puigrredon.—Felipe Guasp.—*Mahon.*—Antonio Sintes.
BARCELONA.—Juan Llordach.—J. Güell.
BURGOS.—S. R. Alonso.—C. Avila é hijo.
CÁCERES.—J. del Pozo y Mateos.
CÁDIZ.—Ibañez y Prado.—M. Morillas.—José Vides.—*Jerez.*—Bueno.—Miguel Gener.
CANARIAS.—*Las Palmas.*—Martin Velasco.—*Santa Cruz de Tenerife.*—Delgado Yúmar.—*Santa Cruz de la Palma.*—T. Torres Lujan.
CASTELLON.—Rovira hermanos.
CIUDAD-REAL.—Francisco Ruiz Morote.—Ramon Clemente Rubisco.
CÓRDOBA.—Manuel Garcia Lovera.
CORUÑA.—A. Escudero.—*Ferrol.*—F. Obertin.—E. Varela.—*Santiago.*—B. Escribano.—Galy Camps.
GERONA.—Paciano Torres.—F. de P. Vila.
GRANADA.—Paulino Ventura y Sabatel (Viuda é hijos de).—José L. Guevara.—D. Santaló.
GUADALAJARA.—Rafael García.
GUIPÚZCOA.—*San Sebastian.*—Hijos de Ignacio Baroja.—M. Darrassen.—Viuda de Oses.
HUELVA.—Viuda é hijos de Muñoz.
HUESCA.—F. Iglesias Lacostena.
JAEN.—Bermejo.—José Rubio Arcos.
LEON.—L. Garzo.—Miñon.
LÉRIDA.—L. Corominas.—E. Ribelles.
LOGROÑO.—A. Ortoneda.—Viuda de Pablo Zabala.
LUGO.—Juan Antonio Menendez.
MADRID.—Bailly-Baillière.
MÁLAGA.—A. Rubio.
MURCIA.—Rafael Almazan.—*Cartagena.*—W. y L. Garcia hermanos.
NAVARRA.—*Pamplona.*—Regino Bescansa.—Joaquin Lorda.
ORENSE.—Nemesio Perez.—Severiano Perez Resvie.—Vicente Miranda.
OVIEDO.—Juan Martinez.—*Gijon.*—Hermógenes Andrade.—Ladislao Mendez.
PALENCIA.—Eleuterio Rincon.
PONTEVEDRA.—J. Buceta.—*Vigo.*—J. J. del Aguila.—Eugenio Krapf.
SALAMANCA.—Calon (Viuda é hijos de).—Manuel Hernandez.—Vicente Oliva.
SANTANDER.—G. Carriles.—Luciano Gutierrez.
SEGOVIA.—Félix Santiuste.—Segundo Rueda.
SEVILLA.—Tomás Sanz.—Fó.—E. Torres.
SORIA.—Vicente Tejero.
TARRAGONA.—Font.—S. Ginesta Salas.—*Reus.*—J. Sardá y Vernis.
TERUEL.—Joaquin Abad.
TOLEDO.—Menor hermanos.—Juan Pelaez.
VALENCIA.—Francisco Aguilar.—Pascual Aguilar.—Ramon Ortega.
VALLADOLID.—L. Miñon.—Jorge Montero.—Juan Nuevo.—Hijos de Rodriguez.
VIZCAYA.—*Bilbao.*—Eleuterio Villar.—Viuda de Delmas (Dochao, sucesor).
ZAMORA.—Nicanor Fernandez.
ZARAGOZA.—Cecilio Gasca.—Julian Sanz.

Isla de Cuba.

HABANA.—A Chao.—S. Lopez.—J. Martinez.
MATANZAS.—M. Albourne y comp.ª—Carreño y Sobrino.
PINAR DEL RIO.—Marcos Mijares.
SANTA CLARA.—Santiago Ortí.
SANTIAGO DE CUBA.—Juan Perez Dubrull.

Puerto-Rico.

PUERTO-RICO.—J. J. Acosta.—B. F. Sanjurjo Vidal.
PONCE.—Olimpio Otero.
MAYAGÜEZ.—J. Mas.

Filipinas.

MANILA.—Enrique Bota.
LAOAG.—Jerónimo Javier.
ILO-ILO.—Pineda hermanos.

América central.

GUATEMALA.—Antonio Partegás.
HONDURAS.—*Comayagua.*—R. Valenzuela.
COSTA-RICA.—*San José.*—Vicente Lines.
REPÚBLICA DOMINICANA.—*Santo Domingo.*—Henriquez y Carvajal.
NICARAGUA.—*Leon.*—F. Mayorga.
SAN SALVADOR.—Mariano Duarte.

América septentrional.

MÉJICO.—R. Ortega.—Herrero y Benavides.—*Aguas-Calientes.*—Mariano Camino.—*Campeche.*—Avaos.—*Chilpancingo.*—Cayetano Joberon.—*Culiacan.*—M. R. Paredes.—*Durango.*—I. de la Torre.—*Guadalajara.*—P. Pais.—N. Puga.—*Guanajuato.*—C. Castañy Camps.—*Hermosillo.*—F. M. Castro.—*Isla del Cármen.*—Laguna.—Acevedo.—*Leon.*—N...—*Mazatlan.*—M. de Retes.—*Monterrey.*—T. Muris.—*Querétaro.*—Guadalupe A. Ibarra.—S. *Juan Bautista.*—J. M. Graham.—*San Luis de Potosí.*—A. Cabrera.—*Tampico.*—N...—*Toluca.*—N...—*Veracruz.*—R. Rodriguez.
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA.—Tauzy, Carvajal y comp.ª—Louis Gregoire y compañia.

América meridional.

ARGENTINA (REPÚBLICA).—*Buenos-Aires.*—Jacobsen y comp.ª—*Córdoba.*—L. Simion.
BOLIVIA.—*La Paz.*—J. M. Farfan.—Forgues.—E. Vidal y comp.ª—*Cochabamba.*—Aurelio Pacieri.
CHILE.—*Concepcion.*—José M. Serrato.—*Santiago.*—Avalos Prado.—*Talca.*—J. C. Azocar.—*Valparaiso.*—Cárlos Niemeyer.
COLOMBIA.—*Bogota.*—Lázaro M. Perez.—*Barranquilla.*—C. M. Mayans.—*Cartagena.*—J. F. Velez.—*Panamá.*—Preciado y comp.ª—Dr. Manuel A. Mora.
ECUADOR.—*Guayaquil.*—Pedro Janer.—*Quito.*—N. Montesdeoca.
PERÚ.—*Lima.*—Benito Gil.—*Arequipa.*—J. M. Farfan.—J. G. Meneses.—*Callao.*—Colville y comp.ª—*Trujillo.*—Carranza Espinoza y compañia.
URUGUAY.—*Montevideo.*—A. Rius.
VENEZUELA.—*Barcelona.*—Salazar Hernandez.—*Caracas.*—Rojas hermanos.—*Carúpano.*—Carrera Mayz.—*Ciudad de Bolivar.*—Miguel Antonio Rodriguez.—*Cumaná.*—Carrera Mayz.—*Maracaibo.*—M. N. Rincon y comp.ª—*Puerto-Cabello.*—J. A. Segrestáa.—*San Cristóbal.*—Florez hermanos.—*Trujillo.*—J. B. Carrillo.—*Valencia.*—Mendez hermanos.

Antillas holandesas.

CURAÇAO.—*Willemstad.*—Bethencourt ó hijos.

Extranjero.

PARIS.—J. B. Baillière ó hijos.—Roger et Chernoviz.
LÓNDRES.—Baillière Tindall and Cox.

Tetuan de Chamartin.—Imp. de D. Cárlos Bailly-Bailliere.

Propiedad de

LA NEUROSIS

ESTUDIO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO

DISPEPSIA

ANEMIA. — REUMA Y GOTA. — OBESIDAD

ENFLAQUECIMIENTO

POR

EL DOCTOR M. LEVEN

MÉDICO EN JEFE DEL HOSPITAL ROTHSCHILD

TRADUCCION CASTELLANA

DE

C. FERNANDEZ DE ARMENTEROS

Segunda tirada.

LANE LIBRARY

MADRID

LIBRERÍA EDITORIAL

DE D. CÁRLOS BAILLY-BAILLIERE

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS 1881
Y DE BARCELONA 1888,
Y CON MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARÍS 1889.

Plaza de Santa Ana, número 10.

1891

Derechos reservados.

El editor y propietario de esta obra, **D. Carlos Bailly-Bailliere**, ha adquirido, mediante un contrato con el Autor de la misma, el derecho exclusivo de traducción en idioma castellano; y habiendo cumplido con los requisitos que marca la *Ley de Propiedad intelectual*, tanto en España como en sus posesiones de Ultramar, nadie tendrá derecho á reproducir en todo ó en parte esta obra sin su autorización por escrito.

YALE LIBRARY

PREFACIO

Este libro es la continuacion de mis investigaciones sobre las enfermedades del estómago. He dicho anteriormente que las formas múltiples de la dispepsia, que la gastralgia, la gastritis, etc., se confunden todas en una sola afeccion, la congestion patológica de la mucosa estomacal determinada por la irritacion del plexo solar.

Continuando mis observaciones clínicas, quedé sorprendido de la frecuencia de los síntomas nerviosos que aparecen antes ó despues de la dispepsia, sin poderme explicar las relaciones que existen entre el tubo digestivo y el sistema nervioso.

Despues de largas investigaciones y del exámen de gran número de enfermos, no-

107687

tando los síntomas, el modo de evolucion de éstos, el régimen, la medicacion prescrita, comprendí cómo el sistema nervioso interviene en la produccion de la dispepsia.

Entonces me convencí de que la célula nerviosa es la causa de las enfermedades del tubo digestivo, así como de la mayor parte de las enfermedades de las otras vísceras, y que mantiene la salud de los nervios ó determina en ellos fenómenos dolorosos. Ella es causa del mayor número de nuestras dolencias, de nuestras afecciones, dolores de cabeza, vértigos, dispepsia, anemia, gota, reuma, obesidad, diabetes, afecciones cutáneas, desórdenes de la nutricion; ella es, en fin, la que determina las lesiones múltiples de nuestros órganos. Y sin embargo, la célula nerviosa ha sido olvidada por los patólogos. La enfermedad ha sido estudiada sólo en su anatomía patológica, es decir, se ha estudiado la muerte pero no la vida. Los neurólogos no se han ocupado más que de los nervios y de sus síntomas; ahora bien, los nervios son sencillamente conductores de las impresiones de la célula nerviosa. Y como no se han ocupado de ésta, orígen de toda per-

turbacion nerviosa, han desconocido la patogenia de las neurosis.

Decia Bichat, confundiendo la vida con las funciones, cosas absolutamente distintas, que la vida es el conjunto de funciones que se oponen á la muerte. La vida es la fuerza comunicada al sér en la concepcion; gracias á ella la célula nerviosa vive y funciona, y á su vez la célula regulariza, armoniza las funciones, para la mejor conservacion del organismo.

La célula nerviosa permanece en estado de salud mientras el trabajo intelectual, el físico y el alimento son proporcionados á su poder; desde que éstos son excesivos, la célula nerviosa enferma; el funcionamiento de las vísceras, la nutricion se perturban, la salud se altera y la muerte puede sobrevenir. Entonces la fuerza vital imprimida al sér se agotará antes de tiempo y la vida se hará imposible. Para hacerla durar, para conservar la salud, para restablecer la célula nerviosa que sufre, el primer lugar pertenece á la higiene, de ella depende la curacion de las enfermedades; en segunda línea viene el medicamento, que ha intentado suplantar á la higiene; su accion es limitada en ese mun-

do inmenso que se llama organismo humano; mal aplicado, agrava el mal en vez de disminuirlo.

La cuestion de la neurosis que trato en esta obra, hará conocer el papel que hace la célula nerviosa enferma, irritada. El conocimiento del papel que tiene el sistema nervioso en la patología modificará profundamente, así lo espero, en provecho del enfermo, la enseñanza de la ciencia médica actual, tan vaga, tan incierta y tan llena de errores; este conocimiento traerá á la higiene nuevos datos de que carece completamente, y hará comprender al médico cómo y en qué casos podrá hacer uso de medicamentos.

He resumido la cuestion tanto como me ha sido posible para presentarla en toda su sencillez, con toda claridad.

LA NEUROSIS

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

CLÍNICA

Neurosis.—Definicion.

La neurosis es una enfermedad del sistema nervioso causada por la irritacion de las células nerviosas; esta irritacion se trasmite siempre de un centro nervioso á las células nerviosas de los otros centros y á todos los nervios de las vísceras, de la piel, de las mucosas, de los músculos, de las articulaciones.

La neurosis tiene una evolucion regular, empieza en el niño y puede durar toda

la vida, tanto tiempo como la célula esté irritada.

La neurosis se compone de todos los síntomas de los centros nerviosos irritados y de un gran número de enfermedades debidas á la irritacion de la célula nerviosa. Estas enfermedades han sido observadas por los clínicos, que no comprendiendo sus causas y considerándolas extrañas unas á otras, las han diseminado en la patología clásica. El estudio de la neurosis será una síntesis patológica que pondrá al médico en condiciones de comprender y de curar muchas afecciones, en presencia de las que ha sido impotente hasta aquí.

Cullen creó el término neurosis para separar las enfermedades sin lesiones de las enfermedades con lesiones, dividiendo la ciencia médica en dos partes, compuesta la una de las neurosis ó enfermedades sin lesiones y la otra de todas las afecciones caracterizadas por lesiones orgánicas.

La primera parte constituyó la neurología, ciencia vastísima que encierra todas las afecciones de los nervios de la sensibilidad y del movimiento, las del órgano de la inteligencia y las de los nervios de las vísceras, de las mucosas, etc. La segunda

parte se compuso de las flegmasías, hidropesías, etc.

Al separar el estudio de los nervios del de los tejidos, aquel autor separó el estudio de las causas del de los efectos producidos, la lesion, y admitiendo la anatomía patológica como base de las grandes clasificaciones, toda la patología se oscureció con nuevas divisiones.

Cullen pensó dar grandes luces á la ciencia médica con el término neurosis, y por el contrario la embrolló completamente; en vez de hacerla progresar, la detuvo en su desarrollo. La anatomía patológica monopolizó, por decirlo así, la medicina, y á pesar de los grandes servicios prestados á la ciencia, perjudicó á la clínica desde el día en que pretendió ser la base única del tratamiento de las enfermedades. Algunos ejemplos bastarán para demostrarlo.

Los centros nerviosos irritados son los que producen la congestion patológica de las mucosas; así, la irritacion del plexo solar engendra la dispepsia ó la congestion patológica de la mucosa estomacal. Los patólogos, sirviéndose de la idea de Cullen, han creido que podian separar los fenóme-

nos nerviosos que se refieren al estómago de los que pertenecen á la mucosa y han incorporado la gastralgia á la neurología; y la gastritis, el catarro gástrico, la úlcera, la dilatacion, afecciones con lesion, han sido reunidas á otro grupo. La gastritis, el catarro del estómago, la úlcera, la dilatacion, afecciones provocadas todas por el plexo solar, vienen á ser enfermedades distintas, aisladas, independientes; de tal suerte que los síntomas nerviosos del estómago son descritos en la neurología, y la gastritis, el catarro del estómago, etc., se cuentan en el grupo de flegmasías de las mucosas, de las vísceras.

Estas divisiones de Cullen muestran que no conocia la irritacion de los centros nerviosos, ni su accion sobre los nervios y los tejidos, y que veia una enfermedad en los síntomas de los nervios y otra en la víscera lesionada.

¿De qué modo puede el médico, en presencia del estómago enfermo, dirigir una medicacion, curar á un enfermo con estos datos del autor inglés, que han sido sin embargo la base de toda clasificacion patológica?

Los centros nerviosos son causa de las

lesiones. Cullen estudia á parte el sistema nervioso, es decir, la neurología, que no comprende más que los fenómenos de los nervios, y no se preocupa de los centros nerviosos que son causa de todos los sufrimientos de los nervios así como de su accion fisiológica. La patología ha descuidado completamente los centros nerviosos que mantienen la salud y provocan la enfermedad con lesion de las vísceras.

Cullen atribuye á la anatomía patológica el conocimiento del órgano alterado en su estructura; y esta misma anatomía patológica hará la descripcion de enfermedades en que no se tratará para nada de los centros.

Este desmembramiento de la patología tuvo consecuencias desastrosas; la ciencia ha sido desfigurada; la evolucion de la enfermedad, incomprensible, obliga al médico á combatirla á pesar de su interpretacion errónea.

Esto, que es cierto para el estómago, lo es igualmente para las otras vísceras, para el intestino grueso por ejemplo.

Del mismo modo que el estómago funciona por el plexo solar, el intestino grueso funciona gracias á dos centros nervio-

sos que he descrito en mi libro *Estómago y cerebro*, ganglios del gran simpático, situados simétricamente á seis centímetros del ombligo sobre una línea horizontal que pasa por éste.

Gracias á estos centros, la mucosa del intestino grueso funciona normalmente, las materias fecales se elaboran y son expulsadas, al mismo tiempo que conservan íntegra la estructura de la mucosa, la contractilidad de las fibras musculares, etc.; pero en cuanto se irritan se ponen dolorosos, la elaboracion de las materias se hace defectuosa, la mucosa se altera, se congestiona patológicamente y con el tiempo pueden producirse lesiones. El cólico no ha podido ser nunca comprendido ni definido, porque no se conocian estos centros nerviosos. El cólico consiste en el dolor producido por el centro nervioso mismo, complicado ó no con el dolor debido á las contracciones de la fibra muscular del intestino. Ahora bien, los neurólogos han descrito una enteralgia y los anátomo-patólogos se han apoderado de la mucosa, la han observado y han descrito otra enfermedad, la enteritis, una flegmasia.

¿Cuán embarazosa no será la situacion

del médico práctico? No puede comprender el estado patológico de la mucosa si el centro nervioso le es desconocido; gasta el tiempo en discutir si hay gastralgia ó gastritis, enteralgia ó enteritis, y el enfermo, que conoce ya la terminología médica, pregunta si hay gastralgia ó gastritis. Esto me sucede á menudo y me turba bastante, y respondo que seria largo definir la enfermedad; porque en efecto, no hay ni gastralgia ni gastritis: estas divisiones son erróneas; no hay enteralgia ni enteritis: hay centros nerviosos, sin cuya intervencion ni el estómago ni el intestino grueso funcionarian. Si estos centros se irritan, aquellos órganos enferman; cuando los primeros vuelven al estado fisiológico, estómago é intestino grueso se curan. Así, pues, la gran division en enfermedades sin lesion y con lesion no tiene razon de ser y ha falseado la patología, poniendo al terapeuta en la imposibilidad de asistir racionalmente á un enfermo.

La mayor parte de las enfermedades de la piel, eczema, urticaria, acné, etc., son provocadas por la irritacion de los centros nerviosos, como demostraré en este libro; lo mismo pasa con la angina glandulosa,

el coriza, las hemorragias, los flujos. El médico podrá curar las enfermedades de la piel con pomadas, pero dichas enfermedades reaparecerán tan pronto como los centros sean irritados nuevamente: con pulverizaciones se podrá disminuir, calmar la angina glandulosa; la ergotina detendrá las hemorragias, pero el médico no podrá entrever por esta patología que ha separado el sistema nervioso de las enfermedades de la piel, de las mucosas, etc., el por qué éstas se reproducen. Sumamente indeciso en cuanto á su naturaleza, trata un síntoma pero no una enfermedad.

Las investigaciones de la anatomía patológica han sido de gran utilidad para hacernos conocer la lesion local; han seguido el movimiento científico que imprimió Cullen dándonos á conocer un lado de la enfermedad, mas no el mal en su patogénia, en su orígen, y de ahí resulta que el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades es empírico, incierto y que el esfuerzo del práctico más concienzudo queda frustrado con harta frecuencia.

CAPÍTULO II

FISIOLOGÍA PATOLÓGICA

Centros nerviosos: cerebro, médula, gran simpático

El sistema nervioso se compone de tres centros: cerebro, médula y gran simpático, y está encargado de las funciones de relacion, de reproduccion y de nutricion, manteniendo además la actividad de todo el organismo.

Cada centro tiene una funcion distinta: el cerebro compone las percepciones, las ideas, con los fenómenos sensitivos; órgano de la inteligencia, de la sensibilidad y de la voluntad, en él reside el *yo*, el alma humana.

La médula le trasmite las impresiones de los nervios sensitivos; agente principal

de los actos reflejos, de la médula emanan los nervios del gran simpático.

El gran simpático está constituido por ganglios nerviosos diseminados en las cavidades esplánicas, y envía nervios á las vísceras y á los vasos.

Los tres centros están intimamente unidos entre sí; la clínica nos demostrará que cada uno de ellos tiene cierto grado de autonomía funcional: médula y gran simpático dependen del cerebro y mantienen, gracias á éste, su nerviosidad respectiva; pero las células de la médula, como las del gran simpático, crean tambien influjo nervioso.

Cada centro crea, por sus células, influjo nervioso, y por tanto posee una autonomía funcional. Fácil es comprender que esos centros deban influir recíprocamente y obrar uno sobre otro, que el cerebro influya sobre la médula ó el gran simpático y que, recíprocamente, médula y gran simpático influyan sobre el cerebro.

La clínica nos mostrará que si uno de los centros, médula ó gran simpático, es lastimado primero, el cerebro se resentirá siempre, se irritará: estos datos generales deducidos de la observacion, enseñan que

tan pronto como un centro nervioso se irrita todo el sistema nervioso se perturba; que la irritacion de un solo centro bastará para producir dolencias en todos los nervios, sin que para esto sea necesario invocar una disposicion morbosa, una diátesis cualquiera.

Bichat estaba en un error al pensar que el gran simpático era un sistema enteramente independiente y que el plexo solar era el cerebro de ese sistema aislado del resto del sistema nervioso.

He hablado más arriba de la irritacion del cerebro, de la de la médula ó del gran simpático. ¿Cuál es el sentido de esta palabra: irritacion de la célula de un centro nervioso? Los fisiólogos admiten generalmente que la célula nerviosa no es excitable, no es irritable y que su funcion consiste en recibir la impresion del nervio centrípeto ó nervio sensitivo para trasmitirla al nervio centrífugo ó motor que hará contraer al músculo. La prueba que han dado los experimentadores en apoyo de esta idea es que una corriente eléctrica, ó un agente químico aplicado á la célula, no hace contraer al músculo, no excita el nervio motor; la célula es de cierto modo pasiva.

El estudio clínico pondrá en evidencia que toda actividad nerviosa radica en la célula, que crea todas las especies de neuralgias de los nervios periféricos y de los viscerales. Al recibir las impresiones de los nervios sensitivos, la célula se irrita tan pronto como la impresion excede cierto grado de intensidad; la célula duele y se manifiesta por un cierto número de síntomas que varian segun el centro herido, produciendo tambien dolor en los nervios que en ella se terminan. El nervio es sólo un hilo conductor que sirve á trasmitir las diversas especies de impresiones á los centros y enferma cuando la célula nerviosa se irrita. Es un agente pasivo al servicio de la célula é influido por ella que recibe la impresion ora del mundo exterior, ora del organismo. Mientras la impresion es poco intensa, la célula y el nervio *no se sienten*; pero el resultado es otro cuando la impresion es violenta: entonces ambos *duelen* simultánea ó separadamente.

Hasta aquí, los experimentadores no han reconocido al nervio sensitivo más que una accion centrípeta destinada á conmover al nervio motor por el intermedio de la célula. ¿El nervio sensitivo no es real-

mente más que un nervio centrípeto, y el motor un nervio centrífugo destinado á hacer contraer al músculo? ¿La fisiología entera del sistema nervioso consiste sólo en el acto reflejo, que es el movimiento comunicado á los músculos de los miembros, de las vísceras, de las glándulas por la célula impresionada por el nervio sensitivo? ¿El esfuerzo del sistema nervioso tiene sólo por resultado las contracciones musculares?

Experimentalmente sólo se puede observar el músculo; todos los fenómenos subjetivos escapan al método experimental: el papel que hace la célula no puede ser descubierto por el escalpelo, como tampoco el de los nervios sensitivos. La clínica demostrará que la célula de los centros nerviosos puede irritarse y trasmitir su irritacion á los otros centros; que esa irritacion no queda localizada en estos centros, sino que tiene siempre tendencia á volver al primero irritado y que de este modo los centros mantienen recíprocamente el estado de irritacion. ¿Cómo se hace la trasmision? Por los nervios sensitivos llamados centrípetos; el nervio centrípeto que lleva la impresion la trae, pues, al primer centro, sirviendo de union entre los dos.

Voy á citar algunos ejemplos que se presentan diariamente á la observacion del médico.

En cuanto el plexo solar manifiesta dolor á la presion está fuertemente irritado, la médula se irrita en una de sus regiones, cervical, dorsal, lumbar ó coxígea, en el trayecto de una ó más vértebras, algunas veces en toda su extension; el médico no tiene más que palpar la columna vertebral para asegurarse de que la presion que ejerce sobre la piel de dicha columna es dolorosa. Esta hiperestesia de la columna se acompaña á menudo del dolor de algunos nervios cervicales, dorsales, lumbares ó coxígeos, ó de la hiperestesia de los músculos, de la piel de una de las regiones de la columna vertebral. Cuando el plexo solar se calma, la médula se calma tambien; los dolores de la columna vertebral, de los nervios, de los músculos, de la piel disminuyen, y todo desaparece cuando el plexo solar ha vuelto á su estado normal. Este es un hecho en extremo comun, que nos muestra la influencia del plexo sobre la médula; la célula del plexo ocasiona dolor en la de la médula y ésta á su vez produce dolor en los nervios periféricos de la

piel y de los músculos. La accion del plexo sobre la médula se ejerce por los nervios sensitivos del plexo solar que van á aquélla: la raquialgia, á quien los neurólogos se han esforzado en descubrir una anatomía patológica, no es para mí más que una irritacion de la célula medular.

Si la célula de la médula se irrita la primera, ó duele por un motivo cualquiera, el médico encontrará con la mayor frecuencia que el plexo solar es doloroso y no cesará de serlo hasta que la célula de la médula no se haya calmado.

Cuando la célula cerebral se irrita á causa de una gran emocion ó de un trabajo excesivo, no permanece irritada exclusivamente: la médula y el plexo, ó sólo éste, se irritarán consecutivamente, del mismo modo que el plexo irritado causará la irritacion de la célula cerebral. La emocion comunicada al *yo* consciente por el nervio auditivo produce uno de los síntomas que caracterizan la irritacion de la célula cerebral, el dolor de cabeza, el vértigo ó un aturdimiento: la célula cerebral perturba la célula del plexo por medio de sus cordones de comunicacion, los nervios sensitivos.

Estos diferentes hechos hacen comprender el papel de la célula dejada en la oscuridad hasta aquí; el del nervio sensitivo, que no es sólo un nervio centrípeto, sino que reune todos los centros, asegurando así la unidad del sistema nervioso que la fisiología experimental no nos deja entrever; estos hechos nos demuestran tambien que el acto reflejo no es más que uno de los lados de la funcion compleja del sistema nervioso.

Los neurólogos, que no han conocido el papel activo de la célula en las neuralgias de los nervios periféricos, viscerales, de la piel, de las mucosas, de los vasos, se perdian en ese dédalo de neurosis ligadas todas entre sí y evocadas sucesivamente por la irritacion de los centros. De suerte que han escrito la historia de cada nervio en particular, enumerado sus síntomas, sin seguir otro órden más que el anatómico, creando tantas entidades morbosas como nervios, no pudiendo por tanto comprender ni la etiología ni la terapéutica. No buscaban la causa del padecimiento de los nervios en el sistema nervioso mismo, sino que la atribuian á la sangre, á la anemia ó á una diátesis cualquiera, artritismo,

herpetismo. Entregados á todas las incertidumbres que engendra la falta de patogenia, su terapéutica se dirigia, no á los centros nerviosos, sino á la sangre que no es más que la víctima de los desórdenes de éstos ó á diátesis misteriosas sobre quienes no obraba el medicamento.

La neurología ha sido compuesta por una reunion de hechos nerviosos aislados, separados unos de otros. El orígen de todos es la irritacion de la célula, y si se sustituyen fatalmente, es porque la irritacion afecta sucesivamente á todos los centros. Todos los nervios dependen de los centros de que emanan, sufren por ellos y no se curan sino por el intermedio de estos centros.

Los neurólogos han descrito tantas neurosis como nervios hay; en realidad no hay más que una sola, que empieza, ya por el cerebro, ya por la médula ó por el gran simpático, que se extiende á todo el sistema nervioso y que no cura sino con la condicion que los tres centros recuperen su equilibrio y no *vuelvan á sentirse.*

A esta neurosis habia propuesto yo llamar enfermedad *cerebro-gástrica;* esta denominacion es insuficiente, y no designa la

participacion de los tres centros, pero poco importa el término: el de neurosis, más vago, me parece más adecuado.

Las explicaciones que acabo de dar indican la complejidad fenomenal de la neurosis, que comprende los síntomas de los centros irritados, los de los nervios sensitivos y motores, así como de los nervios viscerales y de las vísceras mismas perturbadas, las alteraciones de la sangre, etc.

La neurosis produce la dispepsia, la clorosis, la gota, el reuma, la albuminuria, la diabetes, la obesidad y el enflaquecimiento, desórdenes múltiples de la nutricion. La cuestion es en extremo vasta, y comprende una gran parte de la patología humana.

Aunque me ocuparé de cada una de estas afecciones causadas todas por la neurosis, me propongo ser tan breve como me sea posible para no fatigar al lector; pero no podré omitir ninguna de ellas sin exponerme á faltar á la exactitud clínica. Cada una de estas cuestiones necesitaria un volúmen: me limitaré, sin embargo, á mostrar cómo interviene el sistema nervioso en la produccion de esas diferentes

enfermedades, pues sólo de él dependen. Emplearé todos mis esfuerzos en hacer ver esas relaciones, dando así al sistema nervioso el lugar que debe ocupar en patología.

CAPITULO III

ETIOLOGÍA DE LA NEUROSIS

La etiología de la neurosis, que no es otra cosa más que la etiología de la irritacion de los centros, comprende todas las causas capaces de irritar el cerebro, la médula ó el gran simpático. A propósito del gran simpático estudiaré en especial el plexo solar, que resume las impresiones de los ganglios torácicos y abdominales, y los tres ganglios nerviosos periumbilicales que he hecho conocer en mi libro *Estómago y cerebro.*

Cada uno de los centros puede ser irritado primitivamente y trasmitir la irritacion á los otros centros; pero con la mayor frecuencia la neurosis tiene su orígen en el cerebro. Este es el primero atacado y el

que engendra luego los desórdenes del resto del sistema nervioso.

La etiología de la irritacion cerebral merece, pues, el primer lugar.

Irritaciones del cerebro.

1.° *Cerebro.*—La irritacion cerebral puede ser determinada directa ó indirectamente por el intermedio de la médula ó del sistema nervioso abdominal, y es primitiva en la mayor parte de los casos.

La cuestion etiológica está dominada por un hecho, la herencia. Padres bien equilibrados bajo el punto de vista del sistema nervioso, que tienen un cerebro vigoroso, engendran hijos con un sistema nervioso vigoroso tambien. Los padres nerviosos imprimen este sello á su progenitura: sus niños tienen un cerebro fácilmente irritable; pero frecuentemente la irritacion cerebral es provocada por la mala higiene, y puede empezar en cualquier período de la vida en el adulto, en el anciano, así como en el tierno niño.

El cerebro está sometido á un trabajo colosal, recibiendo día y noche todas las impresiones del mundo exterior y del organismo, y componiendo con esas impresiones las facultades del *yo* consciente por las que siente, piensa y quiere. El cerebro

no tiene reposo, en lo que concierne al mundo exterior, más que durante la noche; pero durante el sueño está ocupado por las sensaciones que le envia cada parte del cuerpo. Este trabajo empieza al nacer y no concluye hasta la muerte.

El *yo* no siente su cerebro mientras la célula no está sobrecargada por las operaciones sinnúmero que le incumben; pero tan pronto como la medida ha sido excedida la célula se hace sensible, dolorosa, y se manifiesta por síntomas que indicaremos más adelante.

Trabajo intelectual y físico.

La tolerancia de la célula varia segun el individuo; es poca en el niño y aumenta á medida que el cerebro se desarrolla, pero no llega á su *máximum* hasta la edad de veinte años, cuando el órgano ha adquirido su completo desenvolvimiento. A esta edad sólo debe empezar el trabajo serio, continuo, perseverante; antes, el cerebro no soporta más que esfuerzos moderados. Nuestros legisladores no han tenido en cuenta la organizacion cerebral al someter todos los niños á exámenes, oposiciones y pruebas sinnúmero que excitan el cerebro y lo perturban; y más sensible es aún que el mismo régimen intelectual se imponga

á las niñas, cuyo sistema nervioso es mucho más impresionable y que estarán más tarde tan expuestas á la neurosis por la menstruacion.

Disgustos, pasiones.

En toda edad, las decepciones, los disgustos, las zozobras de la lucha por la existencia, son causas de irritacion cerebral; lo mismo sucede con las fatigas físicas excesivas que necesitan la intervencion de la voluntad y con los golpes violentos recibidos sobre el cráneo.

Tal es la etiología directa de la irritacion cerebral resumida lo más brevemente posible, tal la irritacion primitiva. La irritacion puede, sin embargo, llegar á menudo al cerebro consecutivamente por la médula ó por el plexo solar: los alimentos, las bebidas que irritan al plexo, determinan la irritacion secundaria del cerebro. Pasaré en revista todos los agentes capaces de molestar al plexo solar.

Irritacion de la médula

2.° *Médula espinal.*—La célula de la médula se irrita por la fatiga muscular de los miembros superiores ó inferiores que entran en juego en todos los ejercicios musculares. La estacion de pie prolongada, las marchas no proporcionadas á la tolerancia de la célula de la médula, engendran

Fatigas musculares.

la raquialgia. Cada semana veo llegar á mi hospital jornaleros y criados afectados de la neurosis, que ha empezado por la médula.

He tenido en el hospital este año al criado de una farmacia, de edad de diez y ocho años, que habia salido de su pueblo, en Alsacia, hacia un año; desde esa época permanecia de pie desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche; á su entrada en el hospital se quejaba de dolores de cabeza intolerables, vértigos, zumbido de oídos, insomnios, dolores en la parte inferior de la columna vertebral; el plexo solar y los ganglios nerviosos periumbilicales acusaban una sensibilidad exagerada por la presion, la piel y los músculos presentaban una hiperestesia considerable; el apetito era nulo, la sed intensa; el enfermo, en suma, ofrecia todos los signos de la fiebre tifoidea; la temperatura, sin embargo, no pasaba de 37°. La neurosis, en efecto, se asemeja con frecuencia á la fiebre tifoidea, y el termómetro sólo permite establecer el diagnóstico. El enfermo no se restableció hasta despues de dos meses de tratamiento.

En los tiernos niños, cuyo sistema ner-

vioso es tan delicado y susceptible, hay que temer sobre todo los excesos musculares; las madres jóvenes é inexperimentadas creen deber pasear todos los dias durante largas horas sus tiernos niños, y con frecuencia éstos sufren ataques febriles y presentan desórdenes digestivos y lasitud, que son la expresion de disturbios en los centros nerviosos.

Irritacion del plexo.

3.° *Plexo solar.*—El plexo solar se irrita directamente por las sustancias introducidas en el estómago intempestivamente, alimentos, bebidas, medicamentos; pero la irritacion del plexo está siempre subordinada á la irritabilidad del cerebro: si el cerebro está bien equilibrado, el plexo presenta gran tolerancia; cuando, por el contrario, aquél es poco resistente, el plexo se irrita con la mayor facilidad. Esto nos explica que si el sistema nervioso del individuo es vigoroso, éste soportará toda especie de alimentos, de bebidas sin volverse dispéptico; pero si el individuo es muy impresionable, la dispepsia se establece fácilmente. Muchos individuos nacidos con un fuerte temperamento, muy resistentes, llegan, por exceso de alimentos y de bebidas, á crear la dispepsia y la neurosis como

Alimentos, bebidas, medicamentos.

consecuencia; en ese caso el cerebro es víctima del plexo.

Relacion entre el cerebro y el plexo solar.

La subordinacion del plexo solar al cerebro, observada diariamente por mí, puede ser demostrada por una experiencia patológica en el perro.

Doy á un perro, junto con 200 gramos de carne, 75 gramos de aguardiente; el perro se embriaga, titubea, el cerebro queda anonadado por esta dosis de alcohol; sacrificado cinco horas despues, encuentro la carne intacta en el estómago: ninguna digestion ha tenido lugar; la mucosa gástrica está roja y contiene 160 gramos de un líquido ácido que no tiene ningun poder digestivo. El plexo ha sido excitado directamente por el aguardiente é indirectamente por el cerebro: en estas condiciones su funcion ha sido suprimida. El plexo solar determina la congestion fisiológica de la mucosa, preside á la secrecion del jugo gástrico y el alimento se digiere; en el caso que nos ocupa no hemos encontrado jugo gástrico y la carne no ha sido modificada.

Otros son los fenómenos que se observan cuando, disminuyendo la dosis de aguardiente, doy 25 gramos solamente: la into-

xicacion general no tiene lugar, y sólo sí una accion irritante localizada en el plexo.

Un perro que recibe con 200 gramos de carne 25 gramos de aguardiente, no contiene en su estómago más que 50 gramos de carne cinco horas despues: 150 gramos han sido digeridos; el aguardiente ha contribuido á la digestion, pero activándola en extremo, puesto que la mucosa no presenta el color rosado que debia tener, sino que está roja á trechos é inyectada al exceso; la mucosa está enferma: la dispepsia está constituida.

El plexo solar soporta sólo cierto grado de excitacion que trae consigo cierto grado de congestion de la mucosa, pasado el cual el plexo padece y la mucosa enferma.

Pasemos en revista las causas múltiples de irritacion del plexo solar. Esta irritacion puede ser producida independientemente de las sustancias introducidas en el estómago: así, un golpe dado sobre la region del epigastrio la ocasiona. La inclinacion del tronco largo tiempo continuada á que obligan ciertos oficios, el trabajo de oficina, la profesion de sastre, de zapatero, de costurera, es causa frecuente de dispepsia.

Insistiré especialmente sobre la cuestion que más interesa al médico: el alimento, la bebida, el medicamento.

Alimentos.

Parece á muchas personas que el estómago es un órgano esencialmente caprichoso y que varia en sus susceptibilidades con cada individuo; nada hay de más erróneo. En todos el plexo solar está sujeto á ciertas reglas de régimen, de higiene, uniformes para todos; pero estas reglas varian segun la edad, segun las disposiciones morales del individuo, y esto se explica fácilmente, porque la funcion del estómago no es aislada, sino que depende constantemente del estado del cerebro. En el niño cuyo cerebro es sumamente impresionable el plexo lo es igualmente; el individuo dotado de un buen estómago no podrá soportar el alimento menos indigesto el dia en que tenga una viva preocupacion, un disgusto. El estómago puede sólo parecer raro al que ignora su dependencia del cerebro.

Carne.

Durante los primeros años de la vida, la fibra muscular de la carne, que tiene la propiedad singular de excitar más el plexo que todas las otras sustancias de igual composicion química (guisantes, alubias,

lentejas), determina fácilmente la irritacion del plexo solar y del cerebro; la carne engendra ó agrava el estado nervioso del niño. La fibra muscular del pescado es menos dañina.

Leche. Los líquidos que no son irritantes por sí mismos (leche, sopas), y que son exclusivamente tolerados en el primer año de la vida, son causa de dispepsia á partir de dos años si se les emplea únicamente, y esto porque el plexo exige cierto grado de excitacion para conservar sus propiedades fisiológicas: los líquidos no le dan esa excitacion y la carne en exceso la exagera. El médico debe, pues, conocer las reglas de la alimentacion, de que la higiene no nos ha dado ninguna idea precisa hasta hoy por no haber tenido cuenta del sistema nervioso.

Hay alimentos que contienen principios irritantes, aceites esenciales, como por ejemplo la col, la seta, que pueden ser causa de irritacion directa; pero hay otras sustancias que sin contener ningun principio nocivo (la carne) determinan la irritacion por su uso reiterado. Estos dos puntos deben estar siempre presentes á la mente del terapeuta: no es la composicion

sola del alimento la que debe fijar la atencion; los hay muy indigestos que son aceptados una ó dos veces sin producir ningun desórden, pero cuyo empleo al tercero ó cuarto día ocasionará accidentes múltiples, fiebre, vómitos, diarrea, que extrañan siempre al enfermo por haber sido necesario introducirlos repetidas veces en el estómago para exceder la sensibilidad del plexo.

Bebidas.

Todas las bebidas fermentadas conteniendo alcohol son mucho más temibles para el plexo y el estómago que los alimentos, pues pueden producir siempre la dispepsia, sea cualquiera la cantidad consumida, cuando se trata sobre todo de un individuo nervioso. El alcohol es una de las sustancias que más ha desorganizado el sistema nervioso en nuestra época. ¿A qué dosis no es tóxico? Nadie lo sabe. ¿Qué cantidad de vino, de cerveza, de licor, será soportada por el organismo? Tampoco se sabe. El estómago de muchos individuos puede escapar á su accion nociva, pero el hígado, el corazon, el cerebro ó el riñon enferman y matan. Hay sujetos que abusando del alcohol no tienen temblor alcohólico, ni alucinaciones alcohólicas, ni de-

lirio y que súbitamente son atacados de una endocarditis, de cirrosis, de albuminuria ó de tuberculosis, cuya causa queda ignorada con frecuencia. Recuerdo individuos que bebian una botella de vino en cada comida y se felicitaban del buen efecto sobre su organismo, arrebatados en cuarenta y ocho horas por una apoplejía fulminante á la edad de cincuenta ó sesenta años.

Las bebidas fermentadas irritan al plexo solar y consecutivamente al plexo nervioso lumbo-aórtico que preside á las funciones de los órganos genitales: así, en los niños, excitan prematuramente estos órganos, los despiertan antes de tiempo llevándolos á excesos de todo género.

A la excitacion de los órganos genitales sucede su adormecimiento. He prestado mi asistencia á jóvenes de veinte años que, dispépticos, no sentian deseos genésicos. Éstos no reaparecen hasta que el plexo solar se calma. La irritacion del plexo solar los exagera ó los suprime.

Las bebidas fermentadas excitan al cerebro y á la excitacion sucede la depresion, acabando por anular las facultades intelectuales.

Las bebidas alcohólicas obran sobre el organismo, del mismo modo que el opio de que hacen uso los chinos, intoxicando al hombre.

A principios de este siglo el jornalero estaba poco habituado á consumir estas bebidas; mas cuando le fué necesario producir mayor cantidad de trabajo á causa de la carestía creciente de la vida, empezó á consumir toda especie de bebidas alcoholizadas.

El abuso del alcohol ha contribuido mucho á la depresion de las inteligencias y de los caractéres: nuestros ascendientes, cuyo sistema nervioso era robusto, podian resistirle. Si el hábito de las bebidas fermentadas no se combate vigorosamente, si no se suprime en los niños, á quienes no hará más que dañar, la degeneracion humana irá en aumento.

Pero se ha dicho que estas bebidas son necesarias en ciertos climas, en Rusia, en Holanda, en Inglaterra, en los climas frios y húmedos. ¿Cuál puede ser su utilidad? Sirven sólo á mantener la temperatura del cuerpo á 37°; ahora bien, todos los alimentos llegan al mismo resultado. Si se desea una bebida estimulante, el café, el té, re-

emplazarán con ventaja á las bebidas fermentadas: el café y el té no hacen daño al estómago, no irritan el plexo, estimulan las facultades intelectuales sin deprimirlas y no destruyen los tejidos del organismo.

Lo singular es que haya médicos que aconsejen vino á la mujer y le prohiban el café con leche; he tenido numerosas ocasiones de combatir este error. El café con leche es bien ajeno á los disturbios que se le imputan y no es nunca nocivo, mientras que el vino no les es nunca provechoso.

Las bebidas fermentadas tomadas como aperitivos no sirven más que á suprimir el apetito, las que se aconsejan como tónicas sirven sólo á perturbar el sistema nervioso.

Los líquidos, cualesquiera que éstos sean, agua, café, té, tomados á la dosis de cuatro ó cinco vasos, son causa de irritacion del plexo; el estómago no acepta una gran cantidad de líquido que reblandece la mucosa y el plexo. El dispéptico tiene generalmente una sed ardiente, si la satisface conserva la dispepsia. La cantidad máxima de bebida tolerada es de dos vasos de líquido; esto es sobre todo exacto cuando el régimen alimenticio se compone de

alimentos sólidos, porque los individuos alimentados exclusivamente con leche llegan á absorber muchos litros; pero este régimen continuado más allá de tres semanas es nocivo al estómago. El abuso de bebidas heladas irrita al plexo y lo mismo sucede con la bebida muy caliente, hirviendo; el órgano necesita una temperatura que se acerque á la suya en el estado fisiológico.

Algunos médicos prohiben toda bebida al dispéptico que tiene un estómago dilatado; esta prohibicion es en extremo penosa y no está fundada en ninguna razon séria; el dispéptico puede siempre ingerir en cada comida la cantidad de líquido más arriba indicada, con la condicion que este líquido no sea irritante.

Medicamentos.—El estudio de los medicamentos ha sido hecho sin conocimiento de la fisiología del estómago, de la fisiología de la digestion. Más arriba he demostrado que la digestion depende de una estimulacion del plexo solar, estimulacion que no debe exceder cierto grado so pena de irritar el plexo y alterar la mucosa del estómago. Si la digestion es demasiado precipitada, demasiado apresurada, será

Medicamentos.

imperfecta en lo sucesivo; su premura lleva consigo la enfermedad del estómago. Así, pues, 25 gramos de aguardiente mezclados con 200 gramos de carne hacen digerir ésta rápidamente y dejan la mucosa enferma.

La mayor parte de los medicamentos tienen la misma accion, excitar al plexo más que conviniera; precipitan la digestion, pero á expensas del estómago que sufre. Los terapeutas no han tenido cuenta del plexo solar y de sus propiedades, y se han ilusionado con la actividad que ciertas sustancias dan á la digestion.

En una retorta, la pepsina, la papaína precipitan la digestion de la fibrina, de la albúmina y las disuelven rápidamente; ¿pero quiere esto decir acaso que sea útil introducirlas en el estómago?

He experimentado sobre un gran número de medicamentos, y hé aquí el resultado de mis observaciones: 200 gramos de carne mezclados con 2 gramos de pepsina son administrados á un perro en ayunas, y éste es sacrificado cinco horas despues.

Pepsina.

A las cinco horas el estómago no encierra más que 70 gramos, en vez de 130 que contendria si la carne hubiera sido in-

gerida sola; la digestion ha sido precipitada y la mucosa está roja con exceso; esta membrana ha sufrido una alteracion que aumentará si se renueva el empleo de la pepsina, el estómago ha sufrido del medicamento.

Papaína.

Si se reemplaza la pepsina por 1 gramo de papaína, los fenómenos son aún más apreciables: los 200 gramos de carne son digeridos totalmente, la mucosa está excesivamente congestionada y contiene 196 gramos de líquido ácido, lo cual quiere decir que cierta cantidad de agua acidulada se ha extravasado en el estómago; este último fenómeno no tiene lugar más que en las grandes irritaciones del plexo: la carne ha sido digerida por completo, pero á expensas del órgano, que queda alterado.

La pepsina y la papaína facilitan evidentemente la digestion, pero crean la enfermedad. Los terapeutas al denominarlas sustancias eupépticas, es decir, que facilitan la digestion, se han dejado llevar por las apariencias sin comprender el sentido íntimo del hecho.

Extracto de quina, cuasia amara.

Lo mismo que con la pepsina y la papaína sucede con los amargos, extracto de quina, cuasia amara, sulfato de quinina.

Un gramo de extracto de quina hace digerir al perro en cinco horas los 200 gramos de carne; 6 gramos de cuasia amara hacen digerir en el mismo tiempo 136 gramos de 200; 25 centígramos de sulfato de quinina digieren 105 gramos de carne.

Sulfato de quinina.

Todas estas sustancias tienen la virtud de activar la digestion: el extracto de quina la facilita más que la cuasia amara; la cuasia amara tiene un efecto mayor que el sulfato de quinina. Si estos medicamentos son administrados muchos días consecutivos, la excitacion comunicada al plexo solar lo enfermará rápidamente.

Cuando se aconsejan los amargos á un individuo débil, la cuasia amara por ejemplo, es necesario tener presente que ésta, como los amargos en general, impide pronto la alimentacion del individuo cuyo organismo se trata de restablecer, y que los amargos facilitan la produccion de la dispepsia y no convienen más que á los estómagos vigorosos.

Todas las preparaciones ferruginosas que los médicos dirigen contra la clorosis tienen el mismo efecto.

La clorosis se complica ordinariamente de dispepsia y el hierro agrava ésta.

Hierro reducido.

Cincuenta centígramos de hierro reducido mezclados á 200 gramos de carne activan la digestion en el perro, y á las cinco horas el estómago no contiene más que 40 gramos en lugar de 130 gramos de carne que debian encontrarse.

El hierro administrado al clorótico irritará el plexo á los pocos días y le impedirá alimentarse; si la dispepsia complica la clorosis desde el principio, se agravará por el uso de las preparaciones ferruginosas. He debido generalmente suspender su uso á los dos ó tres días en las jóvenes cuyo estómago queria tantear; el hierro debe administrarse sólo en ligeras dosis, suprimiéndolo de vez en cuando algunos días.

Todas las sales alcalinas, todas las aguas alcalinas se asemejan á las sustancias que acabamos de estudiar por su accion fisiológica sobre el plexo solar.

Bicarbonato de sosa.

La digestion de la carne en el estómago del perro se activa con 4 gramos de bicarbonato de sosa, y á las cinco horas los 200 gramos de carne se han reducido á 87 gramos.

Trescientos gramos de agua de Vichy administrados á un perro en ayunas han determinado, veinte minutos despues, una

coloracion roja excesiva de la mucosa, al mismo tiempo que toda el agua ha desaparecido del estómago. Este líquido no obra solamente sobre el estómago, sino tambien sobre todas las vísceras abdominales; el hígado está congestionado y la vesícula llena de bilis fresca, el riñon está tambien congestionado, la vejiga está llena de orina. El agua de Vichy á altas dosis estimula, al par que al plexo solar, los centros nerviosos de todas las vísceras.

Agua de Vichy. El agua de Vichy administrada á la dosis de 150 gramos con 200 gramos de carne ha digerido, en el estómago del perro, 76 gramos de carne en el espacio de tres horas; la misma cantidad de carne ingerida sola se encuentra íntegra en el estómago tres horas despues. Si se dobla la cantidad de agua de Vichy, y se administran 300 gramos con la carne, ésta se reducirá á 40 gramos tres horas despues.

Agua de Carlsbad. El agua de Carlsbad produce el mismo efecto que el agua de Vichy. Las aguas alcalinas administradas á dosis crecientes precipitan progresivamente la digestion; pero ésta no puede ser activada impunemente sin comprometer al plexo solar.

Fácilmente se comprenderá que cuando

se trata de un dispéptico el agua alcalina, lejos de atenuar el mal, lo agrava por el contrario en el mayor número de casos. Este líquido debe emplearse con grandes precauciones y en dosis muy ligeras, pues tiene una accion modificante sobre la mucosa misma; es, pues, necesario vigilar atentamente su empleo y suspenderlo de tiempo en tiempo.

El agua alcalina no puede prestar servicios sino con la condicion de que el régimen alimenticio sea prudentemente establecido y tienda hácia el mismo fin, es decir, que no pueda aumentar la irritacion del plexo; de lo contrario, las aguas alcalinas, lejos de ser útiles, serán perniciosas al estómago.

Cuando el plexo solar está profundamente irritado, Vichy, Carlsbad, Vals y todos los alcalinos son igualmente peligrosos. Debo repetir, á propósito de las aguas arsenicales (La Bourboule), de las aguas sulfurosas (Eaux-Bonnes), de las aguas ferruginosas (Orezza), todo lo dicho sobre los medicamentos, pepsina, hierro, cuasia amara, sales alcalinas, aguas alcalinas. He experimentado cada una de esas aguas.

Agua de la Bourboule.

Ciento cincuenta gramos de agua de la Bourboule, administrados á un perro con 200 gramos de carne, le hacen digerir 130 gramos de ésta en cinco horas; la digestion ha sido precipitada, pero el animal ha sufrido, ha tenido náuseas y ha hecho esfuerzos para vomitar.

Aguas-Buenas.

Aguas-Buenas, á la dosis de 100 gramos, no hacen digerir más que 100 gramos de carne; digestion menos pronta que con el agua de la Bourboule, aunque más rápida que cuando la carne ha sido ingerida sola.

Todas tienen, pues, una propiedad uniforme, todas activan la digestion. ¿Pero se le ocurrirá á un médico instruido prescribir á un dispéptico agua de la Bourboule ó Aguas-Buenas, sabiendo de antemano que estas aguas no convienen aunque facilitan la digestion como los alcalinos?

La dispepsia no consiste, pues, en la no digestion de los alimentos; el alimento se digiere siempre, y si el estómago no llega á este resultado el intestino delgado lo digerirá. La dispepsia consiste en los padecimientos que determina el plexo irritado y en los síntomas que produce la mucosa estomacal tambien irritada. La dispepsia no se cura irritando al plexo, sino calmán-

dolo. El mayor número de nuestros medicamentos tienden á su irritacion, algunos solamente contribuyen á calmarlo; antes de señalar estos últimos debo decir algunas palabras sobre las aguas purgativas.

Purgativos.

Los purgantes han sido tan nocivos á la humanidad como las sangrías de Broussais. No hay un solo individuo que sintiendo su apetito un tanto disminuido, alguna fatiga muscular y observando su lengua cargada no se administre de su propia autoridad un purgante, agua de Huniady, Rubinat, Pulna, etc., y si no hace la prescripcion él mismo su médico no tarda en hacerla. Se abusa de los purgantes de un modo deplorable; todos son dañosos al organismo y no le son nunca de utilidad alguna. Los purgantes son la herencia del humorismo de Hipócrates, que creia que el organismo se cargaba de tiempo en tiempo de humores viciosos y que era conveniente limpiarlo de cuando en cuando. Además, cada individuo, con su instinto que le guia mal, cuando tiene náuseas ó vomita cierta cantidad de líquido estomacal, con ó sin bilis, ó pierde el gusto de los alimentos, se inclina á tomar una de esas

aguas que, dice, le librarán de dichos síntomas y le volverán á la salud.

Hé aquí una experiencia sobre el efecto del agua purgante. Un perro recibe con 200 gramos de carne 100 gramos de agua de Pulna, y es sacrificado cinco horas despues: 30 gramos de carne solamente han sido digeridos por el jugo gástrico que está aún encerrado en las glándulas de la mucosa, pero ésta no está rosada ni tiene el color que le da la carne; está, por el contrario, lívida, negra; la sangre contenida en los vasos está negra, asfíxica; el purgativo ha determinado una asfixia local debida á la irritacion del plexo solar. La diarrea producida por el purgativo es debida á la irritacion de los ganglios nerviosos periumbilicales: el purgativo irrita todo el sistema nervioso abdominal; la diarrea se produce con esta condicion, se compone de elementos de la sangre y no arrastra más que las materias contenidas en el intestino. El purgativo hace una sangría y nada más, pero con la condicion de haber perturbado los centros nerviosos del abdómen; esta perturbacion repercute en el resto del sistema nervioso. Tal es la accion de las sales purgantes. Este medica-

mento es causa de dispepsia y cuando se prescribe á un dispéptico el mal aumenta. Sólo algunas sales á pequeñas dosis no irritan al plexo, como el fosfato de cal á la dosis de 3 á 4 gramos, el sulfato de sosa á la dosis de 20 á 30 centígramos. Estas sales no precipitan la digestion de la carne en el perro, son toleradas por el dispéptico, pueden ser empleadas durante la enfermedad é influyen favorablemente sobre el estómago; lo mismo diremos del opio á la dosis de 1 centígramo. Difícil seria explicar su verdadera accion sobre el estómago, pero sabemos sólo que lo calman y le son provechosas. Diariamente puedo observar sus buenos efectos.

Fosfato de cal.

Sulfato de sosa.

No podríamos decir otro tanto de la estricnina que se emplea en el licor de Baumé; su uso es dañoso con frecuencia, sea porque excite la contraccion de las fibras musculares del estómago, ya excitadas por la dispepsia, sea por otro motivo que ignoramos. Esta sustancia es mal soportada, y cuando se soporta no es de ninguna utilidad para el enfermo: 1 centígramo de estricnina mezclado con 200 gramos de carne irrita la médula y el sistema nervioso abdominal del perro, que presenta convul-

siones y cuyo intestino delgado y estómago están contraidos. La digestion de la carne se ha efectuado cinco horas despues, como si ésta hubiera sido administrada sola; la estricnina obra, pues, sobre la fibra muscular del estómago sin intervenir en la secrecion del jugo gástrico.

Al escoger los remedios del estómago el médico no debe pensar en los que activan la digestion, que son todos nocivos, sino en aquellos que no irritan al plexo solar y que deben emplearse únicamente. Deben, pues, eliminarse las sales alcalinas á altas dosis, los amargos, las sustancias llamadas eupépticas y todas las preparaciones ferruginosas. En el caso de administrar una de estas sustancias, el médico debe vigilar diariamente sus efectos, pues frecuentemente los síntomas de intolerancia no se manifiestan hasta despues de algunos días. No hemos hablado hasta aquí del ioduro de potasio, de la copaiba, de la cubeba, del salicilato de sosa, de las preparaciones mercuriales, del aceite de hígado de bacalao, de la creosota, etc., sustancias todas intolerables á dosis un poco altas y que determinan la dispepsia. El médico que las prescribe, en vez de curar una enferme-

dad, se expone á provocar otra muy séria que está llamada á repercutir en todo el sistema nervioso. El facultativo comprenderá con qué precauciones los medicamentos deben administrarse al tuberculoso por ejemplo, en quien es necesario resguardar ante todo el tubo digestivo, y cuán circunspecto debe ser en el empleo de remedios que han sido aconsejados sin preocuparse del estómago. El terapeuta debe pensar siempre, antes de recomendar un medicamento, en el efecto que producirá sobre el estómago. Este órgano esencial deberá siempre ser protegido contra los efectos nocivos del mayor número de los remedios.

Despues de haberme detenido extensamente á investigar las causas de irritacion del plexo debidas á lo que se llama los *ingesta*, quédame aún por indicar rápidamente algunas causas de irritacion no debidas ya á los alimentos, á las bebidas, á los medicamentos, sino á vicios de masticacion, á la irregularidad en las horas de comer, á la lactacion.

Masticacion.

1.° *Masticacion.*—Una masticacion demasiado rápida, incompleta por denticion defectuosa, puede producir la dispepsia, que cederá el día en que el individuo se decida

á comer lentamente ó á servirse de dientes postizos con que pueda triturar los alimentos. La dispepsia no es debida, como se dice generalmente, á que el bolo alimenticio no está suficientemente impregnado de saliva; el papel de la saliva en la digestion es reducido, pero la masticacion rápida, la ausencia de dientes, permiten la llegada al estómago del alimento en masas demasiado considerables. Un trabajo excesivo se impone al plexo, que se hace doloroso.

Irregularidad en las horas de comer.

2.° *Irregularidad en las horas de comer.*—¿Por qué la irregularidad en las horas de comer es causa de irritacion del plexo?

La sensacion del hambre aparece todos los días á la misma hora, y casi en el mismo instante, mientras el plexo está en su estado fisiológico. Esta sensacion, que tiene su orígen en el plexo, debe ser satisfecha con un alimento cualquiera, y si no se satisface en cierto número de veces se apaga y no reaparece más. El plexo sufre por no haber recibido el estímulo de que tenia necesidad y se irrita.

Lactacion.—De 196 mujeres dispépticas 5 enfermaron á consecuencia de la lactacion; la dispepsia no es debida á la secrecion láctea, ni es tampoco una anemia

consecutiva á esta secrecion la que determina la enfermedad del estómago; las causas son múltiples: en primer lugar una nutricion aumentada en exceso y á la que la mujer no estaba acostumbrada, las bebidas fermentadas, vino, cerveza, etc., son las causas de la irritacion. El cerebro interviene á su vez y contribuye á la irritacion del plexo; los insomnios, las emociones maternas traen su contingente. La madre acaba por perder el apetito, por no comer, y se hace incapaz de continuar la lactacion: tal sucede en las ciudades á las madres jóvenes, nerviosas é inexperimentadas, que abrazan sus deberes maternos con demasiado ardor: con frecuencia éstas no pueden soportar el peso de sus deberes. La nodriza del campo, que no tiene otra preocupacion más que nutrirse bien para tener mucha leche, está preparada por una vigorosa constitucion, por un sistema nervioso tranquilo, sosegado, á las funciones maternas, que ejercerá con la mayor facilidad.

He indicado hasta aquí las principales causas directas de irritacion del plexo.

Causas indirectas de irritacion de los centros. –Entre las causas indirectas citare-

mos la fiebre y las diversas enfermedades de las vísceras abdominales y torácicas, etc.

La fiebre se acompaña siempre de irritacion del plexo, de dispepsia, de pérdida del apetito: la irritacion no se circunscribe solo al plexo solar, sino que se extiende al cerebro; por este motivo la fiebre se acompaña de dolor de cabeza, de vértigo, etc. Trataremos sólo del plexo solar por el momento.

Qué relacion existe entre la fiebre y el plexo solar? Hasta hoy no conocemos la fiebre más que por los cambios de temperatura y las modificaciones que sobrevienen en las eliminaciones del organismo. Lo que hay de cierto es que el sistema nervioso no es ajeno á su produccion, pero ignoramos de qué modo interviene. No sólo la fiebre sencilla, sino todas las enfermedades con fiebre, fiebres eruptivas, fiebre tifoidea, etc., irritan al centro nervioso del estómago.

Enfermedades de las vísceras abdominales y torácicas.—Al hacer la historia de los síntomas de la dispepsia indicaremos las principales afecciones que influyen sobre el plexo solar.

Etiología de la irritacion de los ganglios nerviosos periumbilicales y del plexo lumbo-aórtico.—Las fatigas físicas, la marcha, la estacion en pie, irritan á menudo estos centros por el intermedio de la médula. En la mujer, cada época menstrual puede despertar su irritacion. No hay una sola enfermedad de una víscera abdominal que no sea capaz de producir el mismo efecto, catarro de la vejiga, afecciones de riñones, etc.

Cuando estos ganglios se irritan comunican generalmente la irritacion al plexo solar, y engendran así indirectamente la dispepsia.

He indicado, pues, hasta aquí rápidamente todas las causas de irritacion del plexo: alimentos, bebidas, medicamentos, masticacion imperfecta, irregularidad en las horas de comer, lactacion, fiebre, etc.

Estos datos nos explican por qué la dispepsia es tan frecuente, por qué aparece con la mayor facilidad y complica todas las enfermedades con fiebre.

La dispepsia puede ser provocada por la irritacion del cerebro, de la médula, de los centros nerviosos abdominales, así como por los *ingesta*. Las relaciones del plexo

solar con los demás centros hacen de la dispepsia la enfermedad más comun, *y* á la que cada individuo está expuesto diariamente por una emocion, una fatiga física ó un error de régimen.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO IV

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Sintomatología.

Cada centro nervioso irritado, cerebro, médula ó centros nerviosos abdominales, se manifiesta por una serie de síntomas que caracterizan la irritacion. Mientras el centro nervioso permanece en el estado de salud, el individuo no se apercibe de su existencia; siente los latidos del corazon y los movimientos de la respiracion, pero no su cerebro, ni su médula, ni el plexo, ni los otros centros. Otra cosa sucede tan pronto como uno de ellos se irrita; todos

sucesivamente se dejarán sentir con fenómenos particulares; ese mismo sistema nervioso, que estaba silencioso, se hará en extremo sensible y será la causa de dolencias infinitas y variadas hasta el día en que, restablecido su equilibrio, vuelva de nuevo á su silencio.

Los patólogos han descrito bien los síntomas que presentan los enfermos á propósito de cada uno de los centros, pero no han comprendido nunca su verdadero origen ni han podido elevarse tampoco á su causa real. Los violentos dolores de cabeza, los vértigos continuos, los aturdimientos, les anuncian siempre una congestion inminente, una apoplejía cerebral ó un reblandecimiento del cerebro. Felizmente para los enfermos, el diagnóstico es inexacto en el mayor número de casos.

Los patólogos han olvidado completamente la célula cerebral y no han visto en el cerebro más que circulacion cerebral: ésta tiene evidentemente una gran importancia; el cerebro, como el músculo, no vive sin recibir sangre oxigenada; pero han olvidado la célula é ignorado todos los síntomas que produce cuando está irritada; no tratan de célula nerviosa hasta el ca-

dáver, y entonces explican siempre las lesiones por vicios de circulacion. Cuando la célula está sólo irritada no tiene lesion alguna, puesto que no hay aberracion de la conciencia y recupera su funcionamiento entero. Empezaré por un análisis de los síntomas del cerebro irritado.

Cefalalgia, vértigo, etc.

1.° *Síntomas de irritacion de la célula cerebral.*—Cuando la irritacion cerebral aparece se manifiesta, sea por un dolor de cabeza, sea por un vértigo ó un aturdimiento ó tambien por un zumbido intra-cerebral: tales son los signos que acusan la irritacion de la célula. Así como las especies de ruidos respiratorios denotan una bronquitis ó una pulmonía, así tambien el día en que un individuo señala un vértigo, una cefalalgia ó un aturdimiento, puede afirmarse que la célula sufre y amenaza los otros centros á causa de sus íntimas relaciones.

En mi precedente tratado he indicado estos diversos síntomas de irritacion cerebral, pero como me ocupo de un capítulo de patología del todo nuevo, nos es necesario volver sobre la cuestion, tanto más cuanto que mis convicciones han sido corroboradas por las observaciones hechas du-

rante tres años, por el tratamiento de gran número de enfermos y por su curacion.

2.° *Cefalalgia.*—La cefalalgia, fenómeno tan comun que todo el mundo ha resentido, no ha sido nunca definido por los patólogos, que confundian la cefalalgia con los dolores situados en la superficie del cráneo. Incriminaban sólo al músculo, á los nervios del cráneo, jamás á la célula cerebral. En las grandes crisis de cefalalgia que no podian comprender, procuraban explicarlas invocando una diátesis, artritismo, herpetismo ó bien haciendo entrar en juego las meníngeas y anunciando una meningitis. Pero nadie se ocupaba de la célula.

La cefalalgia es el dolor producido por la célula que se revela al *yo* consciente, dolor más ó menos vivo, más ó menos tenaz. Cuando la célula está profundamente atacada, la sensibilidad celular es tal que el enfermo, inmóvil en su cama, incapaz de hacer un movimiento, de soportar un rayo de luz, de entender lo que se dice á su alrededor, ha perdido toda voluntad: la inteligencia es confusa, la memoria está abolida, el enfermo no tiene conciencia completa de sí mismo, su fisonomía es ca-

davérica, la nariz afilada, las extremidades están frías y el pulso ha caido á cuarenta pulsaciones. Este estado puede durar uno, dos ó tres dias, y cuando el enfermo vuelve en sí ignora cuánto se ha pasado. Hé aquí la crisis de cefalalgia en su grado *máximum*: si en este estado de anonadamiento cerebral se purgase al enfermo se podria determinar la muerte; la crisis puede por sí sola llegar al mismo resultado.

Esta crisis significa perturbacion profunda de la célula cerebral; al concluir, el paciente no queda curado del todo ordinariamente; sufre de los nervios del quinto par, la médula se ha irritado y aparecen la raquialgia cervical, la hiperestesia de los músculos y de la piel del cuello ó bien la hiperestesia del cuerpo en su totalidad. Esta crisis cerebral calmada reaparecerá con la primer fatiga, á la primera emocion; el enfermo que ha sufrido un ataque semejante debe ser observado durante muchos meses y atendido con grandes precauciones, para restituir al sistema nervioso su equilibrio y volverlo al estado fisiológico.

He asistido á una señora de cuarenta y

nueve años, en quien un médico distinguido habia diagnosticado una congestion cerebral; la crisis duraba hacia tres meses dia y noche, y el médico prolongaba su duracion con el tratamiento de la congestion cerebral, sanguijuelas, purgativos, etc. Calmando su sistema nervioso me fué dado volverla á la vida en el espacio de diez dias.

Hay enfermos que en medio de sus sufrimientos son incapaces de gritar; pero hay otros que se lamentan constantemente, les parece que se les taladra el cráneo, no pueden permanecer tranquilos, llaman á la muerte para que ponga fin á sus dolores y se agitan sin cesar para aliviarse.

Entre la cefalalgia llevada á este grado de intensidad extrema y la cefalalgia ordinaria hay grados intermediarios infinitos, variedades en extremo numerosas. Es necesario que el sistema nervioso haya sufrido sacudidas enormes para que se desarrolle una crisis de tal importancia.

Hé aquí cómo comienza ordinariamente el dolor de cabeza. Dolor en la línea media del cráneo, en toda su extension ó en una parte solamente de su longitud ó en un punto muy limitado; el punto doloroso

existe algunas veces fuera de esta línea, y ha sido denominado sin razon *clavus hysterícus*: éste no es la expresion de la histeria, sino de la sensibilidad celular. El dolor ocupa las partes simétricas de esta línea media y se extiende á todo el cuero cabelludo, de tal suerte, que el contacto del dedo, el peso del sombrero es intolerable.

El dolor ocupa la mitad del cráneo, un hemisferio cerebral ó una region de este hemisferio, frontal, temporal, parietal ú occipital y aun los dos hemisferios al mismo tiempo.

Al principio la sensibilidad es pasajera y desaparece; cuando vuelve, es más viva y dura más tiempo. En algunos individuos que no han sido tratados, el dolor de cabeza se hace permanente, la cabeza está siempre pesada y en este caso el restablecimiento es sumamente lento.

Pero la sensibilidad de la célula no se traduce siempre por la cefalalgia. Hé aquí las diversas expresiones de los fenómenos que la sustituyen: zumbidos en el cráneo, calor, sensacion de quemadura, de vibraciones, como si hubiera cuerdas tendidas en el cráneo, de absceso que se forma, etc.

Estos fenómenos tienen la misma significacion que la cefalalgia.

Hay otros enfermos que en lugar del dolor y de los síntomas que acabamos de indicar experimentan la sensacion de vacío en la cabeza, como si el cerebro, dicen, hubiera abandonado al cráneo. Esta sensacion atormenta más que el dolor y asusta al enfermo, que procura explicársela é ignora lo que pasa en su cerebro.

3.° *Vértigo.*—La patogenia del vértigo es idéntica á la de la cefalalgia. Algunos enfermos, cuyo sistema nervioso ha sido violentamente sacudido, no tienen dolor de cabeza, sino vértigo y un vértigo pasajero. El día en que el vértigo aparece, la lengua está sucia; el enfermo toma un purgativo, que asegurará la vuelta del fenómeno porque aumenta la perturbacion del sistema nervioso ya perturbado; el vértigo cesa y el paciente vuelve á sus trabajos, á sus fatigas. El fenómeno reaparece un mes despues, el enfermo se purga de nuevo y el síntoma vuelve más pronto; á cada vértigo se añaden gases, náuseas y en lo sucesivo el vértigo se presenta más á menudo; el cerebro al fin se vuelve lo que se llama vertiginoso, es decir, que el paciente

siente vértigo cada vez que mueve la cabeza, sea que la levante, que la baje ó que la dirija á derecha ó á izquierda.

El vértigo puede ser el solo signo de la irritacion de la célula, y, pasajero en un principio, puede hacerse cada vez más frecuente. Éste no desaparecerá hasta tanto que el cerebro no se calme. He asistido individuos que sufrian vértigos constantes hacia muchos años, hasta el punto de no desaparecer más que durante el sueño para reaparecer al despertar; en este caso el vértigo suele ser tan violento que los enfermos viven condenados á permanecer sentados en una silla é inmóviles, y si vuelven la cabeza ó sólo los ojos, están expuestos á caer del asiento, no pudiendo soportar la luz ni la conversacion, ó una emocion, sin que el vértigo se reproduzca. A veces tambien el sueño es interrumpido por vértigos; los enfermos se despiertan sobresaltados, aterrados, se incorporan en la cama y sienten palpitaciones. Cuando el fenómeno disminuye, los pacientes no se atreven todavía á salir solos, temen el atravesar una calle ó un gran espacio demasiado iluminado: la célula cerebral excitada altera todo el sistema muscular que

presenta contracciones involuntarias; el centro de gravedad no está asegurado y el paciente cae con la mayor facilidad, tanto más cuanto que la vista se turba, sea sin perder el conocimiento, sea, en algunos casos, con pérdida completa del sentido, que dura de diez á quince minutos ó un tiempo más largo; la funcion cerebral se suspende y el pulso disminuye de frecuencia sin detenerse.

El vértigo cesa ordinariamente en la posicion horizontal; algunos individuos, sin embargo, lo resienten violento en esta posicion y se ven obligados á pasar la noche en un sillon.

El vértigo es seguido de gran fatiga muscular ó de un dolor de cabeza violento. La digestion lo despierta á horas variables en el dia, no dura más que un instante ó el estado vertiginoso puede durar una ó dos horas mientras el plexo permanece irritado á consecuencia de las comidas. Teniendo su punto de partida en el cerebro, en la célula cerebral, el plexo lo reproduce; pero puede no aparecer en el cerebro sino despues de la irritacion del plexo, que determinará la irritacion cerebral: tal es el vértigo, que ha sido denominado

a stomacho læso, ab intestino læso; mas la condicion de su aparicion es la irritacion de la célula cerebral que puede ser el primer acto del desórden del sistema nervioso, ó ser provocada por el sistema nervioso abdominal.

En cuanto al vértigo anémico, pletórico, gotoso, etc., que encontramos en los tratados de patología, son calificativos que no corresponden á ningun hecho cierto y que deben ser abandonados.

4.° *Aturdimiento.*—El aturdimiento ú obnubilacion pasajera de las facultades intelectuales tiene la misma patogenia que la cefalalgia y el vértigo, aparece en las mismas condiciones, vuelve con mayor ó menor frecuencia, segun el grado de irritacion de la célula cerebral; produce tambien la capa saburral de la lengua, del mismo modo que todos los síntomas cerebrales, y si el médico purga al enfermo creyendo que se trata de una afeccion cerebral, provocará su vuelta y lo hará cotidiano, cuando no aparecia más que cada mes ó cada quince días.

5.° *Apoplejía nerviosa.*—La pérdida completa ó incompleta de conocimiento durante quince minutos ó media hora es fre-

cuentemente el primer accidente que anuncia el exceso de fatiga del sistema nervioso; el individuo atacado puede no haber tenido ni dolor de cabeza ni vértigo, pero ordinariamente ésta llega cuando los centros nerviosos han dado desde hace tiempo pruebas de su estado de fatiga por medio de diversos síntomas.

El individuo cae donde quiera que se encuentra, conserva una conciencia imperfecta, oye lo que se dice, pero es incapaz de responder ni de moverse, siente la muerte inminente, ó bien la conciencia se suprime completamente; vuelve en sí con el espíritu confuso, delira algunos minutos; ó la caida se acompaña de contracturas de las mandíbulas y de los miembros, arroja espuma por la boca, rueda en el suelo, y cuando sale de la crisis presenta una debilidad pasajera de la mitad del cuerpo, que desaparece pronto; nunca presenta parálisis, en algunos casos se muerde la lengua. Hay individuos que presentan esta crisis durante la noche bajo la influencia de una digestion difícil; están en un estado comatoso, las mandíbulas y los miembros contracturados.

Estas crisis se observan en todas las eda-

des de la vida, en los niños, los adultos y los ancianos; son bastante comunes y exponen á numerosos errores de diagnóstico.

Estas crisis se confunden con la epilepsia, la congestion cerebral, la apoplejía cerebral ó con un síncope. El pronóstico de estas últimas enfermedades es grave. La crisis cerebral, por el contrario, no se reproducirá si el tratamiento está bien instituido, si la higiene del enfermo es racional, é indica irritacion de la célula cerebral sin ninguna lesion. El mal es siempre curable; rara vez, como hemos dicho, la apoplejía nerviosa determina la muerte, y en ningun caso debilita las facultades intelectuales ni tiene ninguna de las consecuencias de las otras graves afecciones que hemos indicado más arriba.

El diagnóstico se establecerá siempre con la mayor facilidad cuando los médicos tengan conocimiento exacto de la neurosis cuya historia escribo. Todos estos datos clínicos harán comprender cuántas inexactitudes encierra toda la patología cerebral actual, tan incomprensible si no se tiene cuenta de la célula cerebral que produce estas crisis apopléticas.

6.° *Insomnio.*—El insomnio es un sínto-

ma tan comun como la cefalalgia y el vértigo. Cuando la célula cerebral está irritada, este síntoma acompaña unas veces los otros síntomas de irritacion y otras veces existe solo; un individuo que ha experimentado largas emociones, que ha ejecutado trabajos intelectuales excesivos, que ha pasado durante algun tiempo las noches sin dormir, puede sufrir cefalalgias y vértigos, pero á menudo no presenta más que un fenómeno, el insomnio, y pasará semanas, meses y años sin dormir: el sueño huirá de él mientras la célula permanezca irritada; en vano llamará en su auxilio todos los medicamentos que procuran el sueño al individuo cuyo cerebro está tranquilo, todos los medicamentos serán impotentes: emprenderá marchas forzadas, ejercicios físicos, y unas y otros aumentarán la irritacion celular manteniendo el insomnio.

Aun cuando el insomnio no sea completo, el individuo cuyo cerebro está irritado no tiene nunca un sueño tranquilo y reparador, sino turbado por ensueños penosos y por pesadillas horrorosas é interrumpido más ó menos á menudo en el trascurso de la noche; el enfermo duerme me-

dia hora y se despierta, ó no duerme en toda la noche más que una ó dos horas. Si el sueño se produce, es imperfecto, el paciente se siente dormir, siente su cerebro pesado, y al despertar por la mañana está más cansado que cuando se acostó. Esto indica que todo el sistema nervioso está perturbado; al salir por la mañana de este entorpecimiento producido por un sueño incompleto, los sistemas nervioso y muscular están pesados, perezosos, dolorosos. Muchos enfermos tienen por la mañana pesadez de cabeza, cefalalgias intensas que duran una ó dos horas, ó toda la mañana, y se disipan para reaparecer al día siguiente mientras el estado del cerebro no se ha modificado.

El sueño, que no es debido ni á la congestion ni á la anemia cerebral, sino al estado fisiológico de la célula, á su estado de tranquilidad, si se permite esta expresion, no podrá recuperarse mientras el individuo no se someta á un régimen de trabajo y de nutricion que permita calmarse, equilibrarse, á los centros nerviosos. La alimentacion sin carne y el reposo absoluto del cuerpo son las primeras precauciones que debe aconsejar el médico; las cantári-

das aplicadas detrás de la oreja calman el cerebro; mas estos medios diversos pueden ser insuficientes cuando el insomnio data de mucho tiempo; el bromuro de sodio, incluso á la dosis de 2 á 3 gramos en veinticuatro horas, suele quedar sin efecto; en muchas ocasiones me ha sido dado volver el sueño practicando el lavado del estómago, y renovándolo una vez cada ocho días durante dos ó tres semanas.

El lavado del estómago es útil sobre todo para modificar el plexo solar, y por su intermedio el cerebro; el lavado cura las cefalalgias, los vértigos y hace cesar el insomnio; es maravilloso para obtener esas acciones medicamentosas que no tienen remedio alguno, es un modificador del sistema nervioso y á este título puede prestar servicios, pero con la condicion que el médico haga uso de él con las mayores precauciones y no abuse nunca. Más tarde trataremos esta cuestion.

7.° *Jaqueca.*—La jaqueca, que ha sido extraviada en los tratados de neurologia entre las afecciones que no tienen anatomía patológica, no la tiene en efecto, como tampoco la cefalalgia, el vértigo y el insomnio.

Se compone de dos órdenes de hechos patológicos: los unos intracraneales, que expresan la irritacion de la célula; los otros extracraneales, producidos por la célula á distancia. Los primeros son los golpes resentidos en la cabeza, el vértigo, la incapacidad de trabajar, de reflexionar, de coordinar dos ideas, la intolerancia de la luz, del ruido; los segundos son el dolor de los músculos y de los nervios de la region temporal, frontal, parietal, del globo ocular. La jaqueca es de ordinario unilateral.

El dolor varia en su intensidad: cuando es poco violento se localiza en el cráneo; más violento, obra sobre el plexo solar y produce gases, vómitos, náuseas ó palpitaciones; su violencia depende del grado de irritacion cerebral, que cede con frecuencia veinticuatro horas despues, sucediéndole la irritacion del plexo. El enfermo se encuentra entonces mejorado, vomita dos ó tres litros de líquido y la crisis concluye para reaparecer más tarde; el enfermo sabe que los vómitos indican el fin del ataque, y los espera con impaciencia.

Las emociones, la fatiga física ó intelectual provocan la crisis tanto más pronto

cuanto que el cerebro está más irritado, y estas recaidas dependen del grado de irritacion de la célula cerebral.

En la mujer nerviosa, cuyos centros están perturbados, el período menstrual despertará la crisis mientras el cerebro no esté calmado.

La jaqueca no cede más que por el reposo absoluto; pero siendo su patogenia la irritacion cerebral, el reposo la suspenderá sólo: no hay medicamento para curar realmente la jaqueca, como no lo hay para el insomnio.

He curado á un enfermo de jaquecas que aparecian dos ó tres veces por semana desde veinticinco años hacia y que le obligaban á meterse en cama: un negociante de provincias, que se sometió por mis consejos al régimen de trabajo, de ejercicios físicos y de alimentos que dejaron sus centros nerviosos en reposo durante tres ó cuatro meses, se restableció perfectamente.

La jaqueca es esencialmente curable; manifestándose ya en el niño, el médico debe apresurarse á atajar un mal que le perseguirá toda la vida, reglamentando su higiene de manera que el sistema nervioso no sufra ninguna fatiga.

Si su orígen se desconoce, la jaqueca resiste á los medicamentos empíricos que se dirigen contra ella; pero tan pronto como se tenga en cuenta su verdadera etiología, el médico llegará fácilmente á curarla, con la condicion de alejarse de las ideas de diátesis, de las teorías fisiológicas de la jaqueca actualmente enseñadas (gran simpático, etc.) y de elevarse á la verdadera patogenia de esta dolorosa afeccion que amarga la vida de tantos individuos.

I

ESTADO INTELECTUAL Y MORAL

Todas las dolencias cerebrales que acabamos de describir, cefalalgia, vértigos, aturdimientos, insomnios, etc., etc., cada una de las cuales repercute en los otros centros, que á su vez las reproducen, las hacen renacer, determinan á la larga una debilidad, una disminucion de las facultades intelectuales, de la actividad y de la voluntad, alterando la sensibilidad moral y física del individuo.

La fuerza de atencion, de reflexion, la memoria, disminuyen; la coordinacion de ideas se hace mal; las ideas reguladas, clasificadas por decirlo así por el *yo* consciente en el estado de salud, se despiertan en este estado á su llamamiento y no apa-

recen ante él sino cuando las suscita. Nada parecido sucede en los cerebros irritados de larga fecha: las ideas brotan por sí solas, revolotean por decirlo así en el cerebro y se presentan inopinadamente á la conciencia, que no las espera ni las ha evocado.

Numerosos enfermos me han dicho que están en un estado de desvarío constante, que no son dueños de sí mismos, que no dirigen su medio intelectual: este estado dura tanto como la irritacion de la célula. El paciente no puede desechar ideas que aparecen á pesar suyo, porque su voluntad es impotente, y cuando quiere darse al trabajo de la reflexion, las ideas que ha reunido huyen con la mayor facilidad; cuando desea llevar á cabo una operacion intelectual, todos los elementos le abandonan.

El *yo* permanece perfectamente consciente y se inquieta, se aflige de lo que sucede en el cerebro, entrevé la locura y aberraciones de toda especie; no encuentra palabras para expresar las ideas; cada comida, cada día de trabajo exageran estos fenómenos, hasta el punto de pronunciar unas palabras por otras, de gritar y

cantar involuntariamente, llegando finalmente á no pensar, ni á acordarse, ni á querer.

En el estado de salud, todas las impresiones y sensaciones del mundo exterior y del organismo llegan al *yo* y producen satisfaccion ó repulsion. El *yo* escoge aquellas que le agradan y se guarda de las que le son penosas.

Para un cerebro irritado, todas las impresiones y sensaciones del mundo exterior y del cuerpo son igualmente penosas, mal acogidas y producen tristeza; las más alegres provocan lágrimas; todas hacen entrever alguna calamidad ó enfermedad en extremo grave: el paciente teme todas las enfermedades de que oye hablar. Tal es el hipocondríaco, sér esencialmente desgraciado, porque todo lo que tiene lugar en el mundo ó en su cuerpo es causa de sufrimientos; y está enfermo de tal modo, que poco á poco se separa de la sociedad, de sus negocios, de su familia para no ocuparse más que de sí mismo y no hablar más que de él; se cree desgraciado hasta tal punto, que le parece siempre que el mundo, su familia, no le compadecen bastante y se ve condenado á no curarse nun-

ca, no pudiendo admitir que una enfermedad tan compleja desaparezca.

Estos enfermos se dividen en dos categorías: unos cuyo sistema muscular parece anonadado y permanecen en una inmovilidad absoluta, incapaces de andar, faltos completamente de voluntad: he visto individuos que no tenian fuerza para recoger su sombrero caido á tierra. Otros, impelidos por una fuerza interior que no pueden dominar, andan sin cesar, recorren 30 kilómetros de seguido para obedecer á esta fuerza irresistible y caen luego en un estado de postracion que dura muchos días, impidiéndoles salir en ocho ó quince consecutivos. Los niños nerviosos, cuyo cerebro está ya excitado, pertenecen todos á esta segunda categoría; una necesidad incesante de andar, de moverse, los anima, no tienen paciencia para permanecer sentados en la mesa durante la comida, gesticulan, hablan sin cesar, no pueden ocuparse en ningun trabajo que exija algun reposo y atencion. Tal es en los niños el primer grado del neurosismo, que el médico debe apresurarse á combatir. Estos niños son irascibles, tienen un lenguaje grosero, lloran por el menor motivo, tienen

un apetito caprichoso, no les gusta más que la carne y rechazan toda legumbre: otros, por el contrario, no aceptan más que las legumbres, y en fin, algunos carecen completamente de apetito.

El estado cerebral morboso que acabamos de describir rápidamente se modifica, se mejora ocho ó quince dias despues de instituido el tratamiento.

La tristeza disminuye, la sensibilidad moral y física se reconstituye, la memoria, la fuerza de atencion, la voluntad reaparecen, todas las facultades del *yo* adquieren nuevo vigor; pero el equilibrio cerebral no se restablecerá ni el *yo* recobrará toda su actividad, todo su poder, sino al cabo de un cierto número de meses. ¿La enajenacion mental es siempre independiente de esta enfermedad? ¿Qué límites separan este estado morboso propio á la irritacion cerebral de la enajenacion? Seria difícil contestar: el vulgo llama á estos enfermos locos, hipocondríacos, gente que atiende demasiado á sus sensaciones. No son, sin embargo, locos, y á menudo la enfermedad sola los ha vuelto timoratos.

Cuando la salud del cerebro se restable-

ce, emprenden de nuevo sus trabajos con la misma inteligencia, con igual reflexion que antes. Esto sucede con los nerviosos víctimas de excesos de trabajo, y algunas veces de excesos de todo género.

II

SINTOMATOLOGÍA DE LA IRRITACION DE LA MÉDULA

Si la irritacion cerebral se manifiesta por fenómenos numerosos, á causa de lo complejo de sus funciones, no sucede lo mismo con la médula, cuya sintomatología es sencilla como su funcion. Irritada, se manifiesta por dolor, hormigueos, picazones, sensaciones de frío, de hielo, de calor. Cada una de estas impresiones es más ó menos viva; el dolor es algunas veces tan intenso que hace gritar al enfermo, que no puede soportar el menor contacto, el menor movimiento y se ve condenado á una inmovilidad absoluta en la cama: sus gemidos durante dos ó tres días consecutivos hacen temer sin razon al médico una meningitis espinal; la sensacion de calor, que

no es menos penosa que el dolor, le priva de sueño mientras dura; la picazon puede ser tal, que el paciente se desgarra la piel sin sentir ningun alivio; en fin, la sensacion de frío, de hielo es más insoportable todavía, pues nada puede disminuirla y calentar al enfermo mientras el centro espinal está irritado; el paciente asegura que está frío como si fuera á morir y pide que se le cure prontamente, porque es imposible vivir con ese frío interior ó con el calor que le consume.

Todos estos síntomas se manifiestan en una parte cualquiera de la columna vertebral, en toda su extension, en una region solamente ó en una ó dos vértebras. Sea cualquiera la extension que éstos ocupen, su significacion es siempre la misma.

La irritacion espinal puede establecerse primitivamente ó ser consecutiva á la irritacion cerebral, y repercute siempre en las vísceras que se relacionan con la parte irritada; si la region dorsal es la atacada en su parte superior, las vísceras torácicas sufren; si su parte inferior es la irritada, el estómago y el intestino grueso son los lastimados.

Cuando la region lumbar ó la sacra es

el sitio de la irritacion, los órganos genitales del hombre y de la mujer se afectan habitualmente; pero del mismo modo que la médula obra sobre las vísceras, cada víscera torácica ó abdominal puede ser causa de irritacion de una region correspondiente de la médula y en ese caso la irritacion es consecutiva.

Muchos dispépticos tienen dolores, sensacion de quemadura ó de frío en la parte inferior de la médula dorsal ó lumbar; muchas mujeres afectadas de congestion uterina acusan dolores vivos en la parte inferior de la médula, y esto particularmente en las épocas menstruales. Hay dispépticos que no se quejan más que de dolores dorsales ó lumbares; del mismo modo que hay mujeres que, afectadas de metritis, sufren tales dolores de riñones que la estacion en pie ó la marcha les son imposibles; todo se atribuye al útero habitualmente, cuando en realidad es la médula la causa principal.

Los síntomas medulares no disminuyen ni desaparecen hasta que la médula no se calme, y ésta no volverá á su estado de reposo sino cuando los otros centros dejen de estar afectados, cuando ella misma no

sea sometida á una labor exagerada por la marcha, el trabajo, etc., y cuando el médico trate las vísceras que han producido la irritacion. Ésta será atenuada con ligeros revulsivos aplicados de vez en cuando, un número limitado de cauterizaciones punteadas, vejigatorios de 4 á 5 centímetros, que no deben permanecer aplicados más de cuatro ó cinco horas, etc., etc.

TERCERA PARTE

SISTEMA NERVIOSO ABDOMINAL

CAPÍTULO V

IRRITACION DE LOS CENTROS NERVIOSOS DEL ABDÓMEN

Plexo solar.—Los síntomas cerebrales y medulares han sido indicados por los patólogos, aunque no interpretados en su verdadera patogenia.

Pero no ha sucedido lo mismo con el sistema nervioso abdominal, que presenta relaciones íntimas con el cerebro y la médula; de él no se trata en patología, ha desaparecido enteramente en medio de los síntomas del estómago, del intestino y de

las vísceras; no se habla más que de gastralgia, de gastritis, de enteritis, de cólicos hepáticos y nefríticos, resultando una confusion singular y numerosos errores de diagnóstico. Tratándose de una enfermedad del abdómen, el médico no puede establecer un diagnóstico serio si desconoce estos centros y sus síntomas.

He hablado ya de estos centros en mi precedente libro, *Estómago y cerebro*; volveremos á describirlos sucintamente.

Estos centros son cuatro: el primero es el plexo solar, que se extiende de la extremidad esternal al ombligo delante de la columna vertebral; dos están colocados sobre una línea horizontal que pasa por el ombligo y simétricamente á 6 centímetros de éste; en fin, el cuarto está situado delante de la columna vertebral, en una línea vertical que viene del ombligo y á 6 centímetros de esta cicatriz; éste es el plexo lumbo-aórtico.

Millares de observaciones clínicas, el tratamiento de miles de enfermos me han permitido precisar estos hechos anatómicos. Cada uno de estos centros tiene su autonomía propia, pero tambien cada uno de ellos obra sobre los otros centros, que

no pueden ser observados en el estado de salud. Manifestándose solo cuando están irritados, aparecen con la enfermedad y vuelven á funcionar en silencio en cuanto cesa su estado irritativo. Analizaremos sucesivamente los síntomas propios á cada uno de ellos.

Plexo solar irritado.—Los síntomas son subjetivos y objetivos. Alteracion de la sensacion del hambre, de la sed, dolor, pesadez, quemadura, sensacion de bola, disnea: tales son los diversos caractéres que acusan la irritacion. Se presentan aislados ó en grupo, y como esta irritacion produce siempre la congestion patológica de la mucosa estomacal, se puede afirmar que cuando existen hay dispepsia.

Alteracion del hambre y de la sed.—De 500 dispépticos, 139, es decir, próximamente la tercera parte, han conservado el apetito y comen con gusto. De esos 500, 94, inapetentes, sentian repulsion por toda especie de alimento. Estas dos cifras expresan los extremos de la escala de dispépticos, entre los que los primeros se nutren con placer, pero sufren despues de una ó de todas las comidas, y los otros tienen repugnancia por todos los alimentos. Entre estos dos

extremos se encuentran todas las anomalías del hambre, necesidad aumentada, acrecentada de tal suerte, que cuando la comida se termina el dispéptico siente de nuevo el hambre y pide alimentos; de este modo hace comidas múltiples á horas irregulares, se levanta de noche para comer, etcétera. En este caso se trata de un bulímico cuyo plexo está irritado. Hay otros que sólo apetecen las sustancias que excitan los nervios de la lengua, del paladar, los ácidos, los pepinillos; tienen horror por la carne, que necesita ser masticada y no toman más que legumbres. Estas rarezas del gusto significan que los nervios gustativos sufren la influencia del plexo. Hay individuos, en fin, que sólo desean frutas y pasteles.

El hambre es una sensacion que nace en el plexo una ó más veces por día y que se combina con los nervios del gusto para constituir el apetito; las turbaciones del plexo traen consigo disturbios en los nervios del gusto, y de ahí las extravagancias de apetito de ciertos dispépticos. Mientras el centro estomacal está en reposo, el individuo prefiere una alimentacion sencilla y modesta; pero una vez excitado el cen-

tro, el estómago se hace caprichoso y pide una alimentacion realzada y sabrosa.

Alteracion de la sed.—Del mismo modo que hay el *consensus* entre los nervios del gusto y el plexo, tambien existe entre los nervios de la sed y el mismo plexo.

La sed es proporcional al grado de irritacion del plexo: si ésta es grande, la primera no se satisface por ninguna especie ni cantidad de líquido; la sed ardiente indica dispepsia con más frecuencia que diabetes, que es poco comun; la sed constante del borracho es engendrada por la dispepsia. La polidipsia no es una enfermedad especial, y debe ser atribuida á la irritacion del plexo; he curado polidipsicos calmando al plexo solar.

La sed disminuye con la dispepsia, y es uno de los primeros fenómenos que ceden con el tratamiento racional; aumenta y se agrava cuando no se mide la cantidad de bebida, cuando excede de dos vasos de líquido; aumenta tambien con los líquidos que irritan la mucosa, como el vino, etc. Por este motivo el individuo que se acostumbra á beber vino se hace dispéptico por abuso de éste y se encuentra en un círcu-

lo vicioso: el vino no calmará nunca su sed y la aumentará sin cesar.

En resúmen, todas las modificaciones de la sensacion del hambre, del apetito, de la sed, significan dispepsia; hay sin embargo cerca de la mitad de los pacientes que conservan el apetito y el hambre; muchos tienen una sed más ó menos ardiente, y la sed sola revela la enfermedad del estómago.

Dolor.—El plexo solar se manifiesta, cuando está irritado, por una sensibilidad morbosa que puede ocupar toda la region del estómago delante de la columna vertebral, sus ganglios nerviosos, los cordones que los reunen y se extienden desde la extremidad esternal hasta el ombligo. El dolor ocupa todo su trayecto, pero á menudo la extremidad esternal solamente, en cuya region el médico lo aumenta cuando palpa; otras veces, el dolor existe sólo en su parte media ó en la inferior, al nivel del ombligo.

La sensibilidad morbosa puede existir y pasar desapercibida para el enfermo hasta que la presion no la determine; se exalta siempre por el trabajo que el alimento impone al plexo: intensa tres ó cuatro horas

despues de la comida ó inmediatamente despues de ésta, segun el grado de excitacion del centro nervioso, que permanece doloroso durante algunos minutos; media hora, una, más tiempo aun cuando el mal es antiguo, la sensibilidad puede ser tal que el traje deba tenerse abierto y el corsé se haga intolerable, y que durante la noche el enfermo no pueda soportar el decúbito lateral, teniendo que acostarse sobre el dorso.

Cuando la sensibilidad morbosa es de larga fecha, se modifica y toma una intensidad muy grande, produciendo crisis dolorosas que duran un tiempo variable, algunos minutos ó días enteros, y que arrancan alaridos al enfermo; éstas pueden tener lugar con ó sin convulsiones de la fibra muscular del estómago, sin vómitos y cesar instantáneamente para empezar en un momento inesperado. Cuando el estado irritativo del plexo es tal que produce crisis dolorosas, una emocion, la fatiga física las renueva lo mismo que las comidas; así tambien un viaje, un cambio de medio las suprime momentáneamente; pero esta supresion no dura mucho, y la crisis reaparece hasta que por un tratamiento bien

dirigido y continuado durante algun tiempo el plexo no haya vuelto á su equilibrio fisiológico: una inyeccion hipodérmica de morfina la calma, pero asegura su vuelta.

Intervalos de semanas y de meses existen al principio entre las crisis, pero fatalmente los intervalos disminuyen y las crisis se hacen más frecuentes. Entre los enfermos asistidos por mí, uno tenia tres crisis por día desde hacia veinticinco años; otro tenia una crisis, regularmente cada noche á las dos, hacia dos años; otro, en fin, la tenia por la mañana á las cuatro siete años hacia; este último fué curado en seis semanas con el régimen alimenticio, el reposo y tres lavados del estómago.

Las crisis vuelven con la mayor regularidad á las mismas horas y en el mismo minuto, y desaparecen dejando, ora un estado de abatimiento profundo, ora un bienestar indescriptible. Una vez terminada la crisis, toda sensibilidad morbosa en la línea media del estómago desaparece, ó bien la sensibilidad persiste en algunos puntos de esta línea. En ciertos enfermos, cuando la crisis disminuye y va á concluir, las fibras musculares del estómago entran en juego, se contraen y el ór-

gano expulsa algunos litros de líquido. Los pacientes esperan con ansia el vómito que pondrá fin á los dolores; una expulsion de gases tendrá lugar en otros casos, pero esto no sucede sino cuando el plexo se sosiega.

La crisis no se termina siempre de este modo; si cesa instantáneamente sin dejar huellas, si trae consigo vómitos y gases, volverá; pero si es reemplazada por dolores en el trayecto de los últimos nervios intercostales del lado derecho ó del izquierdo, puede no reproducirse, con la condicion de que el enfermo sea sometido á un tratamiento muy severo.

La crisis dolorosa del plexo es la expresion más alta de la alteracion de su sensibilidad, y no se produce sino cuando la dispepsia es antigua. Se produce tambien consecutivamente á la irritacion cerebral. Todos los medicamentos introducidos en el estómago durante la crisis con el objeto de adormecer al sistema nervioso son expulsados ó no tienen efecto alguno; no hay medicamento capaz de hacer abortar una crisis, y ésta debe terminarse por sí sola. Durante el ataque, el enfermo, que procura hacer toda clase de movimientos

para sustraerse al dolor, deberá permanecer en el reposo más absoluto posible, y se procurará aliviarlo por medio de revulsivos externos. La intervencion médica será solamente útil para prevenir las crisis posibles, calmando al plexo solar.

Pesadez.—La sensacion de peso es otro síntoma de la irritacion del centro nervioso; es una forma de la sensibilidad morbosa, que se siente algunas horas despues de la comida y durante un tiempo más ó menos largo; no aparece al principio, sino despues de la tercera comida, y se hace á menudo constante para no cesar más que durante la noche.

El dispéptico explica siempre este fenómeno por la sobrecarga alimenticia, y he asombrado á algunos que, despues de un lavado del estómago sin encontrar restos de alimento en el líquido devuelto, sentian sin embargo el órgano pesado, lleno; esta sensacion subjetiva no cede, lo mismo que el dolor, á un medicamento cualquiera, ni cura tampoco si el alimento es confiado al estómago sin la nocion exacta de su accion fisiológica.

Ahilos.—Los ahilos son confundidos con frecuencia con el apetito, y se calman por

el alimento; las comidas, por su repeticion frecuente, mantienen y aumentan la impresion morbosa que tiene el mismo valor patológico que el dolor, etc. Esta sensacion es menos penosa, sin embargo, que las antes estudiadas, y les sucede cuando empiezan á atenuarse.

Sensacion de quemadura.—Esta sensacion es muchas veces el signo único de la irritacion del plexo. Debe distinguirse de la quemadura que da un líquido ácido introducido en el estómago, y no es duradera; la evolucion de la sensacion es idéntica á la de los síntomas que acabamos de describir: aparece á las mismas horas, dura el mismo tiempo y se hace continua como las sensaciones de dolor y de peso, percibiéndose de ordinario en la línea media, debajo de la extremidad esternal.

Sensacion de bola.—Esta sensacion, que los patólogos califican con frecuencia de histérica, se observa en la histeria que puede complicarse con dispepsia; pero la sensacion de bola localizada debajo de la extremidad esternal, y que puede subir hácia el esófago siguiendo los nervios de este conducto, caracteriza la irritacion del plexo é

indica una irritacion antigua ya y violenta.

En cuanto el plexo vuelve á su estado normal, el volúmen de la bola y la incomodidad que determina disminuyen; en fin, el fenómeno desaparece y deja tras sí una sensacion de dolor ó de peso. Todos estos hechos de sensibilidad morbosa del plexo se transforman, se suceden, antes de extínguirse; su intensidad se caracteriza por los diversos síntomas que hemos analizado y que tienen una evolucion regular y la misma patogenia. Para completar su historia, debo hablar de un síntoma en extremo comun que tiene el mismo orígen que los precedentes, esto es, de la disnea.

Disnea.—Pensaba, antes de haber estudiado el estómago, que la disnea era siempre provocada por el pulmon ó por el corazon y buscaba una lesion cardíaca ó pulmonar; con frecuencia me equivocaba y no podia explicarme el orígen de la disnea. Y es que la disnea se debe al plexo solar más á menudo de lo que parece en general, y presenta todos los caractéres de la que acompaña al asma ó á una afeccion cardíaca.

El enfermo, despertado bruscamente en medio de la noche, abandona el lecho en busca de aire y permanece dos ó tres horas respirando difícilmente; la marcha, el acto de subir una escalera, el menor esfuerzo muscular, producen los mismos resultados. En otros casos la disnea aparece al principio, á las mismas horas que el dolor, la sensacion de peso, de quemadura, de bola; dura el mismo tiempo, y, como estos síntomas, es determinada por las comidas. La disnea es con frecuencia la sola expresion de la irritacion del plexo, y se establece desde luego sin haber sido precedida por ningun otro fenómeno. Otras veces, uno cualquiera de estos síntomas puede sucederla.

Hay individuos que sufren dificultad para respirar despues de una comida solamente; hay otros en los cuales cada comida hace aparecer de nuevo la misma dificultad.

He hecho conocer los signos de irritacion del plexo, que deben ser enteramente separados de los que determina la mucosa estomacal patológicamente congestionada; los primeros pueden presentarse aisladamente, pero se acompañan de ordinario

por algunos síntomas pertenecientes á la mucosa, porque el plexo irritado provoca casi siempre la congestion patológica de esta membrana. Es importante separar estos dos órdenes de fenómenos, pues el medicamento puede tener una accion sobre la mucosa, pero nunca sobre el plexo solar directamente.

Sintomatología de la irritacion de los centros nerviosos periumbilicales y subumbilical. —Cada uno de los centros nerviosos periumbilicales puede irritarse separadamente, y con frecuencia es el izquierdo el que se irrita; pueden ser tambien afectados todos simultáneamente, ó bien el centro subumbilical se irrita solo, aunque en el mayor número de casos la irritacion de este último se complica con la de uno de los centros periumbilicales y aun del plexo solar; todo lo cual quiere decir que estos centros están ligados unos con otros y se influyen recíprocamente: más tarde volveremos sobre este punto.

La sintomatología de su irritacion es idéntica á la del plexo solar: dolor, sensacion de peso, de quemadura, ahilos, calor, disnea, significan irritacion del centro nervioso. Estos diversos síntomas se manifies-

tan á las mismas horas, tres ó cuatro despues de la comida ó inmediatamente despues de ésta, despues de una comida, frecuentemente la tercera ó despues de cada una de ellas. Su intensidad aumenta sin cesar y estos centros producen crisis de dolor, de peso, de quemadura, etc.; fenómenos que se manifiestan aisladamente ó se complican con síntomas de la mucosa del intestino grueso, que está inervada por los centros periumbilicales, ó con síntomas uterinos, vesicales, testiculares, en una palabra, de las vísceras que reciben sus nervios del centro subumbilical. Tan vasta fenomenología, olvidada hasta hoy, debe tenerse presente en el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades abdominales. Las crisis de dolor debidas á estos centros, y que se complican con síntomas variados, vómitos, estreñimiento, diarrea, simulan á menudo cólicos hepáticos ó nefríticos, con quienes han sido siempre confundidas hasta aquí.

El médico deberá palpar siempre estos diversos ganglios para conocer el estado del abdómen, y cuando los encuentre dolorosos ó procurando una sensacion de peso, de quemadura, puede estar seguro que

el intestino grueso está perturbado en su funcion; si el ganglio subumbilical está doloroso, pesado, etc., la vejiga, el útero sufren en sus funciones.

CUARTA PARTE

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

CAPÍTULO VI

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

La clínica demuestra que la irritacion de un centro es rara vez un hecho accidental, pasajero, aislado; tiende al contrario á durar, si no se la combate, y á propagarse á los otros centros para irritarlos.

Lo mismo que el cerebro, y esto lo observo yo diariamente, trasmite su irritacion á la médula y la médula á su vez la comunica al cerebro; así tambien la iritacion cerebral pasa al plexo solar, y recípro-

camente el cerebro se irrita por la influencia del plexo ó de la médula.

La estadística lo demuestra claramente: de 500 dispépticos, las cuatro quintas partes por lo menos han tenido durante años jaquecas, vértigos, etc., y sólo cuando han llegado á cierta edad el estómago sufre particularmente; es lo que los antiguos médicos llamaban una metástasis, invocando toda clase de razones para interpretar este cambio que se produce naturalmente. El cerebro predispone á la dispepsia al mayor número de los enfermos, y toda infraccion á la higiene del estómago crea el padecimiento; los fenómenos cerebrales disminuyen entonces, mas no desaparecen, porque la irritacion cerebral está aminorada pero no extinguida.

En el estado fisiológico no hay una sola impresion que llegue al cerebro, á la médula, á los centros nerviosos abdominales, que no repercuta en la totalidad del sistema nervioso, cuyas partes son todas solidarias.

Lo mismo sucede exactamente cuando los centros nerviosos están irritados; toda impresion, viniendo del mundo exterior ó del organismo, repercute en todos los otros

centros, y si es violenta la irritacion aumenta; no hay una emocion, un trabajo intelectual ó físico, un solo alimento indigesto, cuya accion no se propague á todos los centros nerviosos.

Si lo dicho hasta aquí es cierto, fácil es comprender que los órganos de los sentidos, que los nervios que no viven ni funcionan más que por los centros nerviosos, sufrirán las consecuencias de la irritacion de éstos.

Analicemos ahora los síntomas que presentan los órganos de la vision, del oído, del tacto, del gusto, del olfato.

Órgano de la vista.—La irritacion cerebral puede sólo manifestarse por los síntomas que hemos indicado; á éstos pueden agregarse los signos de los órganos de los sentidos, ó bien estos últimos expresan solos el estado irritativo.

El enfermo va á consultar al oculista sobre dolores agudos que siente en el fondo del ojo, en el izquierdo más á menudo ó en los dos ojos al mismo tiempo. Si no es la retina la hiperestesiada, serán los nervios de los músculos, y el dolor puede tener su orígen en la retina, en los nervios de los músculos del globo ocular ó en el globo ocular entero.

El niño presenta un estrabismo pasajero ó durable de uno ó de los dos ojos, que no cesa sino cuando el cerebro se calma; la funcion visual se altera, la vision de un ojo ó de los dos se debilita y se restablece con la salud del sistema nervioso. En los casos en que la vista conserva su intensidad, puede ser turbada por la produccion de una nube que se coloca delante de los objetos, por moscas volantes, chispas, etc.

Los colores son mal percibidos; el rojo parece negro, el color amarillo reemplaza cierto número de matices, el paciente percibe agujeros en puntos en que no existen. La imágen de los objetos afecta la mitad de su dimension ó son dobles ó triples. Un ojo solo, el izquierdo de preferencia, presenta estas aberraciones; en otros casos los mismos fenómenos tienen lugar en los dos ojos simultáneamente.

Alucinaciones, imágenes de hombres ó de animales raros se presentan á ciertas horas del día, en el momento de la digestion. Estos hechos patológicos tan frecuentes atormentan al nervioso, y el oculista examina el fondo del ojo sin encontrar ninguna modificacion.

El cerebro es causa de estos diversos fe-

nómenos, que no desaparecen hasta su curacion. Algunos enfermos, aunque esto es sumamente raro, se vuelven completamente ciegos de uno ó de los dos ojos durante algunos minutos, *algunas horas ó muchos dias.*

Órgano del oido.—Con el oído sucede como con la vista. El tímpano se hace doloroso á ciertas horas del día y se producen crisis intolerables que el exámen del fondo del oído no puede explicar; en vez de dolor, algunos individuos experimentan una sensacion de peso ó de cuerpo extraño que no existe.

Estos diversos fenómenos tienen lugar en los dos oídos ó en uno solo, el izquierdo preferentemente.

El más comun de todos es el zumbido de oídos, que se presenta á ciertas horas durante la digestion, y que, intermitente en un principio, se establece luego de un modo continuo; otros enfermos, en lugar de zumbidos experimentan un ruido de vapor de agua que pasa por el oído; este zumbido desaparece durante algun tiempo y se renueva mientras los centros están irritados; su gravedad consiste en que con frecuencia, cuando dura largo tiempo, es

seguido de una disminucion de la sensibilidad acústica de un oído primero, de los dos despues; sordera que, incompleta cierto tiempo, puede hacerse total si el médico no interviene activamente. El exámen del fondo del oído no explica en modo alguno esta sordera, que es bastante frecuente, y determinada siempre por la irritacion de la célula cerebral y su influencia sobre los nervios y músculos del oído interno.

Las alucinaciones del oído son muy raras; sin embargo, las he encontrado en dos ó tres de mis enfermos; generalmente se manifestaron á las cuatro de la tarde, ó en la primera parte de la noche, y duraron una hora ó menos tiempo, desapareciendo tan pronto como se calmó el sistema nervioso.

Las perturbaciones del oído que son debidas á la irritacion de los centros se agravan cada vez más, hasta determinar la sordera doble; pero tambien pueden atenuarse progresivamente y desaparecer cuando los centros se curan.

Órgano del tacto.—Indicaremos las alteraciones del tacto cuando tratemos de los nervios periféricos.

Órgano del olfato.—Muchas personas que

no han tenido nunca ni jaquecas, ni vértigos, ni ningun síntoma de irritacion cerebral, presentan como primer fenómeno de dicha irritacion una abolicion completa del sentido del olfato, no percibiendo ni el olor de los alimentos ni el de las flores; otras, por el contrario, tienen el olfato de tal modo exaltado, que el menor olor de flores les hace perder el conocimiento; otras, en fin, tienen este sentido expuesto á todo género de errores, á alucinaciones; el olor de las flores, de los alimentos es falsamente percibido, los perfumes reputados más agradables les son repugnantes.

Este sentido es capaz tambien de restablecerse y de recuperar su funcion, con la condicion de que los centros nerviosos recuperen tambien su equilibrio.

Órgano del gusto.—Todos los nervios del gusto, los de la lengua, del paladar, encías, labios, de los carrillos, son perturbados por la irritacion de los centros: el gusto es ácido, amargo, salado ó picante; los alimentos y las bebidas tienen un gusto falseado debido á los nervios, y de ningun modo á la capa saburral de la lengua. En gran número de individuos el sentido está embotado, necesitan sustancias excitantes,

ácidos, legumbres frescas. Las modificaciones del gusto, apareciendo con la irritacion del plexo, podríamos repetir lo antes dicho á propósito del hambre y del apetito.

En resúmen, todos los órganos de los sentidos son afectados por la irritacion de los centros; sus desórdenes funcionales no son nunca primitivos, sino debidos siempre á la irritacion de la célula de los centros; cada vez que el ojo, el oído, el tacto, el olfato están afectados, el médico debe buscar la causa en la célula cerebral, que es la que engendra todos estos desórdenes.

CAPÍTULO VII

NERVIOS SENSITIVOS PERIFÉRICOS.—NEURALGIAS.—HIPERESTESIAS.

La neurología, tal como se enseña, es por decirlo así una ciencia anatómica, una descripcion geográfica de los diferentes nervios, relatando los diversos síntomas que presentan, pero que omite completamente la cuestion principal; esto es, la patogenia de las neuralgias é hiperestesias, único guía eficaz del tratamiento. El médico no puede comprender la movilidad notable que aquéllas presentan, é ignora por qué en ciertos enfermos son tan tenaces. Que se trate de nervios periféricos, de nervios viscerales, de nervios de la piel, de los músculos ó de las articulaciones, la perplejidad del facultativo es siempre la misma.

He descrito en el capítulo precedente la accion del cerebro irritado sobre los órganos de los sentidos; veamos ahora cómo todos los otros nervios sufren á consecuencia de la irritacion de los centros.

La movilidad de las neuralgias encuentra la explicacion en su causa; la médula irritada las provoca, y como la irritacion espinal recorre las diversas partes de la médula, los diferentes grupos de células irritadas obran sobre los nervios que emanan de ellas. La tenacidad de las neuralgias es debida á la persistencia de la irritacion: la neuralgia dura tanto como ésta. Las neuralgias anuncian con frecuencia la irritacion de un centro en ausencia de todo síntoma que le sea propio; una neuralgia del trigémino, de los nervios cervicales, intercostales, lumbares, un dolor ciático, son algunas veces el primer signo de la irritacion de los centros nerviosos.

He sido consultado por una señorita de provincia, de edad de veintidos años, que sufria neuralgias atroces del quinto par hacia tres años, no pudiendo ni dormir ni nutrirse. El plexo solar, así como la médula, estaban irritados. Los médicos que la habian asistido durante estos tres años,

imbuidos de las ideas de Trousseau, que creia que la clorosis determina las neuralgias del trigémino, le prescribieron carnes poco cocidas, largos paseos en los bosques, preparaciones ferruginosas y vinos generosos. Las carnes, el hierro y el vino aumentaban la sensibilidad del plexo; los largos paseos agravaban la irritacion de la médula, de modo que el mal persistia é iba en aumento. Mis prescripciones consistieron en reposo absoluto durante quince dias y supresion de la carne durante el mismo tiempo; alimentaba á la enferma con sustancias incapaces de atormentar el plexo, leche, sopas, café, huevos y feculentos; pasados los primeros quince días, la enferma daba un paseo de quince minutos por dia y tomaba carne dos veces por semana solamente. Dos meses de este régimen, adaptado al estado de los centros, fueron suficientes para hacer desaparecer la neuralgia.

Con frecuencia los nervios cervicales son dolorosos, así como los músculos en que se terminan; de ahí resulta el tortícolis, que es siempre atribuido á un enfriamiento ó á una posicion viciosa, pero debido de ordinario á la irritacion de la médula. Si

los nervios cervicales, los del hombro, los del dorso, son dolorosos simultáneamente, de tal modo que el enfermo no pueda levantar el brazo ó volver la cabeza sin quejarse, se invoca siempre el reuma como causa de estos fenómenos, y la médula ha sido constantemente olvidada.

Más comun es todavía la neuralgia intercostal, que aparece súbitamente en el lado izquierdo sobre todo y es consecutiva á fatigas morales ó físicas. Estas neuralgias resisten á los vejigatorios con gran sorpresa del médico; se acompañan de dispepsia, porque la irritacion de la médula es seguida por la del plexo; se atribuyen al catarro gástrico y no ceden ni al purgativo ni al vomitivo, que agravan al contrario la irritacion; duran meses enteros, y si el centro espinal no se calma, pueden desaparecer espontáneamente para ser reemplazadas por otras neuralgias.

Cuando los intercostales derechos son dolorosos en la region hepática, de ordinario se incrimina indebidamente al hígado, y como cierto tiempo más tarde estos nervios pueden dar lugar á crisis dolorosas, el médico tiene tendencia á diagnosticar cólicos hepáticos.

El lumbago primitivo ó que sucede á una neuralgia intercostal ó cervical, etc., se atribuye constantemente al reuma ó á cálculos renales; éste es igualmente provocado por la célula medular y dura tanto como su irritacion: el reposo en el lecho lo calma y hace desaparecer las neuralgias lumbares.

Podré repetir á propósito de la neuralgia ciática lo dicho sobre las neuralgias en general.

Un nervio no manifiesta siempre su sensibilidad en su trayecto, sino que ésta puede manifestarse tambien en las articulaciones. El hombro izquierdo solo, ó un codo, una rodilla, la izquierda con mayor frecuencia, ó las dos, pueden ser el lugar de eleccion del dolor; en otros, las articulaciones del puño, de los dedos de la mano ó del pie se vuelven sensibles inopinadamente, encargándose el reuma de interpretar siempre la hiperestesia, dejando de lado á la médula. Los dolores no desaparecen para no volver sino con la condicion de que ésta se calme.

Hiperestesia.

El nervio doloroso en su extremidad, en la periferia, determina la hiperestesia de la piel y del músculo; el clínico puede has-

ta cierto punto seguir, apreciar la irritacion de los centros, observando el trayecto, la marcha de la hiperestesia. Observará que la hiperestesia debida al cerebro es seguida con frecuencia por la hiperestesia debida á la médula; que la irritacion primitiva de los centros abdominales produce la hiperestesia de las paredes del abdómen y puede engendrar la hiperestesia del dorso, del tórax ó de los miembros inferiores, porque la irritacion del plexo determinará la irritacion de la médula.

Indicaré con brevedad la hiperestesia peculiar á cada centro.

El cerebro determina la hiperestesia de la piel de la mitad del cráneo ó de todo el cuero cabelludo, en la línea media solamente ó en un punto muy limitado; hiperestesia ligera ó en extremo intensa, de tal modo que no se puede tocar el cuero cabelludo sin hacer gemir al enfermo, que asegura que los cabellos mismos le hacen daño.

La irritacion espinal se acusa de ordinario por la hiperestesia de la piel de las vértebras en una extension más ó menos considerable, una ó dos vértebras ó toda una region. Cuando la irritacion es inten-

sa, la piel de toda la columna vertebral es sensible; pero sucede en algunos casos que la piel de la columna vertebral no es dolorosa, y que sólo las partes laterales de la piel del cuello, del dorso, de los lomos, de la region sacra, presentan el fenómeno dolor; los músculos son con la mayor frecuencia simultáneamente atacados en estas diferentes regiones.

La irritacion del plexo solar se manifiesta por la hiperestesia de la piel y de los músculos de la region del estómago, en su mitad izquierda ó derecha ó en toda su extension; puede ocupar sólo la línea media del estómago ó extenderse hasta el ombligo. Cuando la irritacion es fuerte, la piel de la espalda y sus músculos, la piel y los músculos de los lomos, se hiperestesian. Tan pronto como la irritacion disminuye, estas últimas hiperestesias de orígen medular desaparecen.

El centro nervioso periumbilical derecho produce la hiperestesia de la piel y de los músculos de la region, que empieza en este centro y se termina en la parte inferior del abdómen, del mismo modo que el centro periumbilical izquierdo determina la hiperestesia de la region izquierda; en

fin, á la irritacion simultánea de estos centros corresponde la hiperestesia de ambas regiones.

El plexo lumbo-aórtico ó centro subumbilical puede estar irritado solo, y esto se observa fácilmente en la mujer durante el período menstrual; la parte media de la piel del abdómen está entonces exclusivamente hiperestesiada.

Cada centro nervioso tiene, pues, su accion local, hiperestesia su region y los nervios que parten de ella; y como la irritacion se trasmite de un centro á otro, la hiperestesia llega á ocupar toda una mitad del cuerpo, la izquierda sobre todo, para generalizarse extendiéndose á la otra mitad.

Esta generalizacion es muy frecuente é indica la irritacion de todos los centros; cuando éstos se restablecen, la mitad del cuerpo que ha sido atacada en último lugar se cura primero, mientras que la otra mitad atacada primitivamente no se restablece hasta más tarde.

La hiperestesia puede dar lugar á crisis de dolores tan atroces como en las neuralgias propiamente dichas.

Cuando hay crisis de hiperestesia, trá-

tese de una hiperestesia cervical ó dorsal, etc., el plexo entra siempre en juego, provocando vómitos líquidos que duran tanto como la crisis y se terminan con ella; este es un hecho observado por mí en muchos de mis enfermos.

Cuando un centro nervioso se calma, la hiperestesia no desaparece sin dar lugar á fenómenos atenuados que duran cierto tiempo todavía, hasta la completa curacion, que exige semanas y meses de tratamiento. Así, los nervios determinan hormigueos, sensacion de quemadura, picazones atroces, fenómenos que se presentan en las partes del cuerpo que estaban hiperestesiadas; una parte del cuerpo, un miembro, el brazo, el muslo ó una pierna, presentan dichos síntomas, que pueden ocupar la mitad derecha ó izquierda del cuerpo.

La hiperestesia de la piel, del músculo altera el sentido del tacto, el sentido de la temperatura: la sensacion del contacto de los objetos es tardía; el enfermo apresa mal estos objetos, que escapan con frecuencia de su mano, y siente un calor ó un frío que no está en relacion con su temperatura ni con la del medio ambiente. Siente

frío en la mitad superior ó inferior del cuerpo, en un miembro, en la espalda, y esta parte fría no se calienta hasta que el sistema nervioso no se cura. Al frío sucede á veces el calor, que puede ser intenso en una parte del cuerpo á pesar de que la temperatura exterior sea muy baja. El enfermo atribuye siempre estas anomalías del tacto y de la temperatura al empobrecimiento de su sangre.

Los nervios de las mucosas del ojo, de la nariz, de la boca, de la faringe, del esófago, del estómago, del intestino, son perturbados del mismo modo que los nervios de la piel, de los músculos, de las articulaciones, por los centros irritados; la hiperestesia se produce, y da como resultado que la luz se soporta mal, que la masticacion es difícil, que el paso del alimento á través del esófago es doloroso, que el estómago está siempre ardiente, frío ó helado: la bebida fría hace daño, la comida determina una sensacion de peso; el paso de las materias fecales por el intestino grueso se acompaña de dolor intenso, que desaparece lentamente; la defecacion es penosísima.

II

NERVIOS DE LA PIEL

Los nervios de la piel, que son causa de hiperestesias, pueden determinar, bajo la influencia de la irritacion de los centros nerviosos, las diversas enfermedades de la piel que han sido descritas bajo el nombre de herpéticas. El término herpetismo, que ha estado mucho tiempo en boga, comprendia en un mismo cuadro el eczema, la urticaria, el prúrigo, el líquen, la psoriasis, etc., y designaba una diátesis especial independiente del sistema nervioso.

La observacion clínica me ha demostrado que estas diversas afecciones cutáneas aparecen, sea despues de la irritacion de los centros, sea como su primera expresion. Cuando el eczema, la urticaria, etc., han aparecido, se ven ya otros síntomas de los centros nerviosos, y todas estas afeccio-

nes cesan por lo comun cuando los centros se calman.

Hé aquí algunos hechos en apoyo de esta opinion:

Una señora, de treinta y tres años de edad, me consulta sobre dolores de cabeza, dolores de matriz y dispepsia de larga fecha. Todos los desórdenes de su salud habian empezado cinco años antes, precedidos de una erupcion de urticaria que duró un mes y que fué el primer efecto de la irritacion de los centros.

Otra señora experimenta una terrible emocion, y á la edad de sesenta años presenta un eczema y dispepsia.

Un individuo de treinta y cinco años de edad, despues de haber tenido en su infancia frecuentes jaquecas, sufria hacia seis meses cólicos atroces que le impedian dormir; el estómago estaba dilatado y hacia dos años que padecia un eczema de las dos manos rebelde á todos los tratamientos. Le anuncié que la curacion del eczema seguiria á la del plexo y á la de los otros centros, y mi prevision se realizó.

Una señora de cuarenta y un años de edad, que tiene eczema en los brazos y en las piernas, sufria desde hacia algunos

años de dolores de cabeza y de vértigos cuando empezó la erupcion; no duerme, se queja de palpitaciones, de inapetencia, el plexo está doloroso, tiene gases y sensacion de quemadura.

Un enfermo tiene desde hace quince años dolores de cabeza y vértigos, zumbido de oídos á las seis de la mañana y el estómago está dilatado; la cara está cubierta de eczema.

M. J..., de veinticuatro años, es dispéptico, su estómago está dilatado, tiene erupciones sucesivas de acné en la cara y en el tronco.

En resúmen, las afecciones que los dermatólogos han denominado herpéticas son debidas á los centros nerviosos, como la hiperestesia, como las picazones; no tengo que insistir en su estudio, pero debia solamente indicar este punto interesante: que no son debidas á un vicio especial y que no exigen una medicacion especial: engendradas por el sistema nervioso, es necesario curar éste y entonces desaparecen.

III

NERVIOS VISCERALES

La irritacion de los centros nerviosos puede traducirse primitivamente en el nervio de una víscera sin que el centro nervioso mismo haya manifestado su irritacion propia por ningun otro síntoma; así empieza un acceso de asma repentino sin haber sido anunciado ó precedido por ningun fenómeno de los centros nerviosos. Lo mismo diremos de las palpitaciones, de la ictericia; cada una de las vísceras puede ser afectada primitivamente; la diarrea, la leucorrea, anuncian irritacion cerebral, y sólo más tarde aparecen los signos de esta irritacion, cefalalgia, vértigos, etc.

En otros casos estos signos existen de larga fecha; diversos síntomas de irritacion de todos los centros atormentan hace años al enfermo, cuando aparecen el as-

ma, las palpitaciones, la ictericia, etc.

Los desórdenes viscerales se relacionan con el sistema nervioso del mismo modo que las enfermedades de la piel; unos y otras tienen el mismo orígen y se desarrollan en idénticas condiciones.

El asma, las palpitaciones, duran tanto como la irritacion de los centros y no cesan hasta que desaparece. Con frecuencia se observan enfermos atacados muchas veces de ictericia sin cólicos, sin dolores; los nervios del hígado son en estos casos excitados por los centros. Podria pasar en revista las diversas vísceras y mostrar sus relaciones morbosas con el sistema nervioso, pero me basta con haber citado el pulmon, el corazon y el hígado. Para todas, la patogenia es siempre la misma, y es inútil insistir más tiempo.

IV

NERVIOS MOTORES

La célula que produce la hiperestesia de los nervios periféricos y viscerales perturba tambien, cuando está irritada, la funcion de los nervios motores.

La irritacion de la célula produce siempre la hiperestesia, nunca la anestesia; del mismo modo determina toda especie de desórdenes musculares, menos la parálisis.

Hé aquí los principales fenómenos musculares propios á la neurosis: sobresaltos, temblores, calambres, debilidad muscular.

Estos síntomas se localizan siempre; el párpado izquierdo titila, los músculos de la cara, de un hombro, de un brazo, de una pierna, tiemblan; uno ó muchos dedos de la mano sufren calambres y se cierran involuntariamente.

Los músculos del dorso presentan tre-

mulaciones. Un brazo ó una pierna están de tal modo debilitados, que un objeto de muy poco peso no puede ser sostenido; en otros casos los músculos de los lomos, de los miembros inferiores, son incapaces de sostener al cuerpo, ó las piernas conservan su fuerza natural y los brazos solos están debilitados. Los desórdenes motores pasan de una parte del cuerpo á otra, segun el lugar de la irritacion espinal, y cambian con la mayor rapidez. En fin, si todos los centros nerviosos están profundamente afectados, la impotencia muscular puede ser completa sin que haya parálisis, y el enfermo se ve condenado á un reposo absoluto hasta que los centros se hayan calmado.

V

NERVIOS VASO-MOTORES

Edema, flebitis, clorosis.—Los nervios vaso-motores sufren la accion irritativa de los centros como los otros nervios, y de aquí resultan desórdenes de nutricion de las paredes venosas, dificultad de la circulacion de la sangre y alteracion en la composicion de este líquido; en muchos casos, cuando se declara una flebitis ó un edema de los miembros inferiores que no se explica ni por una afeccion visceral ni por el análisis de la orina, el clínico se encuentra perplejo. Cuando observa la clorosis asociada con diferentes síntomas nerviosos los considera como causados por aquélla, pero esta interpretacion es errónea. La clorosis es consecutiva á la irritacion de los centros al par que la flebitis y el edema, como lo demostraré más adelante. Cal-

mando los centros nerviosos, haciendo desaparecer los síntomas nerviosos, la clorosis desaparece, el número de glóbulos rojos vuelve á ser normal y los ruidos de soplo cesan.

Algunos hechos pondrán en evidencia la accion de los centros nerviosos.

1.° *Flebitis*.—M. L..., de cuarenta y ocho años de edad, antiguo procurador, renunció á su profesion hace diez años á causa de dolores de cabeza y de aturdimientos; es dispéptico desde hace muchos años y ha enflaquecido de 30 libras. Flebitis en la pierna izquierda, que ha durado tres meses.

El abate X..., de cuarenta y nueve años, sufria de dispepsia desde el seminario, de dolores de cabeza, y actualmente no puede leer ni escribir más de quince minutos seguidos sin tener una jaqueca. Flebitis en la pierna izquierda durante algunas semanas; más tarde, flebitis en la pierna derecha.

Otro enfermo, de edad de sesenta años, afectado de neuralgias del trigémino y de dispepsia hace largos años, presenta una flebitis *en la pierna derecha* que dura seis semanas.

No creo necesario citar otras observaciones; las anteriores muestran que la flebitis aparece habitualmente precedida de lejos por los síntomas de los centros nerviosos.

Lo mismo sucede con el edema; de ordinario aparece en la pierna izquierda, para desarrollarse luego en la derecha.

La señora C..., de treinta y un años, tiene vértigos y aturdimientos desde la infancia, padece corizas muy á menudo, es dispéptica y se queja de náuseas constantes. Edema de la pierna izquierda.

La señorita de M..., de veintitres años, tiene jaquecas y dispepsia desde la infancia; los dos tobillos están hinchados.

Flebitis y edema de los miembros inferiores significan irritacion de los centros y transmision á los vasos por los nervios vaso-motores; el edema se presenta algunas veces en los miembros superiores.

La clorosis no tiene otro orígen; la sangre no conserva su composicion normal sino con la condicion de que los centros nerviosos estén tranquilos, silenciosos: su irritacion trae consigo la disminucion del número de los glóbulos rojos; la curacion

de los centros es seguida del restablecimiento del número normal de glóbulos, sin que el médico tenga necesidad de añadir una sola partícula de hierro al alimento, que contiene siempre cantidad suficiente para las necesidades del organismo.

Hé aquí algunas observaciones que muestran la patogenia de la clorosis y la curacion de esta complicacion por el intermedio de los centros.

Una jóven de diez y siete años entra en el hospital Rothschild en 1885; consecutivamente á marchas excesivas sufre vértigos, neuralgias del quinto par, inapetencia, gases. El número de glóbulos sanguíneos habia disminuido; un ruido de soplo rudo se percibe en la base del corazon y en el primer tiempo. Esta enferma permanece en el hospital un mes, es sometida á un reposo absoluto y hé aquí su régimen: durante diez días se la nutre con leche y sopas sin carne. Despues de los primeros diez días se le da un litro de leche, 100 gramos de legumbres verdes, 100 gramos de carne y 200 gramos de pan en veinticuatro horas. Gracias á este régimen el plexo solar se calma, el apetito

vuelve, las neuralgias disminuyen, los vértigos cesan y las fuerzas musculares reaparecen. Al mismo tiempo que los fenómenos nerviosos disminuyen los ruidos cardíacos vuelven á su estado normal, y al fin del mes de tratamiento el número de glóbulos aumenta de 2 millones y la hemoglobina de 20 μ.

Lo mismo sucede con el caso siguiente. Una jóven de diez y ocho años, que sufre desde la infancia dolores de cabeza, vértigos, deslumbramientos y de dispepsia, presenta á su entrada en el hospital un ruido de roce en el primer tiempo (base del corazon), un soplo continuo en las carótidas. La sangre es muy pobre en glóbulos rojos, y cuenta por milímetro cúbico 2.950.000. Esta enferma permanece en el hospital dos meses sometida á la alimentacion siguiente: un litro de leche, 200 gramos de patatas machacadas, 70 gramos de pescado, 200 gramos de pan tostado, 50 gramos de carne, y guarda el lecho durante el tratamiento. Dos meses fueron suficientes para hacer cesar los vértigos y los dolores de cabeza, los ruidos cardíacos y vasculares: el número de glóbulos habia ascendido de 2.950.000 á

4.201.025, y la riqueza de la sangre en hemoglobina habia aumentado de 40$_{\mu}$ segun el hematóscopo de Hénocque.

Así pues, la clorosis se cura si los centros nerviosos se curan, y éstos exigen el reposo muscular y una alimentacion que no irrite al plexo solar; y en ese caso todo entra en órden, cerebro, médula, plexo solar, y la aglobulia, que es consecutiva, desaparece. El neurosismo aparece siempre el primero, y la clorosis es determinada por él.

VI

NERVIOS DE LAS GLÁNDULAS DE LA PIEL, DE LAS MUCOSAS, DE LA GLÁNDULA TIROIDES, DE LAS SEROSAS.—OVARIOS.—TESTÍCULOS.—RIÑONES.—PIEDRA.

Los nervios de las glándulas de la piel (glándulas sebáceas y sudoríparas) manifiestan sus desórdenes por fenómenos que se producen en muchas personas cuyos centros nerviosos están irritados.

La materia sebácea se secreta con exceso; he observado una mujer de treinta años que tenia vértigos constantes, dilatacion del estómago, flebitis; que vivia condenada á la inmovilidad, tal era la violencia de los vértigos que sufria, y que tenia toda la cara cubierta de una capa sebácea que desapareció cuando su salud se mejoró. En ciertas partes del cuerpo la

capa sebácea presentaba algunos milímetros de espesor.

Los sudores profusos son en extremo comunes: sudores de una parte del cuerpo, de una mitad de la cabeza, de la frente, de una mitad del cuerpo, de los pies solamente ó de las manos, sudores que indican el estado nervioso y que se producen en el día ó en la noche. Cuando son nocturnos, el enfermo moja la cama, y en ciertos casos tiene que cambiar de ropas, y si se acompañan de tos gutural, hacen temer, sin razon, la tuberculosis; pueden aparecer cada dos ó tres días, á la manera de los fenómenos nerviosos, ó ser cotidianos.

Los nervios de las glándulas implantadas en las mucosas, de las glándulas de la mucosa de la nariz, de la lengua, de la faringe, de la laringe, de los bronquios, de las glándulas anexas á las mucosas (glándulas lacrimales, salivares, hígado, etc.), resienten siempre las impresiones de los centros nerviosos irritados.

Tan pronto como un individuo presenta algun fenómeno encefálico, puede ser atacado por un coriza; la lengua se cubre de una capa saburral, la secrecion de la fa-

ringe y de la laringe se agota, la de los bronquios aumenta de tal modo, que se encuentran enfermos que esputan dos ó tres vasos ó mayor cantidad de líquido espumoso secretado por las glándulas bronquiales; la secrecion de las glándulas lacrimales y salivares aumenta tambien, la ictericia se produce sin causa apreciable, testimonio de la accion de los centros sobre los nervios del hígado. En la mujer los flujos leucorreicos, las pérdidas seminales en el hombre, manifiestan igualmente la irritacion de los centros nerviosos.

Pero no sólo las glándulas que vierten sus secreciones al exterior son perturbadas en su funcionamiento por los centros nerviosos. Hay células glandulosas, tales como las células de las serosas (pleura y sinoviales de las articulaciones), cuyas secreciones quedan en el organismo para facilitar su funcion, que sufren tambien los efectos de los centros nerviosos. En muchos enfermos he observado la pleuresía como primera manifestacion de la irritacion nerviosa, precediendo los síntomas de los centros que no se desarrollaron hasta más tarde; en otros casos esta inflamacion apareció cuando los síntomas nerviosos

existian ya hacia años; la menor impresion de frío, la menor fatiga, es en estos nerviosos causa de pleuresía. Lo mismo sucede con la hidartrosis y los crujidos articulares: la hidartrosis de la rodilla izquierda, la de la derecha menos á menudo, precede ó sigue los fenómenos nerviosos; los crujidos articulares son peculiares á los nerviosos en las articulaciones vertebrales ó en las extremidades (rodillas, manos, pies), etc., etc.

La hipertrofia de la glándula tiroides, el bocio, se observa como consecuencia del neurosismo; la afeccion, que ha sido descrita en estos últimos años con el nombre de bocio exoftálmico, parece tener el mismo orígen. Asisto á tres señoras nerviosas, de las cuales dos tienen la hipertrofia sencilla y la tercera tenia un bocio exoftálmico: éste ha cedido poco á poco, y ha ido disminuyendo á medida que los centros nerviosos se restablecian; en cuanto á las dos primeras, la glándula tiroides se ha quedado tal como estaba con su volúmen ampliado.

El ovario, el testículo, órganos esenciales á la generacion, son afectados en sus funciones en muchos nerviosos; la esterili-

dad es un hecho en extremo comun, y que me parece tener por causa la mal formacion de la célula ovárica ó testicular y de sus productos secretorios.

En resúmen, todas las glándulas del organismo, que no valen más que por sus secreciones, secreciones de toda especie, entre las cuales unas sirven á eliminar los materiales nocivos al organismo, otras á llenar ciertas funciones (serosas), á facilitar la movilidad de ciertos órganos (pulmones), de las articulaciones; otras, esenciales en el acto de la procreacion (ovarios, testículos), y algunas, en fin, que tienen un papel aun mal determinado (glándula tiroides), pueden ser sucesivamente afectadas por el neurosismo; pero hay una glándula que no escapa nunca á su influencia: el riñon.

Tan pronto como los centros se irritan, la secrecion urinaria se altera en su cantidad y en su composicion química; la glándula renal presenta un interés de observacion particular.

El riñon y el pulmon contribuyen á eliminar la mayor parte de los materiales que han servido á la nutricion; son los dos órganos esenciales de eliminacion de todos

los elementos que no pueden ya servir al organismo, y que si permaneciesen en él serian rápidamente tóxicos. No he estudiado los productos eliminados por el pulmon en el neurosismo, pero sí los que pasan por el riñon; he dosado la cantidad de orina excretada y he analizado su composicion química.

Hé aquí lo que demuestra este análisis:

1.° La cantidad de orina disminuye notablemente si los centros están irritados; rara vez esta cantidad aumenta notablemente, y llega á 3 litros ó más en veinticuatro horas, en lugar de 1.200 gramos, cifra ordinaria en el estado fisiológico.

La cantidad de orina excretada aumenta poco á poco, desde que por el tratamiento los centros se calman, y tiende á volver á la cifra de 1.200 gramos.

2.° La composicion química de la orina se modifica profundamente; la cantidad de urea que representa la mayor parte de los materiales albuminoideos desasimilados disminuye enormemente, pero tiende á volver hácia la cifra normal, 28 gramos en veinticuatro horas, á medida que el sistema nervioso se restablece.

El ácido úrico pierde su solubilidad y se

precipita con la mayor facilidad en el riñon, en la vejiga. De aquí los cólicos nefríticos; la mayor parte de los nerviosos, en el momento de los grandes sufrimientos sobre todo, se quejan de orinar en pequeña cantidad y de que su orina deposita abundantes precipitados rojos.

La influencia sobre la composicion química de la orina no se manifiesta sólo en los cambios de proporcion de los productos normales (urea, ácido úrico), sino que á menudo tambien aparecen productos anormales (azúcar y albúmina). He encontrado la glucosa en la dosis de 15 á 20 gramos por litro; la albúmina se encuentra algunas veces en la dosis de 4 á 5 gramos por litro; 1 gramo por litro es bastante comun. La diabetes y la albuminuria provocadas por el neurosismo son afecciones pasajeras, curables, que duran tanto como la irritacion de los centros.

El análisis de la orina demuestra que la alteracion es consecutiva á la irritacion nerviosa y que vuelve á su composicion normal tan pronto como el sistema nervioso se cura, poniendo en evidencia el hecho fisiológico que la nutricion está ligada íntimamente con los centros nerviosos y

que depende de ellos. Como no podemos apreciar directamente la nutricion, la asimilacion, é ignoramos las trasformaciones de los alimentos en el cuerpo, su accion útil, no nos damos cuenta de la nutricion, de la asimilacion sino por los productos de desnutricion, de desasimilacion; por estos productos solos podemos juzgar la nutricion, y estudiando los elementos de la orina llegamos á saber que el alimento no tiene efecto útil en cuanto los centros nerviosos están irritados, y que en lugar de desembarazar al organismo, para mantener su salud, de la cantidad habitual de urea, la orina contiene una cantidad infinitamente menor, así como, por el contrario, contiene con frecuencia elementos patológicos, el azúcar y la albúmina.

He citado ya observaciones de diabetes y de albuminuria en mi tratado *Estómago y cerebro;* daré á conocer aquí algunos hechos que demuestran las variaciones en la cantidad de orina y de urea, haciendo ver al mismo tiempo que el individuo nervioso que ha enflaquecido por su padecimiento aumenta de peso á medida que se cura, y que el individuo obeso por efecto de la enfermedad nerviosa enflaquece progresiva-

mente á medida que vuelve al estado fisiológico.

La clínica nos enseña que el sistema nervioso preside las reacciones químicas del organismo, dirigiendo las modificaciones del alimento, y que si su intervencion es imperfecta el alimento no llega á producir su efecto. En este caso, á pesar de una alimentacion exagerada, la nutricion será siempre defectuosa é insuficiente.

1.° *Cantidad de orina y de urea producida en veinticuatro horas.*—Una enferma del hospital Rothschild, de veintidos años de edad, clorótica, sufre de dolores de cabeza, calambres en los miembros inferiores. La auscultacion revela un ruido de soplo rudo en el corazon y un ruido continuo en las carótidas; al mismo tiempo es dispéptica. En veinticuatro horas secreta 350 gramos de orina. Conteniendo un litro de esta orina 7 gramos de urea, esta enferma no elimina más que $2^{gr},45$ de urea por dia. Alimentada con dos litros de leche, sopas y café, todos los síntomas nerviosos se mejoran. Al cabo de siete días la cantidad de orina se eleva de 350 á 950 gramos. El litro de orina contiene entonces 12 gramos de urea. La carne en la dosis de 60 gramos

viene en este momento á formar parte de la alimentacion, así como los feculentos en la dosis de 100 gramos en veinticuatro horas. Al cabo de quince días la cantidad de orina asciende á 1.200 gramos, conteniendo 16 gramos de urea por litro; al cabo de treinta días la cantidad de orina es de 1.400 gramos, y la cantidad de urea de $17^{gr},5$ por litro: la enferma elimina en esta época 24 gramos de urea en veinticuatro horas.

La cantidad de urea crece progresivamente, y este aumento es paralelo á la disminucion de los síntomas nerviosos; la urea no ha aumentado porque hayamos aumentado la alimentacion; los alimentos no producen la urea sin el consentimiento de los centros nerviosos; este es un hecho observado por mí en numerosas ocasiones. La enferma ha engordado al mismo tiempo que la cantidad de urea ha aumentado; pesaba el primer día 50 kilógramos, el octavo 52, el décimoquinto 54 kilógramos; á los veintiun días su peso habia subido á 55 kilógramos, en fin, á los treinta días pesaba 56 kilógramos.

Otra enferma de veinticinco años presentaba zumbidos en el oído izquierdo, insomnios, dolores articulares, no tenia ape-

tito y eructaba todo el día. Permanece cuarenta días en el hospital, y se la nutre durante ocho días con un litro de leche, dos huevos y 60 centílitros de caldo por veinticuatro horas.

8	días	despues	orina	750 gr.	conteniendo	12gr,7	de urea.
21	—		—	1.100 —	—	16 ,7	—
27	—		—	950 —	—	18 ,9	—
35	—		—	1.050 —	—	20 ,8	—
42	—		—	1.000 —	—	21	—

La cantidad de urea aumenta, pues, de una manera continua.

Desde el octavo día la alimentacion fué modificada del modo siguiente: durante ocho días, al litro de leche y á los huevos se añadió una chuleta de carnero por día, y el régimen alimenticio fué completado hácia el décimoquinto día, á peticion de la enferma, con 50 gramos de patatas machacadas y 100 gramos de pan.

La cantidad de urea aumentó lentamente; encontré este aumento de tres en tres días: la enferma habia engordado 5 libras en veintisiete días y 8 libras á los cuarenta.

Otra enferma de diez y ocho años se queja de deslumbramientos, de palpitaciones; es clorótica y dispéptica. Se la somete al

régimen siguiente: un litro de leche, 50 gramos de carne, 200 gramos de patatas y 100 gramos de pan tostado. El primer día elimina 20 gramos de urea y el octavo día 22 gramos; pesaba 54 kilógramos el primer día y 57 kilógramos veintiun días despues, y no engorda más.

Sea cualquiera la edad del individuo, los fenómenos nerviosos que significan irritacion de los centros tienen la misma influencia sobre la nutricion, disminuyen la urea que no vuelve á la cifra normal hasta la curacion de la enfermedad nerviosa.

Un hombre de sesenta y tres años fué atacado hace siete meses, á consecuencia de una gran emocion, de dolores de cabeza horribles en la mitad derecha del cráneo, de dolores en los nervios cervicales y del quinto par, de contractura de los músculos cervicales; no duerme desde entonces, y es dispéptico. La medicacion con preparaciones de opio, y los vejigatorios prescritos anteriormente, no modificaron en nada el estado de este desgraciado. Le hice cinco lavados del estómago de ocho en ocho días, y fué alimentado al principio con litro y medio de leche y dos tortas *(échaudés)*; doce días despues se añadieron

100 gramos de carne y legumbres. Al cabo de tres semanas de tratamiento empezó á dormir.

La urea permaneció:

6 dias á 25 gramos por litro.
10 — 26 —
17 — 27 —

Y llegó á la cifra 29 gramos para quedar estacionaria. El peso de este enfermo, que era de 67 kilógramos á su entrada en el hospital, creció poco á poco hasta 69 kilógramos, y llegó á 70 para no aumentar más.

Si se somete al enfermo á condiciones higiénicas que aseguren el reposo de los centros nerviosos, si se regulan sus movimientos, su alimentacion, el sistema nervioso se restablece y la urea sube constantemente hasta 28 ó 29 gramos en veinticuatro horas. La irritacion de los centros determina el descenso de la urea á 3 y 4 gramos en el mismo tiempo. Al par que la urea vuelve á la cantidad normal, el individuo recupera su peso ordinario.

Pero la irritacion de los centros puede producir la obesidad lo mismo que determina el enflaquecimiento.

La obesidad es la expresion de sufrimiento de los centros nerviosos lo mismo que el enflaquecimiento; la acumulacion de grasa en exceso indica una nutricion defectuosa; la obesidad cesa en cuanto los centros nerviosos se restablecen.

La obesidad tiene la misma significacion clínica, la misma patogenia que el enflaquecimiento.

No citaré más que un caso de obesidad coincidiendo con la disminucion de urea y disminuyendo con el aumento de la cantidad de ésta.

En enero de 1886 entra en el hospital una mujer de treinta y un años, obesa. Tiene dolores de cabeza, está triste, los centros nerviosos abdominales son dolorosos á la presion y hace un año ha tenido una pleuresía. Las paredes abdominales están cargadas de grasa. Anuncié á mis alumnos que esta mujer enflaqueceria por el régimen y que la grasa disminuiria: mis previsiones se confirmaron.

Hé aquí su alimentacion: durante diez días se le da un litro de leche, dos huevos y 70 centílitros de caldo; al cabo de ese tiempo se añade 200 gramos de carne, 250 gramos de fécula y 500 gramos de pan.

El primer dia rendia 350 gr. de orina y 8 gr. de urea por litro.
50 dias despues — 1,600 — — 31 — —
El primer dia pesaba 59 k,500.
A los 50 dias — 54 k,500.

Todo es conexo en el organismo: la enfermedad de los centros nerviosos altera la nutricion, disminuye la urea, enflaquece ó engorda; pero tan pronto como aquéllos se restablecen, la nutricion vuelve á la normal, la urea marcha hácia la cifra fisiológica, aunque la cantidad de urea puede aumentar y sobrepujar el número 28 ó 30 si el individuo consume gran cantidad de carne; pero este exceso de alimentacion, cuando dura mucho tiempo, irrita á los centros y la nutricion sufre, de modo que la cantidad de urea disminuye entonces y cae por bajo de la cifra normal. El sistema nervioso regula la desnutricion, y en cuanto está atormentado, aquélla se falsea y el individuo enflaquece ó engorda. Todo se rehace al mismo tiempo: la cifra normal de la urea, el engordamiento ó el enflaquecimiento.

Por más que el médico intervenga con una alimentacion excesiva, con medicamentos, si el alimento ó el medicamento no es adecuado al sistema nervioso todos sus

esfuerzos serán perjudiciales y agravarán el estado del enfermo; la medicacion expoliatriz, los purgantes, los baños de vapor son funestos al obeso; le hacen enflaquecer durante algun tiempo, pero aumentan la enfermedad. Son medicamentos de un síntoma no comprendido: la carne cruda, el vino, que triplican la irritacion de los centros, exageran á menudo el enflaquecimiento despues de haberlo combatido durante cierto tiempo. Un enfermo tomaba cada día para engordar 10 litros de leche, 10 huevos, dos platos de carne en el almuerzo y un plato de carne y otro de pescado en la comida, y sin embargo no engordaba: sus centros nerviosos estaban perturbados y permanecian en ese estado á causa de la alimentacion excesiva; se trata de un jóven de veintisiete años que habia perdido la memoria, no podia prestar atencion á lo que leia y eructaba con frecuencia. Nosotros no reconstituimos el sistema nervioso con el alimento.

El médico no debe perder de vista el sistema nervioso, que debe suministrar todas las indicaciones terapéuticas; sin su concurso el médico es de todo punto impotente, y de nada sirve administrar gran-

des cantidades de alimentos ó numerosos medicamentos.

Litiasis úrica, fosfática y oxálica.

Al mismo tiempo que la cantidad de orina y de urea disminuyen, las concreciones úricas, fosfáticas y oxálicas se precipitan en los canales del riñon encargado de eliminarlas en la vejiga.

La presencia de estas sales en la orina y su acumulacion en el riñon traen consigo esos cólicos nefríticos incesantes que atormentan á ciertos enfermos; ni un cambio de alimentacion es capaz de hacerlos desaparecer, ni la profesion sedentaria es su causa.

La litiasis renal tiene su orígen en los centros nerviosos y desaparece sólo gracias á estos centros.

En cuanto un fenómeno nervioso intenso se produce, la orina presenta posos de una de estas sales; y por más que el enfermo que elimina oxalatos se prive de comer alimentos que contengan sus elementos, los oxalatos continuarán produciéndose.

He sido consultado por un enfermo de treinta y dos años que ha tenido una serie de cólicos nefríticos. Desde la edad de doce años sufria de dolores de cabeza, vérti-

gos, dolores de la rodilla y del pie derecho que le obligaron á guardar el lecho durante tres semanas; actualmente tiene la vista turbada y sufre crisis de dos horas, durante las cuales permanece ciego; á la crisis sigue el dolor de cabeza, todos los centros nerviosos abdominales acusan dolor, el enfermo tiene por momentos un apetito voraz, eructaciones y orina á cada instante.

Otra enferma expele orinas que depositan una enorme cantidad de uratos; tiene cuarenta y dos años, no duerme, sufre una hiperestesia generalizada de la piel, neuralgias intercostales, dolores en los brazos, accesos de fiebre y náuseas.

Citaré un tercer enfermo que orina arenas con dolores terribles del cuello de la vejiga; tiene cincuenta y tres años, sufre vértigos, zumbidos en los dos oídos, eczema en las dos orejas; no tiene apetito y eructa.

Aunque el cólico nefrítico puede ser accidental, pasajero, habitualmente acompaña á la fenomenología de los centros nerviosos; no constituyendo una enfermedad aislada, independiente, sino una consecuencia de la nutricion viciosa del individuo, de la química patológica del organismo, cuya

causa está en el sistema nervioso. Unas veces los uratos, otras los fosfatos ó los oxalatos, se precipitan. El médico, interviniendo con remedios, no podrá ejercer influencia alguna sobre las reacciones químicas, que dependen sólo de los centros nerviosos.

CAPITULO VIII

FIEBRE

Ningun síntoma desconcierta tanto al médico como la fiebre cuando aparece todos los días, cada dos días ó á intervalos mayores, si aparece diariamente con frío, calor y sudores. Interroga entonces á todos los órganos para descubrir alguna lesion que le explique la fiebre, y si no encuentra ninguna, su desconcierto aumenta; espera una fiebre eruptiva que no aparece, y su expectacion se defrauda; busca alguna infeccion pantanosa que le haga descubrir la fiebre palustre; en fin, si apercibe algun signo de la fiebre tifoidea, dolores de cabeza, vértigos, insomnios, teme su invasion; pero observando con cuidado la evolucion de la enfermedad, no encuentra á menudo las

oscilaciones de la temperatura ni la ascension lenta que caracterizan á la tifoidea, y no se cree autorizado á diagnosticarla. Además, la fiebre que no se presenta más que por la tarde, ó en la noche solamente, ó con frecuencia por la mañana, no puede ser atribuida á una infeccion que la haria continua. En muchos casos la fiebre, apareciendo con la irritacion de los centros, dura ocho, quince dias, y se acompaña con inapetencia y lengua sucia; esta fiebre ha sido hasta hoy denominada gástrica, biliosa, catarral, etc., y se ha formado un grupo particular.

Que el médico la observe con todos los síntomas nerviosos que la acompañan, y reconocerá que ella se liga á la irritacion de los centros.

Una señora de cuarenta y ocho años tiene fiebre todos los días (39°); de largo tiempo los centros nerviosos están irritados; sufre dolores de cabeza, vértigos, insomnios, debilidad de la memoria, está casi sorda del oído derecho, tiene un catarro nasal crónico, palpitaciones, carece de apetito, el plexo es doloroso y la enferma experimenta una sensacion de

bola que parte del estómago y sube á lo largo del esófago; en fin, tiene eructaciones.

Una señora de treinta y dos años tiene accesos de fiebre cada dos días, y desde largos años dolores de cabeza, aturdimientos, la vista turbada, zumbidos de oídos y gases.

Una mujer de veintiseis años, que está enferma desde hace cuatro, tiene un acceso de fiebre cada noche, no duerme, tiene zumbidos de oídos, anorexia, el plexo está doloroso, el estómago inflado y tiene diarrea.

En fin, una enferma de veintinueve años tiene un acceso de fiebre diario y dolores de cabeza, deslumbramientos, raquialgias, dilatacion del estómago y sufre despues de la comida.

La fiebre aparece, pues, con la irritacion de los centros, unas veces diaria, simulando la fiebre tifoidea, otras intermitente, haciendo pensar en una fiebre palustre, porque el sulfato de quinina la hace desaparecer; otras, en fin, en que se la denomina fiebre gástrica, biliosa, y se atribuye al estómago ó al hígado, que no hacen más que soportar la influencia de

los centros nerviosos. La fiebre puede no aparecer más que cada quince días, cada mes, más rara vez aún como consecuencia de fatiga. Puede preceder los síntomas de los centros mismos y ser el primer signo de la irritacion de éstos, manifestándose antes que cualquier otro fenómeno. Pero cómo se relaciona la fiebre con la irritacion de los centros, no lo sabemos; la irritacion es muy frecuente sin fiebre, pero con alguna frecuencia tambien este fenómeno viene á complicarla.

Nada conocemos de la naturaleza íntima de la fiebre. No estamos mucho más adelantados que Hipócrates, que la juzgaba por el calor del cuerpo; la apreciamos con el termómetro y sabemos la desnutricion que produce, las pérdidas orgánicas que suscita en los tejidos, el aumento de la urea, del ácido carbónico, etc. Tiene un efecto inverso al de la irritacion de los centros, que los disminuye y determina, los desórdenes funcionales del corazon, del pulmon, etc.

Pero es importante saber que la fiebre es una complicacion bastante frecuente de la irritacion de los centros nerviosos, y que

se observa mucho más á menudo que la fiebre tifoidea; en muchos casos es difícil distinguirlas. El termómetro sólo puede guiar al médico.

CAPITULO IX

EVOLUCION DE LA IRRITACION DE LOS CENTROS NERVIOSOS

Origen cerebral.—Origen medular.—Origen en los centros abdominales.

En el estado de salud, los centros nerviosos y los nervios funcionan sin ser sentidos; por el cerebro el hombre siente, piensa y quiere; por la médula el hombre se mueve y las vísceras trabajan; por el sistema nervioso abdominal el alimento se digiere, se absorbe, y sus elementos inútiles son expulsados, etc. Los nervios trasmiten á los centros las impresiones y unen los centros unos con otros, de manera que todo fenómeno que se produce en uno de éstos llega siempre al cerebro para que el

hombre tome conocimiento de él. Esta elaboracion colosal de todo el sistema nervioso, los millares de impresiones que recibe se confunden todas en una, se resumen en una sola sensacion de bienestar, satisfaccion del *yo*; pero si por una de las causas que he indicado más arriba uno de los centros trabaja con exceso se irrita, é inmediatamente, en virtud de la unidad del sistema nervioso, la irritacion se comunica á los otros centros; todos se irritan, los nervios pueden hacerse sucesivamente dolorosos; nervios, músculos, articulaciones, piel, mucosas, vísceras, enferman, y un estado patológico complejo, cuya fisonomía puede variar en extremo, sucederá á la salud. Todas las partes del cuerpo que no se sentian mientras los centros estaban tranquilos se hacen dolorosas, y permanecerán en este estado tanto tiempo cuanto los centros nerviosos se mantengan irritados. La salud volverá con el equilibrio de estos centros.

He hecho conocer los principales síntomas consecutivos á esta irritacion; importa saber cómo empieza para que el médico intervenga prontamente y pueda atajar el mal.

La evolucion de la irritacion es muy regular; empieza unas veces por uno de los centros nerviosos, cerebro, médula ó centros abdominales; otras veces por un nervio periférico, y se anuncia por una neuralgia, neuralgia del quinto par, intercostal, dorsal ó ciática, etc.; en otros casos los nervios de las mucosas se afectan: coriza, tos espasmódica, falso crup del niño, palpitaciones ó un acceso de asma en el adulto, constituyen las primeras manifestaciones de la irritacion. Todos estos hechos patológicos, y una serie de otros que podria citar, no deben sólo ser considerados en sí mismos, sino que deben referirse además á su orígen. El médico puede curar el falso crup, el asma; pero mientras los centros nerviosos no hayan vuelto á su estado de equilibrio, una nueva enfermedad se producirá más ó menos pronto.

Importa observar la irritacion en el niño primero, y la mostraré en todo su desarrollo en el adulto ó en la virilidad cuando el mal ha crecido libremente.

La evolucion de la irritacion se hace con la mayor regularidad y sigue una marcha fatal, idéntica para todos los enfermos.

1.° La irritacion empieza por lo comun en el cerebro, y se trasmite á la médula y al plexo solar.

2.° La irritacion del cerebro puede comunicarse á los centros nerviosos periumbilicales respetando al plexo solar.

3.° Puede empezar en la médula y pasar al cerebro y al plexo.

4.° Cuando la irritacion aparece primero en el plexo ó en uno de los centros periumbilicales, se comunica luego al cerebro ó á la médula.

5.° Si uno de los centros está violentamente irritado, los otros responden á esta irritacion por fenómenos muy atenuados.

6.° Hay alternaciones continuas entre la irritacion de los centros.

Voy á demostrar al lector por medio de hechos clínicos la exactitud de estas diversas proposiciones; y por hechos clínicos tambien le mostraré el proceso de la irritacion, que no puede comprenderse sin la observacion del enfermo.

La irritacion empieza en la más tierna infancia, y se desarrolla progresivamente si una sana higiene no interviene.

La presentaré primero en el niño, luego

en las diversas edades de la vida, cuando ha tenido tiempo de desarrollarse por no haber sido detenida en su evolucion.

Para estudiarla en los primeros años de la vida he examinado una escuela de 96 huérfanos, donde son admitidos desde la edad de cuatro años (varones y hembras), permaneciendo en ella hasta diez y ocho ó veinte años. Todos son considerados como válidos; todos trabajan, estudian, hacen gimnasia y tienen la misma alimentacion.

De los 96 no hay realmente más que 18 que tienen una salud perfecta; 76 presentan ya ciertos fenómenos que indican la irritacion de los centros nerviosos; 30 tienen dolores de cabeza en la frente, en el occipucio, que aparecen cada mes una ó dos veces ó cada semana una vez ó dos. Estos niños que sufren de la cabeza frecuentemente son, segun las noticias del director, indolentes, de carácter triste, faltos de actividad y presentan ya signos graves de irritacion cerebral. Entre estos últimos muchos tienen el plexo irritado.

La irritacion cerebral no se manifiesta siempre por síntomas propios al cerebro, sino que se manifiesta á distancia por la irritacion del plexo.

De 76, 29 tienen ya el estómago enfermo; 11 tienen el plexo solar doloroso y un apetito mediano, caprichoso, voraz por momentos; uno tiene náuseas continuas; 7 tienen el estómago enfermo y lleno de líquido.

De 76 hay 7 (y son principalmente las niñas, cuya menstruacion comienza á establecerse) que tienen el centro subumbilical doloroso á la presion.

Un fenómeno comun á estos niños es el estrabismo, que aparece cuando el cerebro está irritado y desaparece cuando se calma, pues los músculos del globo ocular se contracturan bajo la influencia del cerebro y la contractura puede hacerse persistente; 8 de estos niños tienen estrabismo, 4 del ojo izquierdo, 3 del derecho y 1 doble, pero no tienen dolor de cabeza ni ningun otro fenómeno, de modo que el estrabismo es el primer signo de la irritacion cerebral.

Entre ellos, algunos tienen la médula primitivamente irritada, habiendo notado cuatro veces saltos del hombro, de un brazo, pestañeo, temblor de manos, contracciones involuntarias de los músculos de la cara; 3 están afónicos hace muchos meses,

1 dos años, y el tratamiento local (revulsivos, electricidad, medicamentos) aconsejado por Krishaber no ha tenido ningun resultado; 7 tienen hiperestesia de la piel y de los músculos de la mitad izquierda del cuerpo; 7 tienen incontinencia de orina.

Hé aquí la expresion variada de la irritacion de la médula. Pero los centros irritados no se manifiestan sólo en los nervios y músculos de la periferia; con frecuencia, los nervios cardíacos y los nervios vasomotores son únicamente los atacados.

De 76, 44 no presentan otro síntoma más que palpitaciones, ruidos de soplo cardíaco ó vascular ó ambos reunidos. He contado hasta 130, y algunas veces 150 pulsaciones por minuto; los ruidos del corazon son irregulares, intermitentes, se siguen sin reposo; en la base del corazon ó en su punta se percibe un ruido de soplo suave ó rudo, y el soplo en la carótida es continuo ó existe sólo en el primer tiempo, siendo más ó menos intenso y en algunos casos silboso.

Hé ahí la clorosis que empieza en los niños como primer síntoma del neurosismo, y que tiene la misma patogenia que el

estrabismo, los temblores musculares, etc., y el mismo orígen en la irritacion de los centros.

Estos diferentes hechos patológicos que acabo de enumerar indican un sistema nervioso ya afectado, y representan el primer período del neurosismo, que aumentará si la higiene del espíritu y del cuerpo es defectuosa.

Sigamos la afeccion en el adulto, cuando ha adquirido todo su desarrollo y cuando todos los centros participan de los desórdenes.

Presentaré algunas observaciones de enfermos que han venido á consultarme.

En los unos el neurosismo ha empezado por el cerebro, en los otros por la médula, en muchos, en fin, los centros abdominales han sido irritados en primer término.

I

ORÍGEN CEREBRAL

1.° Un enfermo de veintisiete años de edad me cuenta que, á consecuencia de emociones continuas, padece hace seis años de aturdimientos, y que desde esa época su vista se ha debilitado; tiene actualmente un coriza continuo, la piel y los músculos del brazo y del dorso están hiperestesiados, todos los músculos del cuerpo saltan á ciertas horas del día. El estómago está dilatado hasta el ombligo y lleno de líquido; el enfermo sufre de náuseas y de gases. Los tres centros nerviosos, cerebro, médula y plexo, están irritados.

2.° Un jóven de veintisiete años, fatigado por el trabajo, tiene hace dos años zumbido de oídos que dura ocho días é insomnio; el primer día la médula ha sido

atacada al mismo tiempo que el cerebro, y el enfermo ha resentido un choque en el brazo y en la pierna izquierda; desde hace dos años carece de apetito, sufre despues de la comida y tres veces por semana vomita los alimentos.

3.° Un hombre de cuarenta y cinco años presenta á los cuarenta un vértigo que dura tres días, durante el cual no ve más que la mitad de los objetos. El vértigo se reproduce todas las semanas. El enfermo tiene sensacion de hormigueo en la piel del brazo, y cuatro horas despues de comer sufre calambres de estómago y arroja gases todo el día.

En estos tres casos la irritacion ha empezado por el cerebro y se ha propagado á los tres centros; un síntoma cualquiera de irritacion cerebral de los ya descritos, cefalalgia, vértigo, aturdimientos, etc., es el signo cerebral precursor de la irritacion de los otros dos centros.

Citaré, por último, un caso que dura hace treinta y siete años; desde esa época, todos los centros están afectados.

Un hombre de cuarenta y nueve años sufre, desde la edad de doce, de hiperestesia de la retina con crisis dolorosas que

ocasionan la pérdida del conocimiento; desde la edad de doce años tiene vértigos que duran un minuto, dolores de cabeza constantes, con sensacion de vacío y de constriccion del cráneo; la memoria, el pensamiento y la voluntad están debilitados, y desde hace diez años el enfermo se nutre con leche por no poder tolerar ningun otro alimento sólido.

II

ORÍGEN MEDULAR

En muchos enfermos la irritacion de la médula aparece la primera. He hablado ya de los que padecen dolores que se extienden á las extremidades de los miembros superiores, ó dolores de la espalda, de los lomos, que se propagan hasta las rodillas, las articulaciones del pie; dolores de músculos ó de nervios. Estos pacientes son invariablemente clasificados bajo el título de reumáticos; los patólogos han hecho una entidad morbosa de los dolores múltiples cuyo orígen es la irritacion de la médula, y los han atribuido al reuma. El reuma comprende todos estos hechos patológicos; el reuma, cuya significacion, cuya naturaleza no ha podido ser definida nunca, porque no se ha conocido la irritacion de

la médula. Citaré un solo caso típico que permitirá comprenderlos todos.

Una señora de cincuenta y un años, que ha cesado de tener sus reglas hace dos años, me dice que desde hace veinte, poco más ó menos, sufre de dolores musculares en las pantorrillas y que se extienden á los dedos de los pies; estos dolores cesan súbitamente y aparecen en los brazos; la enferma experimenta constantemente una sensacion de inquietud en los miembros y no puede tenerlos tranquilos ni de día ni de noche; su sueño es defectuoso. Los dolores desaparecen inopinadamente, y son reemplazados por una sensacion de quemadura á lo largo del esófago. Aunque el apetito es normal, la enferma vomita todos los días cierta cantidad de líquido.

III

ORÍGEN EN LOS CENTROS NERVIOSOS ABDOMINALES

En la mujer, la irritacion empieza con más frecuencia en el plexo lumbo-aórtico y pasa al plexo solar, que á su vez irrita, sea al cerebro, sea á la médula, determinando un conjunto de fenómenos nerviosos que han sido agrupados sin razon bajo el nombre de histerismo, y que se manifiesta, ora por una crisis nerviosa cerebral, ora por una crisis medular debida al plexo y que se desarrolla despues de una comida. El lector comprenderá fácilmente con la observacion clínica estos hechos que se desenvuelven en los centros nerviosos y que tienen en ellos su orígen.

1.° Una jóven de diez y nueve años que tiene el plexo solar doloroso experimenta

inmediatamente despues de comer una hinchazon del estómago, y cada tres días, despues de la comida, el cerebro se manifiesta por la irritacion que le es propia; esta jóven pierde toda voluntad, no puede moverse, permanece con los ojos fijos durante un cuarto de hora y llora. Su apetito ha aumentado, es voraz por momentos y come á cada instante.

2.° Una mujer de cuarenta años (plexo doloroso) sufre cuatro horas despues de la comida de sensacion de peso en la cabeza y llora.

3.° Una mujer de veintiseis años, dispéptica desde hace tres, siente su estómago pesado cuatro horas despues de comer, dos veces por día; á media noche tiene zumbido de oídos y pierde la vista durante algunos minutos; todo el lado izquierdo del cuerpo está hiperestesiado.

4.° Una mujer de cuarenta y tres años tiene regurgitaciones continuas; tres horas despues de comer siente una bola que sube hácia la garganta, y sufre en ese momento de dolores de cabeza, vértigo, desórdenes visuales; las mandíbulas se contracturan y los miembros están pesados.

En estos últimos casos el cerebro y la

médula se irritan bajo la influencia del plexo; en algunos otros la médula se irrita aisladamente por la irritacion del plexo debida á la comida.

5.° Un hombre de cincuenta y ocho años, dispéptico desde hace veinte, tiene despues de comer dolores en el estómago y luego calambres en el muslo derecho que pasan al izquierdo, y por último un temblor general. El estómago está dilatado y el hígado congestionado.

6.° Un hombre de cincuenta y cinco años, que tiene el estómago dilatado y lleno de líquido, inapetente, se despierta en la noche por hinchazon del estómago, salivacion abundante, dolores en medio de la espalda, en los dedos de la mano y calambres en las pantorrillas; tiene desasosiego y abandona el lecho precipitadamente.

Hé ahí un número suficiente de hechos para comprender la marcha de la irritacion, su diverso orígen en los diferentes centros nerviosos; para concebir cómo obran éstos unos sobre los otros, para producir esta sintomatología compleja con la que se ha imaginado un número infinito de entidades patológicas especiales, neurastenia,

histerismo, etc.; sintomatología cuya naturaleza y significacion no ha podido ser explicada hasta hoy, á pesar de su precision y de que se observa cada día, presentándose á cada instante á la atencion del clínico.

Las comidas no son siempre seguidas de una crisis cerebral ó medular; con frecuencia determinan sólo la aparicion de un fenómeno cerebral ó medular, como dolor de cabeza, vértigos, aturdimiento, pérdida de conocimiento, zumbido de oídos, incapacidad de reflexionar, de recordar, de querer, el insomnio ó pesadillas; la comida puede ser seguida de un fenómeno medular, neuralgia dentaria, facial, intercostal, lumbar. Si la hiperestesia existe en una parte cualquiera del cuerpo, se hace más viva despues de la comida; un hombro se hace doloroso, una neuralgia se exagera, etc. En una palabra, síntomas cerebrales y medulares pueden producirse simultánea ó individualmente por la irritacion del plexo. Los músculos, los nervios, pueden hacerse dolorosos por la misma causa.

Un centro nervioso puede empezar la irritacion y trasmitirla á los otros centros,

ó despertar el dolor en los nervios y músculos que dependen de él.

He insistido sobre la influencia del cerebro y de la médula sobre el plexo, así como sobre la influencia del plexo cerca del cerebro y de la médula.

Creo deber indicar aún por la observacion la accion directa del cerebro ó de la médula sobre los centros nerviosos periumbilicales y subumbilical.

1.° Una señora de cincuenta y cinco años tiene desde hace diez vértigos, el plexo no está sensible, las funciones del estómago se ejecutan sin dificultad, pero los dos centros nerviosos periumbilicales son dolorosos á la presion; la enferma hace cinco ó seis deposiciones líquidas cada día.

2.° Una señora de veinticinco años sufre de raquialgia, de dolores á lo largo de la columna vertebral, en los brazos y en las piernas. El centro umbilical izquierdo es sensible á la presion; todos los días esta enferma tiene cólicos seguidos de dos ó tres deposiciones diarreicas.

Inversamente, uno de los centros periumbilicales puede ser irritado en primer lugar, y la irritacion del plexo, de la médu-

la, del cerebro, pueden no aparecer hasta más tarde.

Estas observaciones clínicas permiten comprender el encadenamiento de todos los centros, de todos los nervios, la unidad del sistema nervioso, pues que uno cualquiera de sus fragmentos no puede ser perturbado sin que en su totalidad el sistema resienta sus efectos. Hasta el presente este sistema ha sido dividido de modos diversos, y la patología no ha hecho más que estudiar los síntomas de estos elementos aislados, sin poder comprender su unidad. La irritacion no es nunca violenta en dos centros simultáneamente; si la cefalalgia, el vértigo, etc., son intensos, los fenómenos estomacales son poco considerables; si los fenómenos de orígen medular, neuralgias, etc., son muy pronunciados, los desórdenes estomacales son poco intensos; cuando por el contrario los gases, los vómitos son continuos, hay ordinariamente pocos síntomas cerebrales ó medulares; del mismo modo, en el caso de diarrea abundante, los síntomas del estómago, de la cabeza, de la médula, son poco intensos.

A los síntomas cerebrales, medulares,

que pueden durar años, sucederá la dispepsia, que durará á su vez años tambien y que podrá ser reemplazada de nuevo por síntomas cerebrales ó medulares. La neurosis tiene tendencia á prolongarse indefinidamente, calmándose espontáneamente para volver con nueva intensidad, modificándose sin cesar, verdadero Proteo que desespera al enfermo y desorienta continuamente al médico, que cree reconocer en sus modificaciones tantas enfermedades distintas como diferentes manifestaciones tiene.

Cuando el médico observa los dolores de cabeza, los vértigos periódicos, no ocupándose más que de estos síntomas, incrimina al artritismo; si descubre un ruido de soplo en el corazon y en las carótidas, diagnostica la anemia; si un individuo tiene eczema y dispepsia, se le declara herpético, etc., etc. ¡Cuántas entidades patológicas que no tienen ninguna razon de ser han sido descritas! Enfermedades sinnúmero han sido consideradas como extrañas unas á otras cuando todas se ligan á una misma causa, sucediéndose, reemplazándose, pero derivando todas del sistema nervioso irritado.

He citado bastantes hechos clínicos para que el lector pueda seguir el encadenamiento de la irritacion de los diversos centros; irritacion que por lo comun los afecta simultáneamente, pero que de ordinario se acentúa con más intensidad en uno de ellos.

Si uno de los centros está violentamente afectado, el enfermo cura en general con más facilidad; la curacion es por el contrario lenta si los síntomas se desarrollan en todos los centros á la vez aunque con poca intensidad.

Al médico incumbe comprobar la exactitud de todos estos datos patológicos con el exámen del gran número de enfermos que se presentan cada día á su observacion pidiéndole la salud. Estos datos le permitirán comprender el papel fundamental de la célula nerviosa y de qué modo el olvido de la célula ha adulterado toda la patología.

QUINTA PARTE

CAPÍTULO X

SÍNTOMAS VISCERALES

Nariz.—Boca.—Faringe.—Esófago.

El abdómen y el tórax encierran todas las vísceras que sirven á la nutricion y á la procreacion: las vísceras que sirven para digerir los alimentos y, una vez digeridos, para á absorberlos; el órgano que lanza la sangre á todo el cuerpo, el corazon; los órganos que tienen por mision purificarla ó retirar de ella las materias tóxicas, el pulmon, el hígado, el riñon; las glándulas destinadas á elaborar los líquidos que emplea la digestion, hígado, páncreas, etc.

Todas estas vísceras están íntimamente unidas entre sí por el sistema nervioso abdomino-torácico, de tal suerte que el desórden de una de ellas puede turbar el funcionamiento de cualquiera otra; así, por ejemplo, una enfermedad del corazon ó del pulmon es causa de dispepsia, una afeccion del hígado puede ser causa de enfermedad del riñon.

Las vísceras reciben sus nervios de ganglios unidos entre sí por cordones nerviosos, ganglios sometidos á la influencia del plexo solar que centraliza las impresiones nerviosas viscerales y obra sobre todas las vísceras.

Esto es lo que demuestra la observacion clínica.

El plexo no es, como decia Van Helmont, el presidente de todo el género nervioso, sino que centraliza las acciones nerviosas de todo el sistema abdomino-torácico y las de los otros centros, como creo haberlo demostrado más arriba; influyendo á su vez, no sólo sobre el sistema nervioso abdomino-torácico, sino tambien sobre el cerebro y la médula, de tal modo que cuando éstos están afectados el médico se dirige desde luego al estómago para

volver el sistema nervioso á la tranquilidad.

El líquido digestivo, el jugo gástrico que produce el estómago no es más que una parte ínfima de su funcion, que consiste sobre todo en su influencia sobre el sistema nervioso. La fisiología del estómago no ha podido ser comprendida por los experimentadores, que sólo han tenido cuenta del jugo gástrico.

Bichat, al llamar al estómago el foco epigástrico en oposicion al foco cerebral, habia comprendido su importancia, y Beau, observador sagaz é ingenioso, ha dicho que, si el cráneo encierra el centro nervioso de la vida de relacion, la region epigástrica contiene al de la vida orgánica. Beau habia comprendido, pues, el papel del plexo solar; pero despues de los trabajos de este observador, el plexo cayó de nuevo en el olvido.

Como los experimentadores no pueden estudiar sériamente el sistema nervioso de las vísceras, su descripcion no ha podido ser hecha por los fisiólogos, y por tanto los patólogos han estudiado las vísceras sin tener en cuenta su sistema nervioso.

A la clínica pertenece estudiarlo y darlo

á conocer. Voy, pues, á ocuparme de él pasando en revista las vísceras cuya patología determina.

El sistema nervioso abdomino-torácico no es un sistema independiente, puesto que hemos dicho que recibe las acciones de los centros y que los turba, pero se puede observar su irritacion aisladamente.

La cuestion de la dispepsia no comprende más que los fenómenos debidos á la irritacion del plexo solar y á los centros nerviosos directamente relacionados con él. El plexo solar irritado regulariza en cierto modo la evolucion de esta enfermedad, que no desaparece hasta que el centro principal y los centros secundarios vuelven al reposo, y produce los dolores de estómago, el espasmo de su fibra muscular y la congestion patológica de su mucosa, influyendo sobre los centros periumbilicales para engendrar la constipacion ó la diarrea. Por sus relaciones con los nervios de la nariz, de la boca, de la faringe y del esófago, el plexo causa todos los síntomas que presentan estos órganos en la dispepsia, así como todos los desórdenes de las vísceras del tórax y del abdómen. Si se añade á esto que el plexo obra sobre el ce-

rebro y la médula, el lector comprenderá fácilmente que la dispepsia no es nunca una enfermedad localizada en el estómago, y que todas las discusiones á que han dado lugar durante treinta años la gastralgia y la gastritis entre los médicos más eminentes eran discusiones de casuistas.

Es necesario, pues, remover toda la cuestion, rehacer toda la patologia del tubo digestivo y de las vísceras tal como nos las enseña la clínica; esta descripcion mostrará todo el papel del sistema nervioso abdomino-torácico.

Pasaremos en revista, no sólo los síntomas de la dispepsia en el estómago y en el intestino grueso, sino tambien en el tubo digestivo en su totalidad, incluso las fosas nasales que son afectadas en su sensibilidad y funcion cuando la dispepsia existe, y estudiaremos la nariz, la boca, la faringe y el esófago.

I

NARIZ

En la dispepsia, el sentido del olfato está con frecuencia alterado, disminuido ó exaltado; los nervios trigéminos determinan picazon, pruritos, verdaderos dolores en una ó en las dos narices; los bordes de la nariz dan una sensacion de peso, de quemadura. La mucosa nasal está hinchada en su parte superior y dificulta la circulacion del aire; las secreciones aumentan, ó al contrario son nulas. El enfermo se queja de la efusion constante de un líquido cristalino, incoloro, que no se espesa ni se vuelve verdoso, y cuya secrecion cesa inopinadamente y vuelve despues de una comida, pudiendo durar dias, semanas ó meses. A menudo esta evacuacion es sustituida por un flujo sanguíneo más ó me-

nos abundante, especialmente en los tiernos niños, y que se reproduce con frecuencia. En este caso se invoca la anemia, la plétora, cuando en realidad son los centros nerviosos los que determinan el coriza ó la hemorragia estimulando á los nervios de la mucosa.

De 500 dispépticos, 30 individuos estaban afectados de un coriza crónico y 5 tenian epistaxis frecuentes. Todos estos síntomas, ó aparecen despues de la dispepsia ó pueden precederla, é indican la irritacion de los centros.

II

BOCA

Toda la boca, mucosa, lengua, músculos masticadores, glándulas salivares, encías y dientes, es afectada por la dispepsia, y á la larga todos estos órganos padecen en su funcion y presentan lesiones en su estructura cuando la enfermedad es inveterada.

La mucosa de la lengua se pone blanca tan pronto como el plexo está irritado; sólo por excepcion conserva su coloracion normal, y con frecuencia reconozco la antigüedad de la dispepsia por el exámen de la mucosa lingual. La capa saburral es una glositis superficial, una hiperplasia de células infiltradas de granulaciones de grasa, y á medida que la dispepsia se prolonga la glositis se hace cada vez más

profunda, hasta que las células superficiales acaban por desprenderse dejando desnudo el dermis que aparece rojo.

No es la capa saburral la que da el mal gusto, sino los nervios de la mucosa que determinan sensaciones erróneas. Si el enfermo se purga, la capa disminuye cuarenta y ocho horas, pero triplica despues.

Las papilas, los folículos de la mucosa se hinchan, se hipertrofian en esta glositis, en el cuarto posterior, y sobre todo en los bordes de la lengua, dibujándose más tarde por su aumento de volúmen. La capa de la lengua presenta cada vez un espesor mayor á medida que la dispepsia se prolonga, y la mucosa concluye por ulcerarse, presentando una coloracion blanca en su totalidad ó á trechos que constituye lo que se ha llamado psoriasis de la lengua. La lesion es á menudo más considerable en una mitad de la mucosa, la izquierda, y conduce al fin á la ulceracion.

Si la mucosa ha sufrido alteraciones profundas, los músculos que recubre pierden su libertad de accion, la masticacion se hace dolorosa, la palabra misma es difícil y el enfermo rehuye los alimentos sólidos.

Toda la mucosa bucal participa de la accion de la enfermedad del estómago: exfoliaciones, ulceraciones, aftas aparecen en la bóveda palatina, en los labios, los carrillos, y los nervios determinan sensaciones de prurito, quemadura, dolor. La mucosa de las encías se ulcera tambien, y los dientes mal sujetos abandonan paulatinamente sus alvéolos y caen uno tras otro, con caries ó sin ella, consecutivamente ó no á neuralgias más ó menos fuertes.

He sido consultado por una señora de cuarenta y cinco años, dispéptica de larga fecha, que sufria tales sensaciones de quemadura, dolores tan agudos en la lengua, que se veia obligada á mantenerla fuera de la boca muchas horas de la noche, y no llegué á aliviarla hasta haber mejorado en el espacio de un mes el estado del estómago.

La capa saburral de la lengua desaparece por el tratamiento de la dispepsia; las ulceraciones de la lengua, como las aftas, desaparecen tambien cuando el estómago se cura, lo mismo que la caida de los dientes puede detenerse. Hé aquí lo que se observa: al cabo de quince días de

tratamiento, poco más ó menos, la capa blanca que recubre la lengua disminuye de delante hácia atrás; las células de la porcion anterior, del cuarto anterior poco más ó menos, empiezan por volver al estado fisiológico; este órgano comienza por recobrar su coloracion rosada en la punta; pero cuando la capa es espesa y antigua, la reparacion es muy lenta y requiere uno ó dos años para que la lengua recobre su aspecto normal.

Todos los medicamentos aconsejados actualmente, los purgantes, no sirven más que para conservar la capa saburral y para aumentar su espesor. A medida que la mucosa se cura, el gusto se rehace y los músculos recuperan su actividad.

Cuando la mucosa está enferma, la secrecion de las glándulas de la lengua, de las encías, de las glándulas salivares aumenta ó disminuye: la saliva se hace espesa, viscosa, pegajosa, y se extiende sobre los bordes de la lengua en dos listas blanquecinas; una sensacion de sequedad penosa acompaña esta viscosidad de la saliva. En otros casos la secrecion aumenta repentinamente, y se establece tal flujo de saliva que el enfermo tiene que expulsar-

la continuamente, no pudiendo dormir por la obligacion de escupir tan á menudo el líquido que inunda su boca. Este exceso de secrecion se relaciona frecuentemente con la estomatitis que produce la dispepsia inveterada.

La secrecion normal de las glándulas no reaparece hasta que la dispepsia disminuye ó se cura, y entonces se ve aumentar poco á poco la cantidad de saliva normal, desapareciendo las fajas de saliva espesa de los bordes de la lengua para ser reemplazadas por una saliva más fluida y transparente.

III

FARINGE

La angina faríngea, la angina granulosa, tan comun ya en la niñez, precede ó sigue á la dispepsia, exagerándose depues de las comidas ó á consecuencia de la menor fatiga. En el fondo de la garganta se sienten punzadas, picores seguidos á menudo de una tosecilla seca, que se renueva muchas veces al día, y una sensacion de sequedad de la mucosa que está roja, brillante, cubierta de vasos varicosos, de líquido espeso, blanco ó verde, gris ó rojizo. El enfermo expectora, despues de toser, una espuma sanguinolenta que arrastra algunas veces granos blancos que son concreciones calcáreas; los folículos, aumentados de volúmen, describen una ó más lí-

neas longitudinales en la superficie de la mucosa.

La angina atormenta singularmente al enfermo que sufre de la garganta por la mañana en ayunas ó despues de cada comida. Con frecuencia he sido consultado á causa de la garganta por dispépticos que no concebian cómo el tratamiento de la dispepsia haria desaparecer la angina.

En la mayor parte de los enfermos, si la enfermedad del estómago es antigua, la mucosa de la faringe está roja é inflamada, y á menudo se la ve cubierta de ulceraciones. Tambien puede complicarse la dispepsia con amigdalitis flegmonosa ó angina pseudomembranosa.

La angina faríngea se agrava con los astringentes y con los sulfurosos.

Esta afeccion da lugar con frecuencia á errores de diagnóstico cuando no se conoce la dispepsia: la tos que provoca, los esputos sanguinolentos, la inapetencia, el enflaquecimiento y los sudores, tan comunes en la dispepsia, hacen temer sin motivo la tuberculosis.

El espasmo de los músculos de la faringe se observa cuando el estómago sufre de largo tiempo; el alimento entonces pasa

con dificultad y no logra siempre llegar al esófago, siendo devuelto inmediatamente.

La dificultad de la deglucion, lo mismo que la dificultad de la masticacion, hacen que el enfermo evite los alimentos sólidos y le impiden nutrirse sériamente.

IV

ESÓFAGO

El esófago participa tambien de los desórdenes que determina la dispepsia en las partes superiores de las vías digestivas. En algunos casos el estómago mismo no presenta ningun síntoma, y la dispepsia se desarrolla, por decirlo así, enteramente en el esófago. El malestar que éste ocasiona es mucho más penoso que el del estómago. Inmediatamente despues de la comida, ó al cabo de algunas horas, los nervios, el músculo, la mucosa del esófago, se hacen sentir con impresiones de punzadas, de desgarro, de quemadura en todo el tubo ó sólo en una de sus partes, seguidas de espasmos musculares en la porcion superior, media ó inferior del conducto, que se complican con angustia, sofocacion y sensacion de muerte próxima. Esta crisis

dura algunos minutos, media hora, y á veces una, dos ó más horas. Hay individuos que tienen el esófago constantemente seco y ardiente, extendiéndose el ardor á la faringe y á la boca.

Tales son los fenómenos que tienen por orígen el esófago y que se producen despues de la comida. En algunos individuos se producen sin embargo, por decirlo así, en sentido inverso, y aparecen durante la comida; á los síntomas bucales y faríngeos que hemos analizado más arriba se agregan entonces los síntomas esofágicos debidos á la dispepsia antigua, cuyo conjunto se denomina esofagismo.

Cuando el alimento ha atravesado la faringe y cae en el esófago, el músculo esofágico se contractura en una de sus partes y devuelve el alimento inmediatamente si los músculos superiores se convulsan, más tarde cuando los músculos inferiores solos entran en accion. A estos espasmos musculares sucede á veces la atonía de la fibra muscular, de tal modo que el esófago se dilata en un punto cualquiera donde el alimento se detiene y permanece. El enfermo siente su detencion y recurre para hacerlo bajar á beber una can-

tidad considerable de líquido, dos botellas por ejemplo, gracias á lo cual consigue al fin hacer pasar el alimento en el estómago; pero en algunos casos el alimento es devuelto y arrastra cierta cantidad de sangre que proviene de la mucosa varicosa y ulcerada. Estos síntomas hacen temer primero un tumor, y sólo la sonda permitirá hacer el diagnóstico, indicando al médico por su paso franco que el canal está libre y no obstruido por tumor alguno; además el tumor es bastante raro, mientras que el esofagismo debido á la dispepsia es relativamente comun. Al principio del esofagismo los sólidos se abren paso más fácilmente, porque hacen cesar el espasmo, mientras que los líquidos tienden por el contrario á aumentarlo.

El médico debe intervenir con premura cuando el esofagismo complica á la dispepsia y pasar muchas veces la sonda esofágica. He asistido á un enfermo de provincia que vomitaba toda especie de alimentos sólidos ó líquidos, y que se moria materialmente de hambre, logrando con rapidez hacer cesar el esofagismo con la sonda y comenzar á alimentarlo.

CAPITULO XI

ESTÓMAGO

Hinchazon, espasmo, náuseas, regurgitaciones, vómitos, dilatacion, gases, hipo, cáncer.

He reunido en este capítulo los síntomas del estómago, y en el siguiente los del intestino grueso, porque la dispepsia, estudiada en la parte subdiafragmática del tubo digestivo, se desarrolla sucesivamente en estos órganos. Provocada en el estómago por la irritacion del plexo solar, dura en este órgano cierto tiempo, disminuye espontáneamente y pasa luego al intestino grueso, llamada por la irritacion de los centros periumbilicales consecutiva á la del plexo solar, que determina así todos los síntomas del estómago, hinchazon, ga-

ses, náuseas, etc., y más tarde es la causa de todos los síntomas del intestino grueso, constipacion, diarrea, hemorroides, etc., que no cesan sino con la condicion de que el plexo se calme. He curado de la constipacion á una señora de ochenta años que desde la edad de cuarenta no podia defecar sino mediante una lavativa diaria, y que llegó despues de algunos meses de régimen, que tuvieron por resultado devolver la tranquilidad al plexo, á hacer una deposicion espontánea todos los días.

La funcion del estómago depende del estado fisiológico del plexo, cuya irritacion produce la dispepsia. Todos los medicamentos, amargos, eupépticos, vinos medicamentosos, tienen por único resultado, como hemos demostrado más arriba, acrecentar su irritacion.

La constipacion y la diarrea son debidas á la irritacion de los centros periumbilicales é indirectamente al plexo; las preparaciones de opio, la magnesia, etc., podrán determinar deposiciones ó detener la diarrea momentáneamente; pero aumentando la irritacion de los centros, reproducirán una constipacion y una diarrea más intensas. A menudo he curado

diarreas que duraban hacia muchos años por el tratamiento del estómago; todos los medicamentos cuya accion se ejerce directamente sobre el intestino grueso, incluso las lavativas sencillas, lo irritan.

No existen, como dice el vulgo, alimentos constipativos ó evacuantes, refrescantes ó irritantes, sino alimentos que afectan ó no al plexo. A éste está subordinada la funcion del intestino grueso, la regularidad de la defecacion, y en cuanto sufre la menor alteracion el intestino grueso se resiente.

El intestino delgado, que desempeña el gran papel en la digestion y la nutricion, no está bajo la influencia del plexo; circunstancia feliz, porque de lo contrario todos los dispépticos moririan, mientras que en realidad no sucumben más que por los errores de la terapéutica.

Se han inventado muchas fábulas sobre el efecto de la dispepsia en la nutricion; el dispéptico digiere los alimentos tan completamente como el no dispéptico, pero con mil sufrimientos; puede no enflaquecer y muchos engordan, ó si enflaquecen es porque el sistema nervioso sólo turba la asimilacion. Daré otras pruebas aún

de que si el individuo pierde en peso no es porque el tubo digestivo no ofrezca al organismo cantidad suficiente de alimentos.

Estudiemos, pues, estas dos fases de la dispepsia en el estómago y en el intestino grueso, fases que se suceden siempre con la mayor regularidad y que son consideradas en la patología actual como enfermedades distintas.

1.° *Estómago.*—He hecho conocer más arriba los síntomas propios al plexo; voy á indicar ahora los de la mucosa congestionada patológicamente. Reuniendo estos dos grupos de síntomas, se conocerá la dispepsia en el estómago.

El desarrollo de estos síntomas, la regularidad con que se reproducen en ciertos días á las mismas horas, su intensidad, todo depende del plexo.

Estos síntomas aparecen al principio, á largos intervalos, cada mes ó cada quince días, y anuncian que el plexo se irrita, que la dispepsia se prepara; luego se hacen cada vez más frecuentes, se reproducen muchas veces todos los días y concluyen por hacerse continuos. La continuidad es la más alta expresion de la irritacion del plexo y determina sufrimientos incesantes.

En unos enfermos no hay más que un síntoma provocado por el plexo, la hinchazon del estómago por ejemplo, ó los gases, las náuseas ó los vómitos, y este síntoma único indica la afeccion del estómago; en muchos casos hay una sucesion de síntomas que comienza por la hinchazon, á la que siguen los gases, las regurgitaciones, las náuseas, etc. Estos síntomas no se detienen en su marcha hasta que el centro nervioso recobra su equilibrio.

Cada uno de los síntomas merece descripcion especial.

La *hinchazon*, que se debe á la relajacion de la fibra muscular del estómago y no á la produccion de gases, como se dice diariamente, es por lo comun el fenómeno inicial en la dispepsia, dura media hora, una hora y aparece despues de una sola comida ó despues de cada una de ellas, concluyendo por establecerse en permanencia, y entonces la region esternal se eleva denotando la expansion del estómago, cuyo bulto ha podido confundirse en algunos casos con un tumor aunque sea bien fácil distinguirlo. El aumento de volúmen del órgano dificulta la respiracion y origina

un malestar continuo; el síntoma desaparece con el tratamiento del estómago.

El *espasmo* es la convulsion indolente ó dolorosa de la fibra muscular, que produce verdaderas nudosidades en la parte izquierda ó derecha del estómago. Este fenómeno produce en los dispépticos la sensacion de vibracion que empieza en una extremidad del estómago y se termina en la otra, ó la sensacion de un animal que corre por el interior del órgano y lo devora. Es muy doloroso y se observa á menudo en la dilatacion del estómago, complicándose algunas veces con un sentimiento de angustia.

La *náusea* está en relacion directa con el espasmo muscular, se manifiesta en las mismas condiciones que todos los fenómenos de la dispepsia y es grave cuando se hace continua. He curado con dos ó tres lavados del estómago y el régimen alimenticio á una enferma que he citado ya, una jóven de Enghien, que se moria en un estado de náuseas continuo que duraba hacia tres años, no pudiendo dormir ni de día ni de noche ni alimentarse, y reducida al

estado de inanicion cuando me encargué de asistirla. Esta enferma se restableció en seis meses y tuvo un niño al año siguiente.

La *regurgitacion* es debida al espasmo como la náusea y devuelve cierta cantidad de alimentos ingeridos, pero lo que es más digno de atencion es que la cantidad devuelta cada dia tiene el mismo peso; parece que el plexo no se calma sino despues de haber arrojado esta cantidad. Esta no disminuye, la tolerancia del plexo no reaparece sino con la condicion de que el estómago reciba el alimento en cantidad y calidad adecuadas, ó de lo contrario las regurgitaciones se hacen incesantes, constituyendo un síntoma que puede ser grave y contribuir á la inanicion si determina la pérdida de una cantidad excesiva de alimentos.

Si el espasmo es brusco y violento y la convulsion se extiende á toda la fibra muscular, en lugar de la regurgitacion que es debida á un espasmo parcial puede producirse el vómito, constituido por alimentos ó líquidos en cantidad notable si el estómago está dilatado ó por sangre cuando la mucosa está ulcerada.

El *vómito* tiene un carácter serio cuando, apareciendo inmediatamente despues de la comida, arrastra gran cantidad de alimentos y cuando persiste; es menos grave cuando se produce tres ó cuatro horas despues de la comida, porque en este caso sólo sustrae una pequeña parte de la materia alimenticia.

Un alimento dado mal á propósito, un medicamento prescrito intempestivamente prolongan la duracion de los vómitos. Ningun medicamento es susceptible de detenerlos, porque no puede suprimir la causa: ni la pocion de Rivière ni el hielo, que irritan el plexo, ni los vinos, que producen el mismo efecto. Fenómeno de orígen nervioso, el vómito puede detenerse por un cambio de aire, un viaje, pero para ser reemplazado por otro síntoma de dispepsia. Una sustancia cualquiera introducida en el estómago puede tener el mismo efecto. No hay medicamento contra el vómito, como no lo hay contra la hinchazon ó los gases. El vómito no es más que un síntoma.

Se puede siempre combatir al vómito. Los patólogos al describir el vómito incoercible, los parteros al provocar el alum-

bramiento antes de término en mujeres embarazadas que vomitaban todos los alimentos, no comprendian la significacion del vómito y lo hacian durar, por el contrario, con la administracion del vino de Champagne, de hielo, etc. He sido llamado muchas veces por mujeres en cinta que vomitaban desde hacia meses y en quienes se trataba de provocar el parto; en todos los casos he cortado los vómitos, curado el estómago y el embarazo ha continuado y ha llegado á término felizmente y sin accidente alguno.

La *dilatacion* del estómago, consecuencia del espasmo más ó menos prolongado de la fibra muscular del órgano, se acompaña á menudo de vómitos de líquidos, sobre todo cuando es considerable y cuando el estómago llega al ombligo ó desciende muchos centímetros más allá de esta cicatriz.

He observado la dilatacion del estómago en 119 de 500 dispépticos que he asistido; es decir, que la quinta parte de éstos tienen el estómago dilatado.

Algunos médicos que se ocupan en especial del estudio del estómago atribuyen

á la dilatacion una gravedad que no tiene. La dilatacion es tan curable como la dispepsia sencilla, el tratamiento es sólo algo más largo.

Nada tan fácil como diagnosticar la dilatacion; basta con percutir la region del estómago aplicando la palma de las manos sobre cada una de las extremidades del órgano, ó con aplicar una mano sobre la fosa ilíaca derecha y percutir con ella para enviar la sensacion de onda á la otra mano aplicada sobre el estómago. A menudo el enfermo siente él mismo la oleada al meterse en la cama y oye el ruido del líquido. He visto médicos instruidos indecisos sin saber si el líquido estaba en el estómago ó en el intestino grueso; la configuracion del intestino no le permite, sin embargo, realizar las impresiones que da el líquido estomacal. Un profesor de una universidad alemana introduce, para reconocer el grado de dilatacion, una sonda en el estómago y busca á donde llega su extremidad; pero es una maniobra bien inútil y nociva con frecuencia para el enfermo. Un profesor de la Facultad de París, médico muy eminente, ha atribuido una influencia especial á la dilatacion so-

bre la produccion del reuma crónico, error que podrá reconocer fácilmente. La dilatacion como la dispepsia no significan nada bajo el punto de vista del reuma, que depende del sistema nervioso perturbado y no del estómago, como lo probaré en el trascurso de este trabajo. La dilatacion no es una complicacion séria más que cuando el órgano desciende muchos centímetros debajo del ombligo, y si expulsa muchos litros de líquido en un dia; el vómito de esta cantidad de líquido es seguido de postracion nerviosa grave y algunas veces de convulsiones.

La dilatacion se cura incluso en este grado, pero con la condicion que no se cometa un solo error de régimen ó de terapéutica.

El vómito de sangre pura ó de pigmento sanguíneo es un accidente muy comun de la dispepsia antigua.

De 500 individuos he visto 10 que han tenido hemorragias sérias; uno de treinta y seis años ha tenido á los diez y nueve un vómito de dos litros de sangre; otro de treinta años ha tenido un vómito de tres litros de sangre á la edad de veintiocho años; otro ha vomitado tres veces, en el es-

pacio de seis años, un litro de sangre; un hombre de cuarenta y nueve años, dispéptico de quince, ha arrojado hace veintidos meses de tres á cuatro litros de sangre; otro de cincuenta y dos años arroja cada año, desde hace doce, muchos litros; en fin, una señora de sesenta y ocho años, que ha sufrido siempre del estómago, ha vomitado á la edad de cincuenta y ocho años un litro de sangre. Estos hechos muestran la frecuencia de los vómitos de sangre pura y la tendencia de estas hemorragias á reproducirse, acusando una lesion profunda de la mucosa y la lentitud de su cicatrizacion. Rara vez estas hemorragias son fulminantes. La mucosa estomacal se restablece lentamente, y exige para cicatrizarse completamente meses y años de reposo del cuerpo y de un régimen severo.

Los vómitos de líquido cargados de pigmento no ofrecen ninguna gravedad, y se detienen pronta y espontáneamente. La úlcera del estómago es debida por lo comun á la dispepsia, y sobreviene cuando los síntomas ordinarios de ésta existen de larga fecha.

Gases.—Los gases tienen la misma pa-

togenia que los otros síntomas de la dispepsia: irritacion del plexo, espasmo de la fibra muscular, que arroja los gases contenidos en el estómago ó los que se exhalan de los vasos dilatados de la mucosa.

Produciéndose en un principio á largos intervalos, los gases vuelven despues una ó dos veces por semana, y más tarde diariamente, tres ó cuatro horas despues de cada comida y duran media hora, una hora, para hacerse al fin continuos. Que el enfermo esté en ayunas, que se alimente ó no, los gases se producen y son arrojados constantemente. He sido consultado por una señora que, completamente en ayunas desde seis días, arrojaba gases día y noche durante ese mismo tiempo y estaba aniquilada con tan largo sufrimiento. Hice cesar rápidamente los gases calmando el plexo solar. Otra enferma de treinta y nueve años, dispéptica desde hace veinte, tiene crisis terribles de gases quo son expulsados con ruido, y presenta una hiperestesia generalizada de la piel, bastando tocar un punto del brazo, del cuero cabelludo ó de la piel de los lomos para producir una expulsion de gas durante una ó dos horas, lo cual demuestra que la impre-

sion de un nervio periférico es causa de mayor irritacion del plexo.

En cierto número de enfermos los gases cesan cuando empieza el sueño, y vuelven al poner el pie en el suelo; durante el tiempo que los enfermos pasan en la cama inmóviles, los gases no se producen.

Estos hechos clínicos, la regularidad de la evolucion de los gases, su continuidad en los casos de dispepsia antigua, prueban que no son debidos á una fermentacion de alimentos, á su descomposicion química. Una pequeña cantidad sólo se produce por la fermentacion. Algunas veces los gases provienen de las materias fecales y suben del intestino hácia el estómago. El estómago no es una retorta donde el alimento se descompone: el alimento se transforma isoméricamente y es rápidamente absorbido.

Hipo.—El hipo es igualmente un síntoma de la dispepsia inveterada; puede durar meses, y con frecuencia día y noche, tanto como dura la irritacion del plexo.

Cáncer del estómago.—El cáncer es la última etapa de la dispepsia, y es felizmen-

te raro. En 500 dispépticos he encontrado sólo dos ó tres casos. Con frecuencia se diagnostica un cáncer que no existe. Lo he encontrado en personas de edad muy avanzada que sufrian de dispepsia hacia treinta años. Cuando una medicacion errónea, un mal régimen atormentan durante mucho tiempo la mucosa del estómago, el tejido canceroso puede desarrollarse, del mismo modo que el cáncer puede aparecer en el labio de los fumadores que han excitado mucho tiempo la mucosa de los labios ó de la lengua con el tubo caliente de la pipa.

La dificultad del diagnóstico es grande; la enfermedad del conde de Chambord lo ha demostrado suficientemente: todos los médicos han estado indecisos hasta el fin. Los patólogos han descrito los síntomas del cáncer, los han detallado con mucho cuidado; pero finalmente, el médico que ha asistido á muchos enfermos y es sériamente experto, reconoce que todos estos síntomas del cáncer no existen en realidad y que no hay síntomas propios del cáncer.

La inapetencia, la repugnancia por los alimentos, los dolores, las regurgitaciones, los vómitos de alimentos, de líquidos ó de

sangre, el enflaquecimiento, el color caquéctico, el edema de los miembros inferiores son comunes á la dispepsia y al cáncer; con frecuencia el cáncer existe en el píloro, en la cara posterior del estómago, no pudiendo sentirse con la mano, y la percusion no indica nada entonces; los latidos arteriales son en extremo comunes en la dispepsia sencilla. No queda, pues, más que el síntoma tumor, y aun éste puede inducir en error al médico, pudiendo tratarse de un aneurisma de la aorta, de un riñon flotante ó de un infarto de los ganglios linfáticos que se hallan de cada lado de la columna vertebral.

¿Cómo llegar á hacer el diagnóstico? Puede siempre establecerse, pero no por la medicina clásica tal como se enseña. El médico debe reconocer el cáncer en medio de los fenómenos variados de la dispepsia, y esto lo puede como puede curar siempre la dispepsia, pero nunca el cáncer.

¿Cuál es, pues, el hilo conductor que debe seguir? Hé aquí lo que se observa. En la dispepsia, sea cualquiera la gravedad de los síntomas, si se mantiene al enfermo en reposo absoluto, si no se le administran más que algunos medicamentos sencillos

tolerados por el estómago y que lo calman, como una toma de fosfato, de bismuto, de sulfato de sosa, etc., y alimentos fácilmente tolerados, como leche, sopas de leche, el apetito puede renacer, el dolor se calma, la regurgitacion y el vómito disminuyen y cesan, el color caquéctico desaparece, y el médico entonces, poco á poco y con las mayores precauciones, puede hacer uso de la fibra muscular (pescado ó carne) de vez en cuando para despertar al plexo solar quince días ó tres semanas despues. Si se trata sólo de dispepsia, el enfermo se cura siempre. El estómago no desea más que funcionar, y sigue la direccion que se le imprime. Quince días ó tres semanas de observacion son necesarios al médico que quiere hacerse una opinion sobre la enfermedad; si despues de tres semanas ninguna mejoría se ha producido, la duda es imposible, el cáncer del estómago existe y el enfermo está condenado; pero no deberá nunca el médico pronunciarse antes de este tiempo, y despues de haber visto al enfermo todos los días, haciendo notar por la familia los alimentos tomados y los accidentes ocurridos. El diagnóstico exige un exámen prolongado, que no se cometa

el más leve error de tratamiento; sin estas precauciones no se puede emitir ninguna opinion séria sobre la naturaleza de la enfermedad.

Los síntomas estomacales dependen sólo del alimento ingerido, de las impresiones morales comunicadas al enfermo, de sus movimientos. Todo trabajo intelectual, todo esfuerzo físico, deben ser proscritos durante este período. Si no se cumplen todas las condiciones más arriba indicadas la opinion del médico no tiene valor alguno.

El cáncer obra independientemente del alimento y de la higiene establecida, mantiene la inapetencia, el dolor, la regurgitacion, y los síntomas estomacales dependen entonces del tejido de nueva formacion que excita al órgano. En el cáncer, el estómago no tolera nunca otra cosa más que leche ó algunas legumbres machacadas. La introduccion de la menor tisana, de huevos, triplica los fenómenos que son continuos: el enflaquecimiento, la caquexia, siguen su curso fatalmente.

Tales son los datos esenciales del diagnóstico, que debe fundarse en el tratamiento y en la marcha de la enfermedad. No

hay ningun otro medio de establecer un diagnóstico antes de que el tumor se haya desarrollado y se haga palpable. El médico no deberá pronunciarse sino despues de un exámen maduro, y no deberá tranquilizar ni asustar á los parientes del enfermo sin tener una conviccion inspirada por las relaciones entre los fenómenos y el régimen.

Hay casos en que esta incertidumbre no existe, cuando el cáncer aparece bruscamente sin ser precedido de dispepsia. Entonces todos los síntomas que acabo de indicar aparecen inopinadamente: la inapetencia, el enflaquecimiento, los vómitos, el color caquéctico, se instalan rápidamente y la muerte sobreviene algunos meses despues; tal es el cáncer primitivo. No debe formarse la opinion sino despues de haber estudiado el estómago por el alimento, como acabamos de indicarlo.

Cuando un tumor existe en la region del estómago, aneurisma, riñon flotante, infarto ganglionar, todos los síntomas del cáncer pueden existir. Recuerdo haber visto en consulta en Passy á una señora de setenta años que tenia repugnancia por

los alimentos, vomitaba cuanto tomaba y cuyas piernas estaban edematosas. El médico me hizo palpar un tumor á los lados de la columna vertebral, que él decia ser un cáncer del estómago. Esta enferma volvió á la salud despues de seis meses de tratamiento y el tumor persistió. Otros enfermos, que tenian un riñon colocado debajo del estómago, presentaron todos los signos de la caquexia cancerosa y fueron curados por el régimen continuado durante algunos meses.

En resúmen, todos los síntomas de la dispepsia, todos los accidentes de la mucosa estomacal, los fenómenos que ésta produce y con frecuencia incluso el cáncer, son el resultado de la irritacion del plexo solar. Si una indigestion sencilla es mal asistida, la terapéutica errónea puede agravar los fenómenos hasta el punto de hacer creer en un cáncer. Esto sucedió con el conde de Chambord. Muchos enfermos que tienen sólo una dispepsia sencilla, mueren porque dicha dispepsia ha sido mal atendida. Es necesario que el médico no sólo conozca el tratamiento de la dispepsia, sino que cuando se trate de la en-

fermedad de un órgano cualquiera, de una afeccion febril, tenga presente al espíritu los medicamentos y los alimentos tolerados, pues de lo contrario puede comprometer la vida del enfermo.

CAPITULO XII

INTESTINO GRUESO

Constipacion, Diarrea, Hemorroides, Fisura, Prolapsus del recto.

El intestino grueso está íntimamente unido con el estómago por los centros nerviosos que presiden á su funcion. No hay casi ningun caso en que á la dispepsia no sucedan los síntomas del intestino grueso.

He descrito los dos centros periumbilicales y sus síntomas, cuando están irritados.

La irritacion de estos centros sucede espontáneamente, naturalmente, á la del plexo, que disminuye al cabo de algunas semanas. La historia de la enfermedad del intestino grueso comprende los síntomas

de estos centros que he dado á conocer más arriba, así como los síntomas particulares al intestino grueso mismo.

Del mismo modo que todos los fenómenos de la dispepsia son debidos á la irritacion del plexo solar, así tambien los del intestino grueso son debidos á la irritacion de los centros nerviosos periumbilicales. Los síntomas de los centros periumbilicales y del intestino grueso componen, si se me permite emplear esta expresion, el segundo período de la dispepsia que sucede, por decirlo así, fatalmente al primero.

Hé aquí lo que el médico observa.

El alimento, introducido en el estómago, no le atormenta ó le incomoda poco; pero tres ó cuatro horas despues de una ó de las dos comidas el dispéptico siente dolores en uno de los centros ó en ambos simultáneamente, dolores que él llama cólicos. El enfermo no puede determinar con precision el punto doloroso, pero sabe muy bien que el estómago está libre y que la enfermedad ha descendido; y con efecto, la accion del alimento se hace sentir en el centro periumbilical y puede no influir más que en este centro nervioso. En algunos casos el centro determina contraccio-

nes dolorosas del músculo intestinal; contracciones que corren de derecha á izquierda, atraviesan el cólon y arrastran gases. Cuando el centro está fuertemente excitado, la contraccion va hasta la extremidad de la S ilíaca, hasta el músculo esfínter, que se contractura; el ano se cierra y esta sensacion de oclusion penosa es poco duradera en general, aunque puede á veces prolongarse algunos minutos ó algunas horas y reaparecer á la comida siguiente. Si la irritacion del centro nervioso es más viva, se acusa rápidamente despues de la comida ó tan pronto como un alimento penetra en el estómago. El cólico que se produce inmediatamente despues de la comida es debido al plexo ó al centro periumbilical. En el segundo caso, si el centro está muy irritado, el alimento puede determinar una verdadera crisis de dolor al entrar en el estómago, de modo que la sustancia ingerida se haga intolerable tantó á causa del centro periumbilical como del plexo.

De 500 dispépticos 100 tienen evacuaciones regulares, normales, bien formadas; pero esto no les impide sufrir de los centros periumbilicales.

En las cuatro quintas partes de los casos hay constipacion tenaz ó constipacion, alternando cada quince días con diarrea, hasta que al fin, si el mal es antiguo, la diarrea es continua. La constipacion es debida á la disminucion de secrecion de las glándulas del intestino, á la disminucion de exhalacion en los vasos de la mucosa. Un mucus espeso, viscoso, reemplaza la secrecion líquida de las glándulas y se mezcla á las materias formando filamentos, membranas celulosas más ó menos espesas que son expulsadas de vez en cuando con los excrementos, ó con frecuencia solas, en cuyo caso su expulsion se acompaña de cólicos, porque las contracciones musculares son dolorosas. Tal es la enteritis pseudomembranosa, sobre la cual han insistido algunos autores y que no es más que la consecuencia de la dispepsia.

En este medio intestinal que recibe una cantidad insuficiente de líquido secretado la materia fecal se seca, se desagrega en bolas, en grumos, en granulaciones que se acumulan en el ciego; el músculo intestinal no llega á hacerlas circular hasta la S ilíaca, con gran preocupacion del dispéptico, que piensa continuamente en esto; el

enfermo es sin cesar incitado por el centro nervioso á expulsar materias que están lejos del ano, y á pesar de sus esfuerzos y de contraer vigorosamente sus músculos abdominales, lumbares, diafragmáticos, no llega á expulsar ni bolas ni granulaciones, sino, y sólo en ciertos casos, algunas mucosidades. El paciente se desespera, la constipacion llega á ser su preocupacion constante; hace uso de alimentos llamados refrescantes, de píldoras; pero los alimentos y las píldoras no tienen eficacia alguna, agravando la constipacion por irritacion del centro nervioso, y mientras esta irritacion dura la funcion de defecacion no se restablece. Hay enfermos que llegan á tomar cinco y seis lavativas consecutivas para expulsar una bola. El intestino, que no encierra más que bolas, no puede producir cilindros á pesar de la farmacia.

Algunos enfermos tienen el intestino cargado de materias blandas, semilíquidas, tan difíciles de expulsar como las materias secas y duras, porque el órgano encargado de expulsarlas está impotente á causa de su centro nervioso. Estos pacientes tienen la misma dificultad para expul-

sar sus excrementos, mezclados con flemas y algunas veces con sangre, como cuando las materias son duras y secas. Cada mes, ó cada quince días, la constipacion es reemplazada durante una mañana ó todo un día por diez ó quince deposiciones líquidas, que se suspenden espontáneamente sin medicacion para ser seguidas de las materias duras y secas.

El músculo intestinal se contrae con fuerza en ciertos puntos y no en otros, y con el trascurso del tiempo permanece dilatado en su parte derecha ó izquierda ó en toda su extension, lo cual indica que el centro nervioso está aniquilado; verdaderos tumores sonoros ó nudosidades se forman á la derecha ó á la izquierda, ó en el cólon transverso. La defecacion exige entonces que el centro se despierte y produzca cólicos más ó menos largos, y á cada deposicion precede una crisis dolorosa seguida de un anonadamiento completo del individuo, y bastante á menudo de una pérdida de conocimiento. A la constipacion y á las alternativas de constipacion y diarrea sucede la diarrea continua, que puede durar muchos años y que se compone de diez y doce deposiciones líquidas diarias,

que enflaquecen poco al individuo si no contienen más que el agua y los cloruros de la sangre, pero que lo consumen si se componen de glóbulos blancos y de albúmina. La diarrea puede detenerse con lavativas medicamentosas, con preparaciones de opio introducidas en el estómago; puede cesar durante algunos días á causa del medicamento, pero reaparecerá más intensa, porque el medicamento no calma el plexo y los centros periumbilicales, y la detencion brusca de la diarrea por el medicamento aumenta la irritacion de los centros nerviosos. Cuando se trata la dispepsia, para curar la diarrea, hé aquí lo que se observa:

Los cólicos intestinales disminuyen; la necesidad de defecacion, que se reproducia á cada instante, disminuye tambien ó reaparece si habia desaparecido. Al cabo de tres semanas, poco más ó menos, el dispéptico empieza á expulsar espontáneamente algunas bolas cuyo volúmen aumenta progresivamente, y aunque la expulsion es todavía penosa, los días de deposicion espontánea se multiplican al mismo tiempo que la dispepsia estomacal disminuye. En algunos casos las materias toman un vo-

lúmen considerable, y tan enorme, que en ciertas ocasiones he debido socorrer á algunos enfermos empleando una cureta *(curette)* ú otro instrumento para ayudar á expulsarlas. La expulsion de estas materias enormes deprime las fuerzas, pero dos ó tres semanas despues dichas materias toman un volúmen casi normal.

Al mismo tiempo que la constipacion se cura, las mucosidades desaparecen.

En el caso de diarrea, la cura de la dispepsia empieza por disminuir la cantidad de líquido eliminado, sin cambiar el número de evacuaciones; el tenesmo se renueva durante bastante tiempo con la misma frecuencia; pero poco á poco la materia sólida se forma en el ciego para ser expulsada, aun durante cierto tiempo, mezclada con líquido; en fin, la primera aumenta y el segundo disminuye, hasta que las materias se hacen por último enteramente sólidas.

Sucede con la diarrea y la constipacion como con los síntomas estomacales: fenómenos de orígen nervioso, la diarrea puede detenerse por un cambio de aire, ó bien la

constipacion cesa ó es reemplazada por la diarrea. Cuando el enfermo va á hacer una cura de aguas minerales, siempre atribuye el cambio operado á las aguas: atribuye á las aguas las modificaciones que tienen lugar en las secreciones intestinales, y en unos casos hace su elogio, mientras que en otros las incrimina; pero en ninguno está en lo cierto, sea cualquiera su impresion, pues ignora que lo más á menudo el cambio en las secreciones es debido sencillamente al cambio de medio. Todas las observaciones recogidas hasta hoy sobre la accion de las aguas han sido hechas sin tener cuenta del sistema nervioso, de suerte que el médico no sabe cómo debe interpretarse el efecto de las aguas en lo que atañe á las secreciones del intestino.

La congestion patológica de la mucosa del intestino grueso, que es debida al centro periumbilical y causa la constipacion ó la diarrea, provoca á la larga desórdenes profundos en la estructura de la mucosa, hemorroides, flujos hemorroidales, ulceraciones de la mucosa y secrecion purulenta; la fisura del ano y el prolapsus rectal pueden tambien ser sus consecuencias. Estos

desórdenes disminuyen progresivamente cuando la dispepsia está en vía de curacion; las ulceraciones pueden curarse, la fisura desaparece sin intervencion quirúrgica, la procidencia del recto desaparece igualmente por antigua que sea. En muchos enfermos el prolapsus rectal desapareció cuando el intestino se habia restablecido. Otras complicaciones se relacionan con la enteritis, como la tiflitis que he encontrado algunas veces, y sobre todo un infarto de los ganglios linfáticos situados sobre el lado derecho de la columna vertebral, que aumenta con la marcha, con la diarrea y es muy doloroso. Este infarto no ha sido señalado, que yo sepa, hasta aquí, y cuando determina sensaciones dolorosas se atribuyen á cólicos intestinales. En muchas ocasiones he disminuido estos ganglios con el régimen y con la cauterizacion punteada del lado derecho del abdómen, debajo del ombligo, repetida una vez por semana durante dos meses consecutivos. Los hechos patológicos del intestino grueso, constipacion ó diarrea, hemorragias, fisuras, hemorroides, se relacionan directamente con la irritacion del centro periumbilical, é indirectamente con la del

plexo solar. Todos estos fenómenos no cesan sino con la condicion de que los dos centros recuperen su quietud, y los medicamentos distan mucho de ser suficientes para hacerlos desaparecer.

CAPÍTULO XIII

VÍSCERAS ABDOMINALES Y TORÁCICAS

Hígado.—Organos genito-urinarios, etc.

Las vísceras sufren la influencia del plexo irritado. No hay dispepsia en que no se observe en cualquier momento una complicacion visceral; todas las vísceras pagan tributo al plexo. Si el intestino sufre consecutivamente á la dispepsia estomacal, lo mismo sucede con el hígado: la congestion del hígado, la ictericia, los cólicos hepáticos, son accidentes comunes. Ya he señalado los cólicos nefríticos. El dispéptico sufre espasmos de la vejiga, desórdenes en la miccion, pérdidas seminales, etc. La dispepsia comunica al pulmon

una propension á congestiones, á accesos de asma; las palpitaciones, la angina de pecho, la endocarditis misma reconocen su orígen en la irritacion del plexo. Las afecciones viscerales siguen á la dispepsia, pero pueden tambien determinarla, y en ese caso los centros nerviosos empiezan por irritar á los nervios de las vísceras y el plexo se irrita consecutivamente.

Hablaré sucesivamente de cada una de las vísceras, y voy á empezar por las abdominales:

1.° *Hígado.*—Se observa particularmente la congestion hepática, la ictericia y los cálculos biliares.

De cien veces, ochenta el hígado ha aumentado de volúmen, y puede llegar á bajar muchos centímetros de la línea umbilical. Insensible á veces á la presion y á la percusion, es por lo comun doloroso á la presion. El órgano puede llegar á ocupar toda la region del estómago y extenderse hasta el bazo, pero no presenta ninguna modificacion de estructura al tacto, es liso y su peso incomoda al enfermo, que se ve obligado á reposar en el decúbito supino, no pudiendo acostarse ni sobre el lado derecho ni sobre el izquierdo.

La circulacion biliar se perturba, la piel presenta un color subictérico ó está completamente amarilla; las conjuntivas se ponen amarillas de tiempo en tiempo, las materias fecales se descoloran sin que la orina contenga pigmento biliar, ó por el contrario presentando ésta un color de ébano debido al pigmento.

La ictericia, que aparece súbitamente y se repite cierto número de veces, es frecuente cuando el plexo está irritado.

Cuando el plexo está muy doloroso determina algunas veces cólicos atroces, ictericia y vómitos que, con la mayor frecuencia, hacen creer en un cálculo; importa distinguir el dolor debido al plexo del que es causado por el cálculo.

Los purgantes, las aguas alcalinas, mantienen las crisis del plexo, las agravan, las hacen persistir. En el primer caso, la mayor sensibilidad se encuentra en la línea media del estómago; cuando se trata de cálculos hepáticos, el dolor agudo existe en el hígado y el plexo es poco sensible.

El cálculo del hígado es provocado por la influencia del plexo y de los centros sobre la circulacion biliar, y no por el género de alimentacion; el cálculo se produce

cuando el plexo está irritado al mismo tiempo que los otros centros, y es debido á la accion nerviosa. Un individuo que tiene una profesion sedentaria, que se alimenta con carne en exceso, con grasa, no tiene cálculos del hígado ó del riñon á causa de la profesion ó del alimento, sino porque toda su higiene ha perturbado profundamente á los centros nerviosos.

Hé aquí algunos hechos para demostrarlo:

Una señora de treinta y seis años sufre cólicos hepáticos desde hace muchos años; ha hecho una estacion en Vichy y en Plombières; tiene vértigos, se ve incapaz de pensar; no tiene ni memoria, ni voluntad; sufre zumbido de oídos, raquialgia en la parte inferior de la columna vertebral, hiperestesia de la piel y de los músculos del brazo; el plexo está doloroso á la presion.

La Sra. L..., treinta y ocho años, ha tenido tres meses consecutivos cólicos hepáticos con vómitos, defecaciones descoloradas y orina de color de ébano; en otro tiempo sufria jaquecas, y en la actualidad siente dolores á lo largo de la columna vertebral y dolores articulares.

La Sra. A..., treinta y cinco años, sufre hace cuatro de crisis de cólicos hepáticos; siendo niña ha tenido dolores de cabeza y en la actualidad sufre vahidos, zumbido de oídos, sensacion de fuego á lo largo de la columna vertebral; tiene gases, diarrea y un flujo sanguíneo hemorroidal.

En la mujer, la menstruacion, los embarazos tienden á reproducir las crisis del hígado, como consecuencia de la influencia del centro nervioso subumbilical sobre los ganglios nerviosos del hígado.

Todos los hechos patológicos están sujetos al sistema nervioso.

2.° *Organos genito-urinarios.*—No volveré sobre la cuestion renal y la secrecion urinaria, que he tratado ya en detalle; hablaré sólo de la vejiga y de los órganos genitales.

Cuando la dispepsia dura hace mucho tiempo, el individuo se ve atacado inopinadamente de deseos frecuentes de orinar lo mismo de día que de noche, satisface á cada instante esta necesidad y expulsa sólo algunas gotas de orina cada vez; puede no sufrir, pero con frecuencia tiene es-

pasmos dolorosos del cuello de la vejiga, sensaciones gravativas de cuerpo extraño en la vejiga, que aumentan con la marcha ó con el movimiento en carruaje, como si estuviera afectado de un cálculo vesical, al mismo tiempo que la region de la ingle, del periné, están doloridos, y que el canal de la uretra mismo produce picazones, escozor en su extremidad y deja escapar un líquido blanquecino.

La orina es mucosa ó muco-purulenta; el catarro de la vejiga es bastante comun como consecuencia de la dispepsia que ha durado mucho tiempo, y desaparece cuando la afeccion causal se cura. La espermatorrea puede tambien producirse; la pérdida espermática aparece á intervalos más ó menos largos, es frecuente más tarde y se renueva por último dos ó tres veces por semana; trae consigo una postracion extrema, y no cesa hasta que el estómago no se cura. Los deseos genésicos son violentos ó nulos, sea cualquiera la edad del individuo; la funcion testicular está subordinada al sistema nervioso del estómago. He notado tres ó cuatro veces la tumefaccion de la próstata en personas dispépticas que no

tenian enfermedad de la vejiga, del testículo ni del canal.

En la mujer, las reglas son irregulares, se acompañan de dolores ó desaparecen durante meses; la sangre es pálida ó poco abundante; en algunos casos la pérdida menstrual dura quince días consecutivos, es muy abundante y produce una fatiga profunda. En estos casos se acusa siempre á la anemia. La leucorrea constante es tambien un accidente de la dispepsia; la funcion menstrual se restablece por el sistema nervioso. Si la mujer concibe en esas condiciones, los embarazos son algunas veces muy penosos; el parto es prematuro muy á menudo. Estas enfermas tienen con frecuencia las mucosas vaginal y uterina hiperestesiadas, y la hiperestesia es seguida de contractura del músculo vaginal. La intervencion quirúrgica cura sólo momentáneamente la contractura, que vuelve como consecuencia de la hiperestesia; ésta debe, pues, desaparecer primero para triunfar de la contractura.

Las neuralgias del cuerpo y del cuello del útero que provienen de la irritacion del plexo lumbo-aórtico se acompañan con frecuencia de la metritis del cuerpo y del

cuello, de hipertrofia del órgano, de granulaciones y de ulceraciones. Las cauterizaciones que se practican sirven sólo en ciertos casos para irritar el centro nervioso subumbilical. El médico que emplea intempestivamente las cauterizaciones mantiene el estado morboso del centro nervioso.

II

VÍSCERAS TORÁCICAS

No hay dispéptico que no sufra del corazon y que no se crea atacado de una enfermedad de este órgano.

Sensacion de compresion del corazon despues de la comida, de pellizcos, de punzadas, dolores violentos, crisis de angina de pecho con neuralgia que se trasmite al lado izquierdo del tórax y al brazo izquierdo, tales son los síntomas que acusan los enfermos, de tiempo en tiempo primero, por intervalos cada vez más cortos despues y finalmente todos los días. Estos fenómenos se muestran tres ó cuatro horas despues de la comida, se presentan más tarde inmediatamente despues de ésta y se hacen por último continuos. La evolucion de los síntomas viscerales es idéntica á la

de los fenómenos que presentan el estómago y el intestino porque la causa es la misma.

Nada asusta tanto al dispéptico como los fenómenos cardiacos. Mientras los pellizcos y la compresion son pasajeros se le llega á convencer de que no tiene enfermedad del corazon, pero no sucede lo mismo cuado llega una crisis de angina de pecho; entonces el miedo no le abandona aun despues de la crisis.

Una señora nerviosa y dispéptica tiene durante la noche una crisis de angina de pecho que dura diez horas: dolor atroz en el esternon que se propaga al pecho, al tórax y al brazo izquierdo; la enferma estaba angustiosa, sentada en la cama, con la boca entreabierta, la faz lívida, las extremidades frias, creyendo como toda la familia su muerte próxima; los choques del corazon contra el pecho eran tales que parecia querer romperlo, el pulso no podia contarse. Despues de terminada la crisis la enferma quedó aniquilada durante muchos dias y no recobró la confianza hasta algunas semanas despues, cuando el estado general se habia mejorado notablemente.

Las palpitaciones, intermitentes al principio en el dispéptico, se hacen incesantes con mayor ó menor violencia. Este fenómeno está más frecuentemente ligado con la dispepsia que con una enfermedad del corazon; expresion del neurosismo, las palpitaciones son debidas á los centros nerviosos; los ruidos cardíacos son vibrantes, tienen un timbre metálico, son regulares, irregulares ó intermitentes. El corazon tiene paradas que el enfermo percibe; los ruidos son distintos ó confundidos en uno solo, cubiertos por un ruido de soplo suave en el primer tiempo, en la base ó en la punta; en algunos casos late ciento cincuenta, ciento ochenta veces por minuto, un soplo rudo que cubre los dos ruidos se oye en la punta. En ciertos casos hay una verdadera endocarditis por lesion de nutricion, y entonces el médico duda si la endocarditis ha precedido la dispepsia ó si le es consecutiva. El tratamiento de la dispepsia combate victoriosamente, en algunos casos, la afeccion cardíaca; la endocarditis debida al estómago puede curarse.

El pulso, por su rapidez, sus intermitencias, sus paradas, acusa el estado cardiaco.

Cuando se descubren los síntomas de la endocarditis importa buscar si hay dispepsia. Cuando ésta acompaña la afeccion del corazon, el pronóstico es con frecuencia menos grave: he visto desaparecer la endocarditis cuando el estómago se habia restablecido.

Todos los nervios vaso-motores sufren por la irritacion del plexo: los vasos laten con violencia en el vientre, el pecho, el cuello, los miembros, de tal modo que el enfermo se inquieta y se impresiona penosamente; estos latidos no están ligados en manera alguna con la fiebre y se producen sin elevacion de temperatura.

La laringitis, la afonía, los accesos de tos, el falso crup, son complicaciones comunes de la dispepsia; la voz se altera ó se apaga. He notado la afonía durante algunas semanas, meses ó algunos años; los accesos de tos pueden prolongarse diez y quince horas consecutivas, y me ha sido dado calmarlos aplicando una cantárida sobre el estómago.

En 500 casos de dispepsia he encontrado la pleuresía 15 veces. La pleura se inflama sin enfriamiento: la congestion pulmonar se muestra en los dos

pulmones ó en uno solo, y es á menudo muy grave. Dos mujeres del hospital que tenian el plexo solar doloroso fueron arrebatadas en cuarenta y ocho horas por una congestion pulmonar doble.

La bronquitis aguda, la bronquitis crónica, tienen tendencia á renovarse con la mayor facilidad y á durar en los casos de dispepsia; en fin, el acceso de asma alterna con esta última enfermedad ó la precede.

La influencia del plexo sobre el corazon y el pulmon es considerable; contribuye á aumentar la dificultad de la respiracion, puesto que por sí solo puede producir la disnea, facilita la produccion de diversas enfermedades del pulmon, las agrava ó las mantiene.

Muchas personas no contraen bronquitis, pleuresías ó laringitis hasta que han padecido dispepsia. Esta es causa de palpitaciones, de la irregularidad de los latidos del corazon, y en algunos casos de verdaderas enfermedades de este órgano, de endocarditis. La tuberculosis sola no puede ser consecutiva á la dispepsia: no hay tisis de orígen gástrico; pero por el contrario, con frecuencia la tuberculosis produce

la dispepsia. La granulacion tuberculosa no viene de la dispepsia, de la digestion difícil, dolorosa: su orígen es todavía desconocido.

Cuando la granulacion existe, los accidentes pulmonares, las congestiones, las hemoptisis sufren la influencia del plexo; los esputos sanguíneos tienden á aparecer tres ó cuatro horas despues de la comida, y si el estómago está demasiado cargado de alimentos, excitado por manjares ó bebidas que no le convienen, el enfermo está más expuesto á las congestiones pulmonares, á los vómitos de sangre, en las horas en que se producen los síntomos de la enfermedad del estómago. El médico, al prescribir el régimen y los medicamentos al tuberculoso, deberá recordar las relaciones que existen entre el estómago y el pulmon; deberá siempre resguardar la funcion estomacal y prescribirá, no sin cierta aprension, la creosota, el aceite de hígado de bacalao, el vino, pues todas estas sustancias pueden perturbar el estómago, y consecutivamente la evolucion de la tuberculosis puede activarse.

CAPÍTULO XIV

CRISIS DE LOS CENTROS NERVIOSOS Y DE LOS NERVIOS

Cada centro, cada nervio está sujeto á crisis de dolor más ó menos intensas, que duran á veces veinticuatro, cuarenta y ocho horas y que pueden renovarse durante muchas semanas. En el intervalo de estas crisis toda huella de sensibilidad cesa en el centro ó en el nervio, ó bien uno y otro permanecen sensibles.

La célula cerebral produce crisis de dolores de cabeza intolerables, durante las cuales el enfermo siente la muerte próxima, y que pueden ser tan intensas que todas las facultades intelectuales se suspenden, que el individuo es incapaz de moverse y de percibir las impresiones del mundo

exterior. La crisis dura más ó menos horas consecutivas. Otras veces se observan crisis de vértigos, tales que el individuo no puede moverse en su lecho sin sentir náuseas y vómitos, de modo que se ve condenado á la inmovilidad absoluta como en los dolores de cabeza. Tales son las dos especies de crisis encefálicas que el médico observará más á menudo.

Las crisis de dolores intensos que provienen de la célula medular se observan con menor frecuencia. Ya he hablado de las crisis dolorosas del plexo, de los vómitos líquidos incesantes que se repiten durante muchas horas consecutivas, de las crisis de gases que duran dias y semanas. Llamaré especialmente la atencion sobre las de los tres centros abdominales, periumbilicales y subumbilical, que se acompañan frecuentemente de vómitos líquidos que se producen de tiempo en tiempo ó diariamente. Los dos centros periumbilicales alternan de ordinario con el plexo solar para producir la crisis, y ésta pasa de un centro al otro; siempre se consideran como dolores debidos á un cálculo renal ó hepático, ó hacen pensar en un tumor que empieza á desarrollarse en el abdómen. La

observacion de estos centros es de gran interés clínico.

El centro subumbilical produce las crisis tan comunes en la jóven que va á tener sus reglas por la primera vez, en la mujer en el momento de la menstruacion; estos accesos pasan del centro subumbilical á los centros periumbilicales, á la médula, y son á menudo reemplazados por dolores de cabeza, jaquecas. La excitacion de las células de los centros nerviosos da lugar á esas diversas especies de crisis que se suceden.

El nervio, como la célula nerviosa, es susceptible de producir una crisis dolorosa que todo el mundo conoce, sea en su trayecto, en su terminacion, en la piel, en el músculo ó en una articulacion. Un nervio cualquiera, quinto par, sétimo par, nervios intercostales, dorsales, ciáticos, nervios braquiales, etc., puede hacerse doloroso. Si el músculo, la piel, están hiperestesiados, la hiperestesia puede presentar inopinadamente gran intensidad, y entonces una crisis de hiperestesia se produce. Esta crisis puede durar muchas horas, y el individuo puede llegar á perder el conocimiento.

Todas estas crisis se terminan ordinariamente de una manera uniforme, ora por una expulsion de gases, ora por vómitos, porque las impresiones violentas de un centro ó de un nervio encuentran siempre eco en el plexo solar. Ninguna se muestra ordinariamente al principio de la neurosis, sino que tienen lugar en general cuando la enfermedad es antigua y significan un estado de sufrimiento profundo del centro nervioso.

Los dolores de los nervios pueden durar largos años y no cesan nunca espontáneamente: las inyecciones hipodérmicas de morfina los hacen durar, excitando los centros. He visto un enfermo de setenta años que tenia todos los dias, desde veinticinco años hacia, una crisis de los dos últimos nervios intercostales, y durante estos veinticinco años se habia hecho diariamente una inyeccion. Hice perder á este enfermo la costumbre de la morfina, curando sus centros nerviosos, causa de la neuralgia.

He sido llamado hace seis meses por un enfermo de cuarenta y ocho años, en cama desde hacia ocho meses. Cada dos dias tenia una crisis de hiperestesia de la piel del

muslo izquierdo en una extension de 10 centímetros, dolores atroces que se irradiaban hácia la médula, el plexo y el cerebro; tenia latidos arteriales en el cuello, palidecia y perdia el conocimiento, y estaba en un estado de debilidad tal que le era imposible moverse en su lecho. Desde hacia sis meses estaba sometido á un tratamiento hidroterápico que agravaba su estado; lo sometí á un régimen alimenticio severo y practiqué dos ó tres lavados del estómago: algunas semanas más tarde el estado dc los centros nerviosos se habia modificado, la hiperestesia habia desaparecido. El enfermo curó y pudo emprender de nuevo sus ocupaciones. Este enfermo habia sido tratado por los médicos más distinguidos, que ordenaron las duchas frias, que su sistema nervioso no podia tolerar, sometiéndole á una alimentacion sustancial que no podia soportar, de modo que habia llegado á la inanicion en medio de crisis horribles.

Todos estos hechos patológicos no pueden ser comprendidos con la patología actual, en la que el sistema nervioso ha sido mal interpretado. Cito este enfermo solo, pero podria citar gran número de otros

que, teniendo crisis de los centros abdominales, del cerebro ó de la médula, no han obtenido ningun alivio con la terapéutica inspirada por nuestra patología clásica. El médico no puede comprender la enfermedad en que el sistema nervioso está en juego si no sube al orígen, la irritacion de la célula nerviosa.

SEXTA PARTE

CAPÍTULO XV

REUMA Y GOTA

Desde la más remota antigüedad, el reuma y la gota están en estudio, y los médicos más eminentes se han ocupado en diferentes siglos de estas dos enfermedades tan comunes, sin dilucidar su naturaleza. La aplicacion de la química á la medicina no ha podido tampoco hacernos conocer su orígen. Habian sido reunidas las dos por los antiguos bajo una sola denominacion, artritis, ambas componian una sola entidad patológica, cuyo carácter fundamental era la enfermedad de la articulacion, su aumento de volúmen, sus dolores,

y toda la atencion se concentró en la articulacion, que es, en efecto, la víctima habitual de estas enfermedades. Los antiguos creian que estas enfermedades podian, como muchas otras, explicarse por la alteracion de los humores, y admitian que la sangre producia un humor acre que iba á depositarse en la articulacion; el reuma y la gota eran, pues, segun ellos, una sola y misma afeccion.

Baillou las separó el primero y distinguió en dos especies, y esta division fué conservada. La observacion de estas dos enfermedades ha ocupado hasta nuestra época muchos clínicos cuyos nombres es inútil citar. En nuestro siglo, en que la anatomía patológica ha servido de guía al análisis clínico, Bouillaud intentó clasificar el reuma articular entre las flegmasías, invocando la fiebre y la lesion articular; ahora bien, con frecuencia no hay ni fiebre ni lesion, los caractéres de verdadera flegmasía faltan, las principales lesiones del reuma no son las de las flegmasías propiamente dichas.

Los modernos, para definir el reuma, se aplicaron, pues, á trazar sus grandes rasgos clínicos, é insistieron sobre la instan-

taneidad de su desarrollo, la movilidad de los dolores, el paso rápido del mal de una articulacion á otra. y distinguieron el reuma que ataca el músculo, el nervio, la articulacion, denominándole, reuma muscular, articular ó neuralgia reumática.

Bouillaud y sus discípulos señalaron que el reuma no ataca sólo las serosas articulares, sino que tambien ataca la del pulmon y la del corazon. La pleuresía, la endocarditis, la pericarditis, fueron, pues, atribuidas al reuma y consideradas como su complemento, y con efecto, á menudo no aparecen sino despues que la articulacion ha sido atacada.

La patogenia nada ganó con estas investigaciones modernas, tan numerosas y tan interesantes; la sintomatología sólo fué completada.

No encontrando en los síntomas una base para definir la naturaleza de la enfermedad, se pensó en completarla invocando la etiología, y se dijo que el reuma aparece sobre todo en los jornaleros que desarrollan grandes fuerzas musculares y se exponen á enfriamientos, lo cual no tiene nada de exacto: el reuma es tan fre-

cuente en la gente acomodada como en los artesanos.

Bouchard, en su interesante obra sobre el relajamiento de la nutricion, añade, de acuerdo con algunos autores, que el reuma se encuentra acompañado de diversas especies de enfermedades, la litiasis, la piedra, las neuralgias, las dermatosis, la obesidad, la diabetes, y la coincidencia es exacta, aunque nada nos revela sobre sus relaciones con el reuma y nada nos enseña sobre la esencia del mal que sólo nos interesa.

Así, pues, el análisis clínico del reuma, perfeccionado en nuestra época, no nos instruye sobre la naturaleza de la enfermedad.

La gota ha sido el objeto de discusiones no menos numerosas, y los esfuerzos de los médicos se han multiplicado en extremo á propósito de esta enfermedad.

La gota aparece tambien con gran número de síntomas y la articulacion no padece sólo. El tofus es un carácter absoluto de la manifestacion gotosa y sin el cual la enfermedad no existe, y sin embargo muchos médicos han comprendido entre los gotosos á individuos que no presentan

tofus, sino únicamente dolores de cabeza, vértigos, dispepsia, etc., y aun algunos han sostenido que la gota puede existir sin que haya tofus.

La gota, á causa de la multiplicidad de sus síntomas, que no han podido aún ser clasificados por la patología, ha dado lugar á mucha incertidumbre, y la demostracion de este hecho se halla en la historia misma de la enfermedad.

Los médicos que trataban gotosos presentando, sobre todo, síntomas de dispepsia (Boerhaave, Broussais), la atribuyeron al estómago: Garrod, que ha estudiado los uratos de la sangre, la composicion química de los tofus y ha encontrado el ácido úrico en exceso en la sangre, ha edificado sobre este hecho químico una teoría humoral, segun la cual los alimentos en exceso que surten la mesa del rico, las carnes, los dulces, las grasas, etc., producen la dispepsia y alteran consecutivamente la sangre disminuyendo su alcalinidad por la produccion excesiva de ácido úrico; pero lo que no nos enseña Garrod es la relacion que existe entre el exceso de alimento de todo género y el aumento del ácido úrico, así como tampoco nos dice por qué es es-

pecialmente el ácido úrico el que aumenta en cantidad. Este autor acusa al estómago; pero la gota es una enfermedad poco comun, incluso entre las personas que comen demasiado, que se vuelven dispépticos y no gotosos: la gota indica una disposicion hereditaria, y es en su sentir una discrasia úrica con fluxiones articulares, siendo la enfermedad del rico, así como el reuma es la enfermedad del pobre. Para demostrar que esta clasificacion social no es cierta, presentaré un hecho que he citado ya en la Sociedad de Biología. He recibido en mi hospital á un desgraciado músico ambulante que no tenia que comer desde hacia muchos años y estaba en la miseria más profunda, y que tenia las manos y los pies cubiertos de tofus que hicieron caer los dedos de los pies por la gangrena. Este desgraciado murió en el hospital á consecuencias de ella.

Garrod ha hecho una teoría humoral impulsado por sus análisis químicos, dejando de lado la clínica.

Cullen se aplicó á estudiar los síntomas nerviosos que habia encontrado; los dolores de cabeza, los desvanecimientos, los dolores musculares, le hicieron pensar que

el sistema nervioso era la causa de la gota; así pues, cada autor, preocupado por sus observaciones, sacaba deducciones diferentes segun los hechos culminantes que se presentaban á su atencion.

En el reuma y la gota la articulacion es la más frecuentemente atacada; este hecho ha sido notado especialmente por los autores, y como es principalmente la que padece, esta coincidencia llamó sobre todo la atencion de los médicos. En la gota la circulacion se altera por el tofus, que no existe en el reuma, pero en la una como en el otro puede haber fiebre, aumento de volúmen y deformacion de la articulacion; semejanzas superficiales que fueron invocadas para decir que ambas enfermedades resultan de un mismo principio morboso, que están unidas por un estrecho parentesco, que son como las dos ramas del mismo tronco, y que tanto la una como la otra se deben á una misma disposicion morbosa, en virtud de la cual un individuo tendria la gota y otro el reuma; esta disposicion morbosa ha sido denominada diátesis artrítica, artritismo.

En el reuma, todas las articulaciones pueden ser atacadas simultánea ó suce-

sivamente; en la gota una sola articulacion, la del dedo grueso del pie, empieza de ordinario por ser atacada; las otras articulaciones del pie, la rodilla, las de la mano, del codo, enferman sucesivamente. Cuando la generalizacion se ha afectuado, ambas enfermedades se parecen y no se distinguen más que por el tofus. El reuma puede producir hidropesías articulares y atacar su sinovial y su cartílago.

Como estas dos afecciones tienen puntos de contacto, se han buscado los caractéres diferenciales: el reuma, se dice, provoca la endocarditis, y la gota respeta el corazon. Esto no es clínicamente exacto, puesto que la serosa cardíaca puede impregnarse de tofus, y que con frecuencia en el reuma el corazon permanece indemne. Ambas enfermedades presentan numerosas analogías; la uricemia nada nos enseña sobre la patogenia de la gota; es necesario conocer el orígen de la uricemia, y Garrod no nos lo indica diciendo que la alimentacion abundante la produce, puesto que un individuo miserable, alimentado insuficientemente, puede tenerla.

No queda, pues, para explicar el reuma

y la gota, segun los patólogos, más que la palabra vicio artrítico, que resume su procedencia.

Las complicaciones de piedra, litiasis, dermatosis, obesidad, que se observan en el reumático, se encuentran igualmente en el gotoso.

Busquemos con la clínica las condiciones de produccion de la gota y del reuma, y en qué casos se desarrollan las dos enfermedades.

No citaré más que dos observaciones de gota; podria presentar gran número de ellas, pero todas son idénticas.

Un negociante, de edad de cincuenta y cuatro años, ha tenido en numerosas ocasiones, y muchos años consecutivos, accesos de gota en el dedo grueso del pie izquierdo y en la articulacion tibio-tarsiana izquierda; un tofus ha quedado en el dedo del pie. El mismo enfermo ha tenido muchos años ha, en su juventud, dolores de cabeza y vértigos; más tarde, neuralgias del trigémino y del ciático; actualmente sufre de dolores estomacales y gases.

Un anciano de setenta y dos años me cuenta que en su juventud ha tenido accesos de asma, despues cólicos nefríticos

y numerosos accesos de gota en el dedo grueso; viene á consultarme porque desde hace un año experimenta una sensacion de estrangulacion, sufre hipo, arroja pituitas y gases, y le es imposible alimentarse porque, tan pronto como se sienta á la mesa, la sensacion de estrangulacion aparece y el tialismo se renueva.

Hé aquí dos tipos de gotosos bien característicos: el uno empieza por los dolores de cabeza y los vértigos en su juventud (síntomas de irritacion cerebral); más tarde vienen las neuralgias de diferentes nervios, trigémino y ciático (síntomas de irritacion medular); en fin, el plexo solar se perturba, y el enfermo se vuelve dispéptico. Los accesos de gota se presentan en medio de estos síntomas.

El segundo enfermo no tiene más que asma (síntoma de irritacion medular); al asma sigue la irritacion del plexo, la dispepsia; los cólicos nefríticos y el acceso de gota vienen á complicar toda esta sintomatología.

Así se presenta siempre la gota precedida de fenómenos cerebrales, de fenómenos medulares y de síntomas del plexo irritado; la irritacion de los centros trae

como consecuencia los accesos de gota, pero es necesario saber cómo la irritacion de los centros la determina.

He indicado más arriba las modificaciones químicas de la secrecion urinaria, disminucion de la urea, aumento del ácido úrico. La litiasis renal, los cólicos nefríticos siguen la irritacion de los centros; si el ácido úrico, en vez de eliminarse por la orina se acumula en las partes fibrosas que circunscriben la articulacion, ó en la articulacion misma, la gota se produce.

Los centros nerviosos irritados alteran la nutricion, crean la uricemia y determinan en el individuo predispuesto por la herencia un acceso de gota; los alimentos, las bebidas fermentadas, no producen la gota; pero ambos irritan los centros, y en este caso, la gota es posible. Por tal motivo, esta enfermedad puede observarse lo mismo en el pobre, cuyos centros nerviosos están irritados por la necesidad y la miseria, que en el rico que irrita sus centros con una alimentacion excesiva. Estos datos prueban el error de Garrod, al creer que la dispepsia produce la gota á causa de la digestion incompleta. La insuficiencia de oxidacion de las materias

azoadas proviene del sistema nervioso directamente; un individuo puede comer y beber con exceso durante cierto tiempo, y mientras el sistema nervioso esté intacto, no tendrá ni dispepsia, ni litiasis, ni gota; pero como rápidamente el exceso de alimento, de bebidas fermentadas irritará los centros, aparecerán los dolores de cabeza, los vértigos, las neuralgias, el asma, la dispepsia, los cólicos hepáticos ó nefríticos y, finalmente, la gota.

Tal es el orígen de esta afeccion, que el individuo nacido de gotoso podrá evitar si se mantiene en una buena higiene y si no fatiga sus centros nerviosos; pero tan pronto como aparezca un síntoma cualquiera de estos centros, la vía á la gota queda abierta, y la enfermedad puede durar tanto tiempo como los centros tarden en volver á su estado de equilibrio.

El reuma es la enfermedad tan comun que el médico observa en todas las edades, que ataca el músculo, el nervio, la articulacion, las serosas y que compone el segundo término del artritismo. ¿Cuál es su significacion? ¿cuál su valor patológico?

Empieza en un individuo por una sencilla neuralgia ciática ó intercostal; en

otro por dolores articulares, crujido articular ó una generalizacion articular, aumento de volúmen de la articulacion, hidropesía de la serosa y fiebre. Esto es lo que los patólogos han llamado reuma articular generalizado: en unos casos su primera manifestacion es la hidartrosis, en otros las pequeñas articulaciones de los dedos son atacadas simultánea é inopinadamente; las articulaciones digitales de la mano y del pie se deforman, y dan lugar á crisis dolorosas; tal es el reuma llamado gotoso, que se acusa por dolores en el músculo y la articulacion, dolores que duran algunos días, con fiebre ó sin ella, y se repiten. Estos accidentes reumáticos concluyen por deformar las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies.

Pero aun existen otros tipos: una pleuresía ó una endocarditis se desarrollan espontáneamente, sin causa por decirlo así, sin enfriamiento, y el clínico diagnostica una pleuresía ó una endocarditis de orígen reumático; si las articulaciones y los músculos se vuelven dolorosos consecutivamente, su diagnóstico sobre la naturaleza de la pleuresía ó de la endocarditis es in-

dudable: una ú otra son de orígen reumático. ¿Qué es, pues, el reuma? ¿Qué es esta enfermedad que recorre así todo el organismo, atacando sucesivamente todos los órganos de la vida de relacion, todas las vísceras, y cuyos caractéres notados hasta el día por los patólogos son la movilidad, la facilidad de cambiar de lugar, sus migraciones continuas, sus desapariciones y sus recaidas, que traen consigo algunas veces deformaciones incurables de las articulaciones?

Ciertos medicamentos, el salicilato de sosa, el ioduro de potasio, triunfan algunas veces en dos ó tres días de los dolores y el reuma continúa su evolucion; cuando se acompaña de fiebre, el sulfato de quinina puede disminuirla ó hacerla desaparecer; pero se trata de una medicacion empírica, aplicada á una enfermedad de que se desconoce la naturaleza y la significacion.

Busquemos, pues, la significacion, la patogenia de esta afeccion. Observando por los hechos clínicos cómo se desarrolla, de qué síntomas se compone, cuál es su marcha, cuál su evolucion, mostraré al lector su patogenia.

En el reuma todos los centros nerviosos son atacados, todos los nervios sensitivos, motores, vaso-motores, tróficos son afectados sucesivamente.

Una mujer de cuarenta años ha tenido á la edad de veinte un reuma articular de la rodilla, que al desaparecer es sustituido por dolores atroces de cabeza, por los que ha sido enviada cuatro años consecutivos á Ragaz. Estas estaciones repetidas calman los dolores de cabeza, que son reemplazados por la dispepsia, y desde entonces cada una de las comidas es seguida de crisis dolorosas del estómago; actualmente el ganglio nervioso periumbilical y el plexo lumbo-aórtico son sensibles á la presion. El reuma de la rodilla es el signo de la irritacion de la médula, á ésta sigue la irritacion cerebral, y, en fin, aparecen la del plexo y la de los otros centros nerviosos abdominales. El reuma en esta enferma no es más que la irritacion de los centros nerviosos.

Un jóven de veintiocho años viene á consultarme, y me cuenta que á los doce años ha tenido un reuma articular de la rodilla izquierda; idéntico comienzo que en el caso precedente; el reuma es reemplazado

por vértigos y una neuralgia facial del lado izquierdo. En la actualidad toda la mitad izquierda del cuerpo está hiperestesiada, el plexo solar es doloroso á la presion; el enfermo sufre de calambres de estómago, de pirosis, de gases; en este caso, que empieza por la rodilla, se producen igualmente los síntomas de irritacion de los centros nerviosos.

Otro individuo se vuelve reumático á consecuencia de disgustos. Un hombre de cincuenta y tres años tiene, á consecuencia de violentos pesares, vértigos, zumbidos en el oído izquierdo, más tarde la articulacion del codo y la del puño se hinchan y acusan dolor; su médico lo envia á Aix.

Una jóven de veinte años entra en mi hospital con reuma de la articulacion del codo, consecutivo á disgustos; ha perdido á su madre, y ocho días despues el codo está rojo, hinchado y sus movimientos son imposibles.

El reuma puede ocupar una ó muchas articulaciones; el reuma articular agudo generalizado tiene el mismo orígen que el reuma mono-articular, y se produce en medio de los mismos fenómenos que este

último, ó la hidartrosis, ó el crujido articular.

Un abogado de veinticinco años me dice que siempre ha tenido dolores de cabeza y dispepsia; ha sido atacado en 1877 de reuma articular generalizado, y hoy, 1886, sufre todavía de calambres de estómago, de pirosis. Tan pronto como sufre del estómago, resiente una compresion en toda la extension de la columna vertebral y una constriccion de la cabeza.

Una señora de sesenta y dos años sufre, desde la infancia hasta sesenta años, de dolores de cabeza, de vértigo; los músculos del brazo derecho y las articulaciones están doloridos; la rodilla derecha, dolorosa, está llena de líquido; la articulacion del pie presenta ruidos anormales y el estómago arroja gases todo el día. Hé aquí una larga carrera patológica que empieza por la irritacion cerebral; la de la médula es consecutiva y se traduce en los nervios sensitivos, en los tróficos, y entonces los músculos, las articulaciones, se hacen sensibles, los cartílagos se alteran y el líquido se acumula en la articulacion.

Presentaré, por último, otro caso en que el reuma no produce más que dolores en

los músculos y las articulaciones, sin aumento de volúmen ni fiebre.

Una señora de veintiocho años sufre hace muchos de jaquecas; además ha tenido dolores en los músculos del muslo, en las articulaciones de los dedos y es dispéptica.

Todas estas observaciones muestran al reumático sufriendo primero de la irritacion del cerebro, más tarde de la irritacion de la médula y en último término de la del plexo solar: todos los síntomas consisten en la irritacion de los centros.

En algunos casos el reuma empieza por la médula, y entonces los nervios, los músculos del cuello y sus articulaciones, los músculos y la articulacion del hombro se hacen dolorosos, y el dolor se extiende á la extremidad del miembro superior, á las pequeñas articulaciones digitales; á los síntomas medulares seguirán los síntomas cerebrales y los del sistema nervioso abdominal.

Así pues, el reuma es la expresion de la irritacion de los centros, cualesquiera que sean los síntomas, cualquiera que sea su forma, lo mismo cuando empieza por una articulacion ó por un nervio ó por un

grupo de músculos, que cuando comienza por los síntomas cerebrales ó estomacales.

La significacion es la misma cuando los nervios tróficos se afectan y aparecen ruidos articulares, deformaciones articulares.

Un médico de cuarenta y cuatro años viene á consultarme sobre ruidos articulares que le molestan en la marcha, y me hace la historia de su larga enfermedad; ha tenido, jóven aún, jaquecas, vértigos, zumbidos en el oído izquierdo, estrabismo del ojo izquierdo; tiene un coriza continuo y es dispéptico.

Otro enfermo de cincuenta y tres años, que se queja de dolores y de crujidos articulares, ha tenido á la edad de catorce años dolores de cabeza, vértigos, aturdimientos; tiene la vista debilitada, epistaxis frecuentes y es dispéptico.

En resúmen, todos los síntomas que preceden ó siguen la manifestacion articular se desarrollan con la mayor uniformidad, con la mayor monotonía.

Puede suceder que el primer fenómeno sea el reuma articular agudo generalizado, que significa irritacion de la médula;

pero de ordinario ha sido ya anunciado por la irritacion cerebral. Puede suceder que una sola articulacion sea atacada; al reuma articular siguen entonces los fenómenos cerebrales, los del estómago, y más tarde, otros síntomas medulares. Lo que se denomina reuma durará tanto como la irritacion de los centros nerviosos.

El reuma puede empezar por crujidos articulares y los otros síntomas no presentarse sino más tarde. Con frecuencia una sola articulacion, la del dedo grueso del pie, está roja y dolorosa, pero sin tofus; cuando no es la del dedo grueso, diversas articulaciones del tarso ó del metatarso enrojecen y aumentan de volúmen; estos hechos, confundidos siempre con la gota, no son más que la expresion de la irritacion de los centros nerviosos. En vez de ruidos articulares, de exóstosis, los nervios tróficos pueden engendrar la pleuresía, la endocarditis; la enfermedad puede circunscribirse á estas solas manifestaciones si los centros nerviosos vuelven al reposo; pero si no se trata la enfermedad, á la pleuresía, á la endocarditis seguirá una serie de padecimientos de los centros.

Un enfermo de cuarenta y tres años es atacado hace veinte, á consecuencia de largas fatigas intelectuales y de trabajos físicos, de un dolor atroz en la parte media de la columna vertebral, y más tarde por una endocarditis (ruido de soplo rudo en la punta del corazon en el primer tiempo); y por último, aparecen los dolores de los nervios del brazo y de sus músculos; el enfermo sufre constantemente y resiente tambien vértigos, vacío en la cabeza, zumbido en los dos oídos, tiene crisis de gases que duran noches enteras. La enfermedad ha atacado, pues, primero los nervios tróficos de la serosa cardíaca, despues los nervios sensitivos de los músculos y de las articulaciones y, por último, el cerebro se ha irritado consecutivamente.

En el reuma, los nervios vaso-motores de la piel se irritan tambien, y esto nos explica los sudores profusos á que está sujeto el individuo atacado de reuma; los de los vasos se irritan, y la aglobulia aparece, así como la palidez de la piel, que anuncia tan á menudo la enfermedad, ó que no aparece sino en el curso de ésta: la anemia de los reumáticos es la consecuencia de la irritacion de los centros.

Creo haber puesto en evidencia los caractéres del segundo término del artritismo, el reuma, de manera que sea posible dar una definicion y comprender su patogenia.

El reuma es la manifestacion de la irritacion de los centros; sea cualquiera su forma, muscular, nervioso, articular, que se acompañe de fiebre, que se localice ó se generalice, ora ataque las serosas del pulmon ó del corazon, ora los nervios vasculares ó los de la piel, el reuma tiene siempre su orígen en la irritacion de los centros nerviosos, y se anuncia de ordinario por la irritacion del cerebro ó del plexo. Tiene por carácter invadir despues toda la economía, y no se cura, como la gota, hasta que el sistema nervioso se restablece. El reuma no constituye una entidad patológica; el término reuma no tiene, hasta el presente, un sentido definido, como la gota; uno y otra deben ser reunidos, porque tienen un mismo orígen, una misma causa: en la gota, el tofus es la consecuencia de la alteracion de la nutricion; en el reuma, la degeneracion del cartílago, la exóstosis, las alteraciones de las serosas traducen la lesion de nutricion;

los síntomas de una y otra afeccion son los síntomas de los centros irritados, con influencias diferentes sobre la nutricion. Por consiguiente, el artritismo no tiene razon de ser, como tampoco el herpetismo; el término artritismo, que significaba enfermedad de la articulacion, era provisional, y es necesario restituir actualmente al sistema nervioso lo que le pertenece, puesto que engendra la gota y el reuma. El individuo debe resguardar y fortalecer su sistema nervioso si quiere evitar estas afecciones; los medicamentos no son más que paliativos momentáneos.

El individuo que ha tenido ya una crisis de reuma, que ha soportado un acceso de gota, se verá atacado nuevamente tan pronto como haya fatigado su sistema nervioso por excesos de trabajo intelectual ó físico, por pesares ó por un mal régimen alimenticio; una buena higiene le tendrá al abrigo de estas dos enfermedades.

CAPÍTULO XVI

OBESIDAD.—ENFLAQUECIMIENTO

En patología, como en las ciencias en general, la solucion de un problema conduce á menudo á la de otros más complejos en apariencia, más difíciles de resolver que el precedente.

Acabo de demostrar que el reuma, la gota, artritismo de los antiguos médicos, no es más que el producto de la irritacion de los centros nerviosos, produciendo las alteraciones de nutricion propias á una y otra de estas modalidades patológicas, los padecimientos de los nervios, de los músculos, de las articulaciones.

Voy á buscar ahora la significacion de la obesidad y del enflaquecimiento, su valor clínico, su verdadera etiología.

La obesidad es la acumulacion excesiva

de grasa en el tejido celular de la piel del abdómen, en la piel del cuello, de los miembros, en los intersticios de los músculos, en las vísceras, de tal suerte que el funcionamiento de éstas se hace más difícil.

El enflaquecimiento es la disminucion progresiva de la grasa en el tejido celular subcutáneo, en los intersticios musculares, la disminucion del tejido muscular mismo, y finalmente, la desaparicion completa de la grasa, el empobrecimiento de los tejidos y de los líquidos.

Cuando la obesidad ó el enflaquecimiento van más allá de cierto grado, la vida entonces se hace imposible y sobreviene la muerte.

¿Qué es, pues, la obesidad? ¿qué es el enflaquecimiento? La obesidad y el enflaquecimiento pueden aparecer en todas las edades. La primera se observa en los niños. Ciertos autores han dicho que la obesidad se observaba en los niños israelitas y era bastante comun en ellos; esta observacion denota que esos autores no han comprendido la obesidad, que depende del individuo y no de la raza.

La obesidad aparece sobre todo en la

edad en que el sistema nervioso empieza á perder su vigor, hácia los cuarenta y cinco ó cincuenta años: frecuentemente se muestra entre veinte y treinta años si los centros nerviosos están irritados, pues esta es la edad en que los jóvenes cometen excesos de todo género que los fatigan. Muchos individuos flacos se ponen obesos á consecuencias de una enfermedad febril, una fiebre eruptiva, una pneumonía, y muchas mujeres que tenian un talle fino y elegante antes del matrimonio engordan inmediatamente despues del primer parto, y esta obesidad va en aumento.

Hay otros individuos que conservan en toda edad una flaqueza exagerada: hay niños que comen mucho, enflaquecen sin cesar y permanecen pálidos: hay adultos ó personas llegadas á la madurez ó á la vejez que enflaquecen rápidamente. He observado pérdidas de 10, 20, 30, 50 libras en el espacio de algunos meses, y estas pérdidas tenian lugar al mismo tiempo que la alimentacion habia sido considerablemente aumentada: el alimento se digeria, la economía no hacia ninguna pérdida materialmente apreciable ni por diarrea, ni por sudores, etc. ¿Qué hace el

alimento en exceso? ¿por qué á pesar suyo disminuye el peso?

En fin, en ciertas personas hay alternativas de obesidad y enflaquecimiento; un obeso enflaquece de una vez 40 libras y permanece flaco, ó bien esta pérdida de peso es pasajera y la obesidad primera se recupera algunas semanas ó algunos meses despues.

La obesidad que llega á cierto grado es un estado morboso que, lejos de indicar una exuberancia de salud, denota enfermedad; el enflaquecimiento que se produce rápidamente ó de un modo continuo indica que el organismo sufre.

Cada individuo al nacer está destinado á un volúmen determinado, y he observado que si éste aumenta sensiblemente ó si disminuye en demasía es porque el individuo está enfermo.

Muchas veces he podido anunciar, entre los enfermos del hospital, muy obesos unos, en extremo enflaquecidos otros, que tal de entre ellos debia disminuir de volúmen y tal otro engordaria, gracias al régimen. Diariamente en mi consulta digo á tal enfermo que está demasiado grueso y que debe enflaquecer para gozar salud, y mis

previsiones se realizan: disminuye en dos ó tres meses 25 libras. A tal otro, demasiado delgado, anuncio que engordará y gana 15 ó 20 libras en el mismo espacio de tiempo: mi pronóstico se realiza siempre.

El organismo está, pues, sometido á ciertas condiciones de estado, cuya violacion se traduce por la acumulacion ó la pérdida de la grasa, y el individuo disminuirá ó aumentará su alimento, y sin embargo continuará engordando ó enflaqueciendo. Los médicos que hacen química en vez de clínica aconsejan al obeso grandes ejercicios, gimnasia, armas, equitacion, y el obeso engorda á pesar de todo; sostienen que la grasa es debida á un relajamiento de la nutricion y que los movimientos excesivos aumentarán las combustiones, la cantidad de ácido carbónico á expensas de la grasa.

Para probar que están en un error, recordaré la historia de un enfermo que sufria desde hacia tres años de neuralgias intercostales y presentaba una obesidad exagerada: le anuncié que curaria de sus neuralgias y que enflaqueceria; las neuralgias habian desaparecido tres semanas despues, pero la grasa no habia disminuido y el enfermo se quejaba de no haber perdido

un solo gramo de peso; le hice observar que los ejercicios excesivos á que le obligaba su profesion le impedian enflaquecer, y que si queria llegar á este resultado era necesario guardar el reposo durante algun tiempo; el enfermo se condenó á la inmovilidad durante diez días, y en ese tiempo perdió 4 libras. La razon es que las fatigas físicas cansaban los centros nerviosos que rigen la nutricion, y que cuando éstos se cansan la nutricion se altera, la urea y el ácido carbónico disminuyen y la grasa aumenta.

El consejo dado por los médicos en general de hacer mucho ejercicio para enflaquecer se refiere á las reacciones químicas que deben aumentar por el trabajo muscular, y olvidan los centros nerviosos que presiden la contraccion muscular y que falsean la química cuando están perturbados. Los centros presiden la química de la economía, y nuestra intervencion con los agentes químicos no tiene accion ninguna sobre los centros nerviosos. Hemos visto que el tofus de la gota, las alteraciones de cartílagos y sinoviales en el reuma se deben á la irritacion de los centros; del mismo modo, la acumulacion de

grasa ó su disminucion exagerada, es decir, el vicio de nutricion acusado por estos dos hechos patológicos, es la consecuencia de la irritacion de los centros nerviosos.

La grasa tiene un papel complejo: importada por el alimento, sirve sobre todo para la combustion, se descompone en ácido carbónico y en agua y mantiene la temperatura del cuerpo á 37°, ó bien se deposita en los tejidos y sirve para reemplazar el alimento cuando la cantidad de éste es insuficiente; en este último caso, la grasa es un alimento en depósito. Cuando el individuo tiene los centros nerviosos irritados, no es sólo la grasa importada la que se deposita en los tejidos, todos los alimentos, materias azoadas, azúcar, féculas producen menos urea, menos ácido carbónico y se convierten en grasa y la temperatura del cuerpo disminuye. Todas estas sustancias contribuyen á aumentar el volúmen del cuerpo; la carne, el azúcar, así como los feculentos, se vuelven grasa; el alimento no hace su papel habitual y se desvia de su funcion. Pero en cuanto los centros nerviosos se calman, la grasa disminuye, la obesidad cesa, y aunque el médico aconseje los feculentos, que tienen tan

deplorable reputacion, el enfermo enflaquecerá alimentándose con fécula.

Dos señoras enfermas vinieron á consultarme. La una, de treinta y siete años, atormentada por su flaqueza excesiva y la palidez de su tez, me contó que desde hacia veinte años sufria de dolores de cabeza, de dolores á lo largo de la columna vertebral y en los músculos de la cara; todos los músculos del cuerpo estaban hiperestesiados, no tenia apetito, era dispéptica y habia tenido un zona. La segunda, de sesenta y tres años, se quejaba de su obesidad, de dolores de cabeza y de las rodillas que la impedian andar más de cinco minutos; tenia, además, por momentos, un apetito voraz que la obligaba á levantarse de noche para comer.

Una y otra, la enflaquecida y la obesa, fueron sometidas á un tratamiento que tenia la mayor uniformidad; las féculas componian gran parte de su alimentacion: la casualidad quiso que la una y la otra volvieran á la consulta tres semanas despues; ambas me dieron gracias reiteradas, la primera por haber engordado ya de 4 á 5 libras, la segunda por haber enflaquecido de 5 á 6. La una y la otra sentian

su estado general muy mejorado. La primera fué curada en nueve meses de una enfermedad que duraba desde hacia veinte años y engordó 18 libras, y la segunda enflaqueció en tres meses 20 libras. Así engordó una y enflaqueció otra con el mismo régimen, dos enfermas alimentadas con féculas; la una ha ganado y la otra ha perdido en peso con estos alimentos que, segun dicen los químicos, producen siempre grasa.

Hay, pues, en la obesidad y en el enflaquecimiento algo más que sencilla química y reacciones que sufren los alimentos en el organismo; la obesidad y el enflaquecimiento no pueden, pues, ser previstos por la química.

Estos hechos patológicos no dependen de la química; uno y otro significan enfermedad. Pero ¿cuál es su causa y cómo el médico puede combatirlos? Como de costumbre, haré conocer por la clínica su significacion, su patogenia.

El alimento, cualquiera que éste sea, produce acumulacion de grasa ó la hace desaparecer cuando los centros están irritados; la grasa disminuye ó reaparece cuando aquéllos se calman.

La obesidad aparece en los niños cuando aparecen los síntomas de los centros. He sido consultado á propósito de una niña de catorce años de un volúmen enorme: la piel del vientre, del cuello, de la barba, estaba ya sobrecargada de grasa; desde algun tiempo sufria dolores de cabeze, de insomnios, tenia un coriza continuo y una angina faríngea; era además dispéptica y dos veces por mes, cuando el plexo se ponia doloroso, tenia crisis nerviosas, disturbios en la vista, contractura en los miembros y lloraba.

Una señora de cuarenta y cuatro años que ha tenido grandes pesadumbres, sufre jaquecas, vértigos, zumbido de oídos, temblores musculares y se vuelve dispéptica. Cuando todos los centros han manifestado su irritacion, la nutricion se ha alterado, la grasa se ha depositado en exceso en el tejido celular subcutáneo y su peso ha aumentado 36 libras: esta señora ha engordado á consecuencia de pesares. La obesidad se produce, pues, cuando los centros están irritados.

Un hombre de cincuenta y un años tiene desde hace siete vértigos, está sordo del oído derecho, tiene hormigueos en las

manos y en los pies, es dispéptico. El estómago está enfermo: el sistema nervioso está desequilibrado hace siete años y el enfermo ha perdido desde el primer año 35 libras de peso que no ha recuperado.

A la irritacion de los centros sigue, pues, en unos la obesidad y el enflaquecimiento en otros.

Una señora de veintiseis años que tiene la cabeza pesada, las facultades mermadas, zumbido de oídos, dolores en las articulaciones de los brazos y de las piernas, palpitaciones, angina faríngea, se vuelve dispéptica y pierde en ocho meses 48 libras.

Un hombre de cuarenta años que sufre vértigos, insomnios, debilitacion de la vista, zumbido de oídos, dispepsia, pierde 60 libras.

Otros individuos que presentan signos de irritacion de los centros, engordan y se ponen obesos para enflaquecer cuando los centros se calman y reengordar tan pronto como éstos se irritan de nuevo.

La obesidad puede aparecer como primer signo de la irritacion de los centros, lo mismo que el reuma de una articulacion, una neuralgia, una dermatosis, el

cólico hepático, la ictericia, la dispepsia. Los otros síntomas de irritacion no se muestran sino más tarde; con el enflaquecimiento sucede lo que con la obesidad, ó bien uno y otra aparecen en el curso de la neurosis, no se modifican mientras dura ésta y no empiezan á disminuir hasta que los centros nerviosos se calman, y el obeso ó el flaco no recuperan su peso normal hasta que los centros nerviosos estén curados. La obesidad empieza despues de una enfermedad que ha irritado los centros; despues del embarazo, despues de un parto la mujer engorda, porque el embarazo y el parto han irritado los centros nerviosos: los pesares, las fatigas físicas, una mala alimentacion tienen la misma influencia patológica. Mientras los centros nerviosos están en reposo, el alimento, cualquiera que sea su naturaleza, su composicion y su cantidad, se transforma sólo en urea y ácido carbónico; la química del organismo se hace normalmente y no se altera hasta el momento en que los centros nerviosos sufren, y entonces el individuo engorda ó enflaquece.

La naturaleza tiende á volver al estado fisiológico; el organismo desea curarse,

pero es necesario que el régimen general, la higiene, se adapte á la situacion; el sistema nervioso tiene sus exigencias, que si se satisfacen, permiten al individuo hacer grasa ó perderla: el sistema nervioso se servirá de todos los alimentos que se le ofrecen para restablecerse; pero la condicion fundamental es que los alimentos no irriten los centros.

Hé aquí un caso muy interesante que nos lo demostrará.

En 1883, mi amigo Ed. Grimaux, profesor de química en la Escuela Politécnica, vino á consultarme á propósito de una parienta suya que, despues de haber pasado cuatro meses en París para curarse, fué enviada al departamento de la Charente moribunda. Habia sido asistida por clínicos muy distinguidos, profesores de la Facultad de Medicina de París, que aplicaron al tratamiento de esta enferma los principios médicos que enseñan: alimentacion rica en carne, vino, etc., á causa de su flaqueza y palidez; habia perdido 60 libras y su alimentacion habia continuado debilitándola, enflaqueciéndola, y cuando uno de sus parientes, médico en la Charente, la vió á su vuelta, en el lecho é

incapaz de moverse, anunció una muerte próxima que se pintaba ya en su fisonomía.

El Sr. Grimaux vino entonces á rogarme que la tratara por correspondencia.

Se trata de una mujer de treinta y cinco años que sufre de jaquecas hace muchos y es dispéptica, que vomita hace diez y ocho meses todos los alimentos y no toma más que una taza de café con leche por día desde hace dos meses, lo cual quiere decir que la muerte por inanicion se aproximaba. Paso en silencio la mayor parte de los síntomas de la irritacion de los tres centros, y reconocí esta enfermedad tan comun, la neurosis, en la que los patólogos, no preocupándose más que de la anemia, hartan al azar al enfermo de alimentos y bebidas, sin tener cuenta del estómago ni del sistema nervioso; sus doctrinas químicas llegan á un resultado constante: aniquilan el sistema nervioso y el enfermo muere. Esto estuvo á punto de suceder á la prima de mi amigo Grimaux.

Hé aquí mi primera prescripcion, que comenzó á ejecutarse en mayo: prohibicion absoluta de recibir ninguna visita, inmovilidad absoluta del cuerpo, de tal modo

que la enferma debia recibir los alimentos sin hacer ningun movimiento, reposo absoluto del espíritu y prohibicion de conversar con ella; hice aplicar algunas cantáridas en la cabeza y en el estómago, y prescribí, con el objeto de calmar este último, una toma de fosfato de cal y de bismuto, etc., y como alimentacion:

En mayo, un litro de leche, un huevo, dos yemas de huevo y dos platos de fécula con leche cada día; los vómitos cesaron ocho días despues.

Del 17 al 25 de mayo los centros habian experimentado cierta calma y la enferma engorda una libra.

En junio aumento la alimentacion añadiendo un huevo, y la enferma engorda 7 libras en el mes; hé aquí cómo se reparte el aumento de peso: gana una libra en cinco días, una libra en dos días, una libra en seis, una libra en dos y una libra en ocho días; de modo que la enferma, que pesaba á mediados de mayo 93 libras, pesa 101 á fines de junio. Este aumento rápido de peso muestra la tendencia del organismo á utilizar toda especie de alimento que no irrite el plexo para volver á la vida: el organismo quiere vivir.

Continúo el tratamiento siempre por correspondencia sin conocer á la enferma.

En julio añado medio litro de leche, dos huevos y dos yemas; tres veces por semana jugo de carne, y por la primera vez prescribo, una vez por semana, 30 gramos de carne de carnero; esta carne no es dada como alimento, sino para imponer cierta actividad al plexo.

En julio, la enferma gana 9 libras, repartidas como sigue: una libra en seis días, otra en dos; una libra en otros dos días, otra en dos; una libra en tres días, otra en dos; una libra en dos días, otra libra en uno. Llamo la atencion del lector sobre la rapidez del aumento de peso y el esfuerzo de la economía para asimilarse el alimento que le conviene, cuando sucumbia con los alimentos ricos, las carnes, etc.

En agosto, añado aún dos huevos, y la enferma recibe tres veces en el mes 20 á 30 gramos de carne; engorda 7 libras, y pesa 118. En este mes, un vómito se produce; la enferma pierde 2 libras, pero las recupera rápidamente.

En setiembre, idéntica alimentacion, y toma nueve veces carne en el mes: la enferma gana 6 libras y llega á 125.

En octubre, mismo régimen: toma carne cinco veces y engorda 4 libras, es decir, que su peso es de 129 libras; la enferma adelanta rápidamente hácia el peso definitivo, su peso de salud, y por lo tanto el aumento de peso va á disminuir.

En noviembre, mismo régimen: carne tres veces, y el mismo régimen es seguido hasta mayo de 1884. En noviembre, la enferma gana 4 libras; en diciembre, 4; en enero y febrero, 2; en marzo, 3; en abril, 2, y en mayo, 3. El peso es de 153 libras; éste es su peso normal, y la enferma no pasa de este peso natural, que habia disminuido por la irritacion de los centros de tal modo que la muerte era inminente; la curacion de los centros, debida al tratamiento durante un año, la habia vuelto al estado de salud.

Ningun hecho más demostrativo puede aducirse en apoyo de mis observaciones y de mis datos clínicos: hé aquí una enferma que es observada y asistida cuatro meses por los médicos más instruidos y que va á morir; yo la trato á distancia sin haberla visto, reconociendo los fenómenos de la neurosis, y la curo.

Nada hay de más concluyente para la

veracidad de mis estudios; he curado á muchos individuos que no habian podido curar con la medicina actual, la medicina química, que olvida el sistema nervioso y desconoce las leyes fundamentales de la salud.

En resúmen, obesidad ó enflaquecimiento aparecen bajo la influencia de la irritacion de los centros nerviosos; nacemos con un peso determinado que aumenta con el desarrollo del cuerpo, pero que le es siempre proporcional; siempre que el médico lo vea aumentado ó disminuido en exceso, puede estar seguro de que el sistema nervioso está turbado. El sistema nervioso produce nuestro peso fisiológico, y cuando éste se desvia en uno ó en otro sentido, el sistema nervioso es siempre la causa, y del mismo modo que produce el reuma ó la gota, determina la obesidad ó el enflaquecimiento.

No hablo aquí, naturalmente, de los casos en que el enflaquecimiento es debido á la tuberculosis, al cáncer ó á cualquiera otra enfermedad orgánica, en cuyo caso somos impotentes; pero si los centros nerviosos nos hacen enflaquecer ó engordar con exceso, el médico puede remediar uno

ú otro inconveniente. Todas las aguas termales empleadas para llenar este objeto, todas las medicaciones son medios empíricos, todo depende del sistema nervioso mismo; él solo debe ocupar la atencion del médico, que con su concurso restablecerá la nutricion normal.

RESÚMEN

La neurosis es una enfermedad debida á la irritacion de los centros nerviosos, y que se desarrolla en los nervios, en las vísceras, en la piel, en las mucosas, en las articulaciones, que altera la sangre y la nutricion.

Sus manifestaciones son múltiples. Empieza á veces por una fiebre intermitente, periódica ó continua que dura dos ó tres septenarios. Ligada con la neurosis, la fiebre desaparece espontáneamente y reaparece en un momento inesperado, confundiéndose con la fiebre tifoidea, porque presenta los mismos fenómenos nerviosos y la continuidad. Estas dos clases de fiebre no pueden distinguirse más que por la temperatura. Tambien se confunde algunas ve-

ces con la fiebre palustre, por presentar su marcha regular.

La denominacion de fiebre gástrica, biliosa, catarral, que se le impuso cuando no se conocia la irritacion de los centros, indica solamente uno de sus caractéres principales, los fenómenos gástricos ó hepáticos que se producen al mismo tiempo que la fiebre.

La neurosis empieza con frecuencia por una afeccion cutánea, un eczema, el acné, la urticaria, una erupcion papulosa, una de esas enfermedades que han sido clasificadas sin razon en un cuadro especial, el cuadro del herpetismo; si las enfermedades cutáneas se acompañaban con reuma ó con gota, se las incluia en el grupo de lesiones artríticas. Los médicos del hospital San Luis, entre los cuales es necesario citar en primera línea á Bazin, uno de los más eminentes de la escuela, admitian dos diátesis distintas, dos principios morbosos de que dependian las numerosas enfermedades de la piel. La mayor parte de estas enfermedades, complicadas de reuma ó independientes de éste, son consecuencias de la irritacion de los centros, comienzan con ella y desaparecen cuando

el sistema nervioso ha recobrado su equilibrio.

Las flegmasías de la piel son seguidas á menudo por una flegmasía de las mucosas; el individuo que ha tenido un eczema, una urticaria, se volverá dispéptico cuando el eczema, la urticaria, etc., se curen: estas alternativas han sido denominadas metástasis; pero con frecuencia, la dispepsia se produce al mismo tiempo que la afeccion cutánea. Se ha tratado de explicar la sucesion por la continuidad de la mucosa y de la piel; la explicacion no puede ser satisfactoria sin la irritacion de los centros que determina las lesiones de nutricion de la piel, produce las flegmasías excitando los nervios cutáneos y engendra más tarde la dispepsia. A la enfermedad de la piel sucede algunas veces la bronquitis, la pleuresía, una angina, una laringitis, el falso crup, y la dispepsia no empieza hasta que la bronquitis, la pleuresía, la angina han cesado.

El desarrollo de la bronquitis, de las pleuresías, de las anginas, etc., se facilita por la irritacion de los centros. Numerosos enfermos me han dicho que se acatarraban con la mayor facilidad desde que

comenzaron los síntomas nerviosos y que anteriormente no se resfriaban nunca; la menor impresion de frío, la menor fatiga eran suficientes para hacerlos contraer una de estas enfermedades; el sistema nervioso irritado los ha predispuesto á estas diferentes afecciones. Cada una de estas enfermedades de las mucosas, de la faringe, de la laringe, de los bronquios, la angina, la laringitis, la bronquitis, incluso la inflamacion de la serosa, la pleuresía, pueden ser el primer signo de la irritacion de los centros nerviosos, la primera enfermedad que engendra; las enfermedades de la piel, la fiebre pueden no venir hasta más tarde; el asma es bastante comun, aun en los niños, cuando el sistema nervioso está perturbado.

La nosología ha separado todas estas enfermedades, ha clasificado las fiebres, las flegmasías de la piel, de las mucosas, distinguiéndolas como otras tantas entidades patológicas diferentes. Sin embargo, todas se relacionan entre sí. ¿Qué importa que se trate de un acceso de asma ó de una flegmasía de la piel ó de los bronquios, que se trate de una pleuresia ó de una angina si tienen una misma pato-

genia, un comun orígen? Se distinguen evidentemente por el tratamiento local que debe serles aplicado, pero el médico no debe olvidar en la terapéutica general los centros nerviosos. Poco importa que haya fiebre, flegmasía ó una afeccion como el asma, todas tienen, bajo el punto de vista clínico, el mismo valor, y son la expresion, con localizaciones diferentes, de una misma causa.

Las epistaxis frecuentes, las hemorragias uterinas, el púrpura mismo, que he encontrado dos veces, pueden ser los primeros síntomas de la irritacion de los centros; lo mismo sucede con el coriza, el tialismo, la gastrorrea, la poliuria, las pérdidas espermáticas, el flujo leucorreico. Derivando todas estas afecciones del sistema nervioso irritado, no tienen significacion por ellas mismas, pero la adquieren cuando se entrevé la causa, la irritacion de los centros. Entidades patológicas múltiples, trozos de la patología nerviosa de que se ignora el orígen y la naturaleza, estas afecciones representan cierto número de hechos morbosos pertenecientes á los centros enfermos; agrupados por la nosología actual en el capítulo de hemorra-

gias y flujos, no pueden ser combatidos por el terapeuta sin contar con los centros irritados.

La anemia, la clorosis, la flebitis, son igualmente consecuencias de la irritacion de los centros.

La nutricion está bajo la influencia directa de los centros nerviosos. Si éstos se irritan, la urea disminuye hasta descender á 3 ó 4 gramos por litro; el ácido úrico aumenta, y entonces aparecen los cólicos nefríticos; la gota deriva de la alteracion de la nutricion como el cólico nefrítico, y son enfermedades ligadas al sistema nervioso. Podria decir lo mismo del cólico hepático debido á depósitos de colesterina asociada con sales.

La diabetes y la albuminuria aparecen en cierto número de casos entre las lesiones de nutricion, pasajeras ó durables, pudiendo curar con los centros nerviosos ó continuando despues del restablecimiento de éstos.

El reuma de una articulacion ó el de todas las articulaciones puede ser el primer síntoma de la irritacion, como la fiebre ó la afeccion de la piel. Los crujidos articulares, las exóstosis, las deformacio-

nes de las pequeñas coyunturas, se refieren á las alteraciones de nutricion.

En fin, entre estas alteraciones nutritivas citaré dos de las más interesantes, la obesidad y el enflaquecimiento, debidas, como la clorosis, la gota, la diabetes, el reuma, á los centros nerviosos irritados.

Todas las neuralgias, cualquiera que sea su naturaleza, de los órganos de los sentidos, de las vísceras, de los nervios periféricos, tienen su orígen en la irritacion de los centros; lo mismo sucede con las hiperestesias, los hormigueos, el prurito, la sensacion de calor excesivo, de frío, los escalofríos; todas las crisis nerviosas, denominadas en su mayor parte y sin razon histéricas, tienen el mismo orígen. De toda la neurología, sólo tres ó cuatro neurosis, histeria, epilepsia, corea, catalepsia, cuya naturaleza es desconocida hasta hoy, quedan fuera de los fenómenos nerviosos producidos por los centros. Pero en medio de todas estas enfermedades tan variadas, tan numerosas, que han sido consideradas como extrañas unas á otras y que reconocen todas una causa única, figura siempre la dispepsia con sus síntomas múltiples, caracterizándose por el dolor, los gases,

las hinchazones, los vómitos de alimentos, las hemorragias, y significando irritacion del plexo solar y congestion patológica de la mucosa estomacal.

La mayor parte de la patología, el mayor número de nuestras enfermedades son, pues, evocadas por la irritacion de los centros nerviosos que presiden la salud y la mantienen, y cuya irritacion es causa de todas estas enfermedades. Cada uno de ellos se manifiesta por síntomas que he dado á conocer. La irritacion de uno de estos centros se comunica á los otros y produce las afecciones diversas que acabamos de estudiar. Cada centro puede producir crisis dolorosas que le son propias, y de las que no volveremos á hablar. En cuanto se muestra un síntoma indicando la irritacion de un centro, es necesario apresurarse á combatirlo, pues de lo contrario los otros centros serán rápidamente afectados.

La neurosis tiene una marcha regular, se desarrolla fatalmente si se la abandona á ella misma. Con la mayor frecuencia empieza por el cerebro, atormenta este órgano cierto tiempo y pasa luego al estómago; éste sufre á su vez, se calma y el intestino

grueso se afecta; la constipacion, la diarrea, las hemorragias, son su consecuencia; los fenómenos intestinales disminuyen á su vez, y todo el sistema nervioso acusa de nuevo su perturbacion; á la comida sigue un abatimiento general, dolores de cabeza, vértigo, fatiga, etc.: tal es, en el mayor número de casos, la marcha de la neurosis. Empieza á menudo en la mujer por los centros nerviosos abdominales, pasando luego al plexo, á la médula, al cerebro, para reproducir todos los síntomas que se observan cuando su orígen es cerebral; en algunos casos la médula es la primera afectada, y la dispepsia aparece consecutivamente; en otros los fenómenos gástricos abren la marcha, y los síntomas cerebrales y medulares forman su cortejo; su desarrollo se efectúa, pues, con la mayor uniformidad, atacando el sistema nervioso entero despues de haber empezado en uno de sus centros.

La neurosis puede traducirse aún en su principio, no ya por un síntoma de uno de los centros, sino fuera de éstos, por la clorosis, una afeccion cutánea, un acceso de falso crup, el asma, la pleuresía, la endocarditis, el reuma, la gota, la obesidad,

y en el recien nacido por el coriza, la angina faríngea, el falso crup ó los accesos de fiebre.

Así, pues, la neurosis, una en su patogenia, resume la mayor parte de la patología actual, que ha sido dividida por no haber tenido la patogenia por base de la clasificacion, revelando la unidad patológica del organismo humano correspondiendo á su unidad funcional. Muchos individuos permanecen enfermos desde la juventud hasta la muerte, y pasan por esta sucesion de padecimientos, creyéndose condenados fatalmente á la enfermedad. Nada más erróneo: la neurosis no ha sido tratada; estos dolientes han sido asistidos empíricamente, sea en las jaquecas, en los vértigos, en un reuma ó en la gota; el médico no ha hecho más que tratar los síntomas sin dirigirse á la enfermedad original, causa única de sus miserias infinitas.

La neurosis no llega á calmarse, á disminuir progresivamente, sino con gran lentitud, si ha adquirido su total desarrollo; el sistema nervioso no recupera su equilibrio, no vuelve á su silencio hasta despues de un año, poco más ó menos, con

la condicion expresa de que el médico y el enfermo establezcan una terapéutica prudente y la higiene reclamada por los centros nerviosos.

CAPITULO XVII

TERAPÉUTICA

La terapéutica actual consiste generalmente en el tratamiento de los síntomas de una enfermedad sin dirigirse á la enfermedad misma.

Cuando el individuo se queja de dolores de cabeza, de jaquecas, el médico busca un medicamento que los calme momentáneamente; si estos fenómenos se reproducen, si aparecen los vértigos, los aturdimientos, el médico teme una congestion cerebral, una apoplejía, purga al enfermo, irrita el plexo y el resultado es el aumento de estos fenómenos, síntomas de la célula cerebral irritada que no significan en manera alguna amenaza de congestion ó de apoplejía.

Cuando aparece una crisis cerebral con

pérdida completa de conocimiento durante un tiempo más ó menos largo, una hora ó dos, seguida de contractura muscular, el médico diagnostica siempre congestion ó hemorragia cerebral, sangra y purga al enfermo que sale de la crisis, pero el fenómeno se reproducirá, porque los purgativos serán administrados repetidas veces.

La sangría puede por si sola ser causa de muerte rápida. La crisis cerebral puede algunas veces producir por sí misma la muerte repentina.

La embolia ó la ruptura del corazon sirven siempre á explicar este género de muerte. Un presidente de tribunal de provincia, de treinta y nueve años, afectado de la neurosis, murió de repente. En mi hospital un jóven de treinta y dos años, neurótico, murió instantáneamente despues de haber conversado con el interno del servicio. Fácil es comprender que la sideracion cerebral que priva al individuo de conocimiento media hora ó más puede interrumpir bruscamente la vida.

Hay crisis violentas de dolor de cabeza que anonadan al enfermo, condenándolo á la inmovilidad, en que el menor ruido, la conversacion se hacen insoportables y

en que el doliente presenta el aspecto hipocrático y sufre un dolor que se irradia hácia el trigémino, hácia las ramas dentarias. Se busca entonces un diente malo, y si se encuentra, se manda el enfermo al dentista; pero los sufrimientos continúan porque el dolor proviene de la célula cerebral, porque ésta es la que provoca la crisis y no el diente; la sensibilidad de la célula se transmite hasta el diente, que no es el punto de partida: la célula cerebral excita el nervio dentario. Cuando se producen neuralgias intensas, crisis de hiperestesia seguidas de vómitos que duran un día ó más, una inyeccion subcutánea de morfina puede conjurar la crisis, que se renovará más violenta porque la morfina no cura la célula nerviosa que produce la crisis: esta sustancia atonta al enfermo y aniquila el sistema nervioso perturbado.

Si del sistema nervioso pasamos al tubo digestivo, observamos la misma terapéutica sintomática. El apetito es nulo, la lengua blanca, á la comida sigue el malestar; el diagnóstico, catarro gástrico, palabras vacías de sentido, se pronuncia y se prescribe un purgante que irrita el plexo, causa de todos los fenómenos del tubo di-

gestivo, cuando el médico cuenta con el purgante para curarlos. Otras veces, en lugar de un purgativo se administra un vomitivo, más nocivo aún á los centros nerviosos. Al purgativo sucederá la pepsina, la papaína, los elixires digestivos, los amargos; el estómago no podrá soportar estos medicamentos, y la funcion del plexo será completamente turbada provocando la irritacion de los otros centros: una afeccion pasajera será el punto de partida de desórdenes profundos en todo el sistema nervioso.

Cuando la piel presenta erupciones diversas, exantemas, pápulas, vesículas, pústulas, no se trata ya de medicina de síntomas; entonces Bazin y su escuela hacen intervenir la diátesis, la disposicion morbosa artrítica y herpética, que creian atacar con dos especies de medicamentos: el artritismo con los alcalinos, el herpetismo con los arsenicales; ahora bien, ambas medicaciones quedan sin efecto: la afeccion cutánea creada por los centros nerviosos no se cura con medicamentos.

Las afecciones de la garganta, de la laringe, las palpitaciones, no desaparecen hasta que los centros nerviosos se calman.

¿Qué hará el medicamento en el mayor número de casos? Lo que puede hacer el medicamento del síntoma: procurará un alivio momentáneo y el síntoma reaparecerá. La digital, empleada en las palpitaciones, sirve sólo con frecuencia para aumentarlas, porque este medicamento irrita el plexo solar.

Todas las afecciones de los bronquios, bronquitis aguda ó crónica, durarán más tiempo si se prescriben medicamentos que, como el kermes, no pueden ser tolerados por el estómago; el óxido blanco de antimonio sólo puede soportarse.

El salicilato de sosa calma ó no el dolor del reuma, pero no se dirige á la causa de la enfermedad; lo mismo sucede con los medicamentos de la gota, el cólchico por ejemplo.

El tratamiento de la obesidad que consiste en purgativos, baños de vapor, aguas termales, debilitan al enfermo y lo fatigan; enflaquece, pero su enfermedad se agrava; sus centros nerviosos se debilitan cada vez más y el individuo que quiere enflaquecer por medio de medicamentos ó reduciendo su alimentacion se expone con frecuencia á la muerte, como se ha obser-

vado á menudo en personas obesas que querian enflaquecer siguiendo las inspiraciones de un comerciante en caballos ingleses, Benting. La obesidad es una enfermedad que es necesario en primer lugar no complicar con otra enfermedad.

Esta rápida revista de las enfermedades y de su tratamiento, tal como se comprende hoy, permitirá al lector darse cuenta de los errores de la terapéutica que han venido á añadirse forzosamente á los de la patología. El medicamento no tiene valor sino cuando se dirige á la patogenia y no al síntoma, cuando es aconsejado por una patología verdadera, cuando ataca la causa de la enfermedad.

I

HIGIENE DE LOS CENTROS NERVIOSOS

La neurosis empieza en el niño y aumenta con todos los errores de higiene que se cometen á propósito de su educacion física é intelectual, de su alimentacion; al médico incumbe reconocer inmediatamente sus primeras manifestaciones, reglamentar los ejercicios físicos y el régimen alimenticio, y fijar el número de horas de trabajo intelectual apropiadas al estado del sistema nervioso.

Padres que sufren de los centros nerviosos, engendran niños nerviosos; el neurosismo puede ser detenido en su marcha. Si la existencia del niño no se regula bajo todos los puntos de vista, la neurosis se desarrollará y aquél pasará penosamente los primeros años, y como tiende á aumen-

tar sin cesar, volverá al niño incapaz de trabajar debilitándolo física y moralmente.

Sea cualquiera el período de la vida en que se desarrolla la neurosis, los mismos principios generales guiarán al médico, que puede dominarla en toda edad.

Debo insistir sobre las cuestiones relativas á la higiene que exige cada uno de los centros, cerebro, médula, plexo solar, puesto que la irritacion no se circunscribe nunca á un solo centro, sino que se propaga inmediatamente á los otros: la higiene y el tratamiento de los tres centros deben prescribirse simultáneamente.

Por el cerebro se hace la educacion intelectual y moral, y por él se ejecutan los trabajos del espíritu; á la médula pertenece poner en accion los músculos, presidir el movimiento; el plexo solar determina la funcion del órgano destinado á recibir los alimentos que deben reparar las pérdidas diarias de la economía y mantener el libre funcionamiento de las vísceras, así como la temperatura del cuerpo necesaria á la vida.

Cada uno de estos centros nerviosos obra sobre los otros centros, de suerte que el funcionamiento de cada uno es necesa-

rio al buen funcionamiento de todos y que la enfermedad del uno repercute en los otros, lo cual quiere decir que la educacion intelectual y moral debe ser adecuada al cerebro y que si ésta es mala perturba la médula y el plexo; que la cantidad de ejercicio físico debe conformarse á la tolerancia de la médula, y que si el ejercicio es excesivo, la educacion intelectual y moral, la digestion sufren; que el alimento, en fin, debe ser apropiado al plexo, y si no lo es, si se administra sin medida, sin conocimiento exacto de sus exigencias, éste se irrita y el individuo sufre en el cerebro y en la médula. Así, pues, todo está subordinado en el organismo; nada es indiferente, ni en la dosis de trabajo intelectual, ni en el desarrollo de las pasiones, ni en los ejercicios corporales, ni en los movimientos, ni en el régimen alimenticio; todo debe ser medido segun la susceptibilidad del sistema nervioso, que nos limita siempre y nos impone reglas severas, ó de lo contrario la enfermedad aparece rápidamente.

El adulto es dueño de su persona y debe conocer, es preciso que conozca, la higiene que le conviene y que se conforme á ella;

pero es necesario hacer la educacion del niño, educacion que permita dar á su organismo toda la energía intelectual y física de que es capaz: todo individuo posee, al nacer, en estado embrionario, una suma de fuerzas físicas y mentales que no se desarrollan si la educacion es mal comprendida, pero que se desenvuelven armoniosamente cuando ésta es dirigida racionalmente: es indispensable que este desarrollo se haga simultáneamente; si las fuerzas físicas son especialmente favorecidas, las intelectuales se resienten y recíprocamente; es, pues, necesario no separar la educacion física de la intelectual, que no deben realmente constituir más que una sola. El organismo humano vive y se conserva por tres órdenes de funciones: funciones de relacion, de nutricion, de reproduccion; estos tres grupos funcionales hacen del hombre lo que es, un sér creado para pensar, obrar y reproducirse: dos de estas funciones tienen por condicion la nutricion; de ésta dependen las dos precedentes, y aquéllas tienen á su vez gran influencia sobre la funcion de nutricion: la nutricion se altera tan pronto como se alteran las funciones de relacion y de

reproduccion, como lo hemos demostrado.

La salud no puede conservarse sino siguiendo, para con todas las funciones, las prescripciones que nos imponen los centros nerviosos. Voy á mostrar de qué modo es necesario comprender la alimentacion bajo el punto de vista humano, como los ejercicios corporales, la educacion intelectual y moral; mostraré igualmente el tratamiento aplicable á la neurosis cuando el sistema nervioso está profundamente alterado.

Empezaré por indicar qué es el alimento bajo el punto de vista del organismo y cómo obra sobre el plexo solar.

II

ALIMENTO

El alimento es la materia nutritiva que sirve á constituir los tejidos del organismo; á cada instante de la vida los principios nutritivos que han formado el músculo, el cerebro, el hueso, el nervio que han sido asimilados, se separan despues de haber sido transformados en ácido carbónico, urea, agua y son expulsados del organismo; gracias á estas transformaciones, las vísceras funcionan, la temperatura del cuerpo se mantiene á 37°, el corazon late regularmente, los movimientos respiratorios se ejecutan, el hombre puede pensar, reflexionar y contraer sus músculos. En este medio, compuesto y conservado por el alimento, el individuo puede desplegar su actividad intelectual y moral, puede di-

rigirse libremente: la nutricion es un
vimiento continuo de entrada y salide
alimento y exige una importacion cot
na; el alimento no debe faltar nunca, cu
quiera que sea la enfermedad del indivi-
duo; la dieta absoluta es un atentado con-
tra la vida; en el estado de enfermedad
debe darse leche, sopas, materias nutriti-
vas que no excitan el estómago ni exigen
te órgano. Esta ali-
ıa los elementos que
la eliminacion nor-
do carbónico se hace
modo casi uniforme;
cantidad de alimen-
rea y de ácido carbó-
ıta tambien y la nu-
ontamente; una im-
la es suficiente para
sica tiene la misma
ɔs descrito anterior-
ides que resultan de
ıtricion. Todo lo di-
instable es el equi-
y á qué precauciones
ıbre para conservar

La composicion de los tejidos del orga-

nismo y la de los alimentos son poco más ó menos idénticas; el cuerpo humano está formado de 70 por 100 de agua combinada con los diversos principios de los tejidos, que se componen á su vez de materias azoadas, de materias no azoadas, azúcares, grasas y sales minerales.

El alimento extraido de los reinos animal y vegetal está formado por materias azoadas, albúmina, oseina, y de sustancias no azoadas, azúcar, almidon, grasa y sales minerales. La sustancia del cuerpo y la sustancia del alimento son, pues, idénticas. La digestion no tiene otro objeto más que hacer solubles la albúmina y la grasa y convertir las féculas, el almidon, en azúcar.

Si el cuerpo está constituido por agua en su mayor parte, por materias azoadas, azúcares, grasas y sales minerales, toda sustancia que contenga uno ó muchos de estos principios será un alimento.

Pasemos rápidamente en revista las diversas especies de alimentos: 1.°, los del reino animal; 2.°, los del reino vegetal.

Alimentos de origen animal.—Tienen gran analogía bajo el punto de vista de su composicion química; la vaca encierra en 100

partes de fibra muscular: agua, 74; albúmina y fibrina, 26; gelatina, 6; 2,8 de grasa, y 1,6 de sales; la ternera contiene: 75 de agua, 10 de albúmina y fibrina; el carnero encierra: agua, 71; albúmina y fibrina, 22; el puerco contiene: 76 de agua, 16 de albúmina y fibrina, y además presenta 5,7 de grasa; el pollo tiene: 73 de agua, 20 de albúmina y fibrina; el caracol contiene: agua, 76; 16 de albúmina y fibrina; todas las carnes, desde la del buey hasta la del caracol, se parecen, pues, singularmente y presentan con muy pocas diferencias una riqueza alimenticia casi equivalente; la carne de cerdo se distingue de las otras por la gran cantidad de grasa que contiene.

El pescado tiene una carne semejante á la de los animales de que acabamos de hablar.

El lenguado presenta 68 por 100 de agua, 7 de materias azoadas, 1,7 de grasa y 1,8 de sales; la composicion química de la pescadilla es casi equivalente á la del lenguado; el salmon difiere de los dos precedentes por la gran cantidad de grasa, conteniendo 80 por 100 de agua, el doble de materias azoadas que los precedentes y 4,7 de grasa.

Todos estos alimentos contienen, como los órganos, agua, materias azoadas, grasa y sales minerales.

Lo mismo sucede con la leche, el huevo y el queso.

La leche de vaca tiene por 100: agua, 87; materias azoadas, 3,6; manteca, 9; azúcar y sales.

El huevo contiene por 100: agua, 75; sustancias azoadas, 15; grasa, 10, y sales fosfáticas, magnésicas, cal, hierro, sílice 8.

En fin, el queso *(brie)* está compuesto por 100 partes de: agua, 53, materias azoadas, 15,5; grasa, 24,8; materias minerales, 5,6. El *gruyère*, el *roquefort*, etc., tienen una composicion química semejante á la del *brie*.

En resúmen, carne ó queso, pescado ó leche, contienen la cantidad de agua que encontramos en el cuerpo humano, las materias azoadas, las ternarias, todas las sales necesarias al organismo.

El alimento vegetal es más rico que el tomado del reino animal, puesto que además de las sustancias azoadas contiene el almidon, que se convertirá en azúcar por la digestion.

Hé aquí la composicion química de diferentes vegetales:

Vegetales.	Agua.	Materias azoadas	Almidon, dextrina, glicosa.	Grasa.	Sales minerales.
Judías....	12	25	48	1,9	3
Lentejas..	9	25	58	»	2
Trigo.....	14	11	78	1,8	1,4
Centeno..	16	9	67	2	2
Arroz	14	6	77	»	2

Los vegetales contienen, pues, los mismos principios que los tejidos del cuerpo, encierran los mismos elementos, son más ricos que la carne en principios azoados y tienen almidon que no existe en la carne.

Así, una lenteja, una judía, un grano de trigo, valen más que la fibra muscular bajo el punto de vista del objeto final, la nutricion, é importan al organismo mayor cantidad de materiales útiles.

Si se fuera á clasificar los alimentos en cuanto á la riqueza alimenticia, el huevo, la leche, la lenteja, la judía, el trigo merecerian el primer lugar; la carne, que contiene sustancias azoadas, poca grasa

y ningun almidon, viene despues. Los primeros poseen todas las variedades de sustancias de que la economía tiene necesidad; el almidon, el azúcar, le son particularmente necesarios para producir la temperatura, y cuando estas sustancias faltan el organismo emplea las azoadas; el almidon y el azúcar parecen ser consumidos constantemente; una vez en el organismo desaparecen, y son quemados siempre.

Pero ¿debe tomarse sólo en consideracion la composicion química del alimento; debe el médico tener sólo presente la cantidad de principios azoados, grasos, de fécula, de sales minerales que cada alimento contiene; debe apreciarse únicamente el alimento bajo el punto de vista químico?

Hasta que emprendí mis investigaciones sobre el estómago, se profesaba que el enfermo podia nutrirse de lo que quisiera, de lo que le sugiriese su apetito, su instinto; ahora bien, la sensacion del apetito es de lo más singular que existe. Esta sensacion falta enteramente á ciertas personas durante toda la vida, ¿y deben no comer por eso? En otros casos, el apetito es caprichoso y conduce á ciertas personas á usar

de los manjares más excéntricos ó nocivos; ¿deben éstas prestar oído á las sugestiones de su apetito, siempre falseado por el neurosismo? Fácil es, pues, comprender que no podemos dejarnos guiar por el apetito, por nuestras impresiones. ¿Es indiferente alimentarse de un modo cualquiera, y basta sólo con tener presente las eliminaciones diarias del organismo, los 20 gramos de ázoe y 300 gramos de carbono perdidos cada día, reemplazándolos por un alimento cualquiera del reino animal ó vegetal que importe todos los días el equivalente de lo que ha sido empleado; en una palabra, puede el hombre á su capricho alimentarse de carne, de vegetales, con tal que recupere su ázoe y su carbono? Un médico químico responderia que sí; la clínica me ha demostrado que no. El hombre no puede, sin comprometer su individuo, nutrirse como quiere, y debe someterse á ciertas obligaciones que le imponen su centro nervioso, el plexo solar y los otros centros; el individuo no puede vivir exclusivamente de carne ó de vegetales, de grasas, de líquidos, tales como el vino, la leche; todas estas sustancias pueden, en cierta cantidad, ser suficientes químicamente

hablando; pero como pasan antes de llegar á la circulacion por el estómago, en el que se encuentran en presencia de su centro nervioso, cada una de ellas lo influye á su modo, y esta influencia puede hacer nocivo tal alimento á pesar de sus buenas condiciones bajo el punto de vista químico.

Es necesario, pues, considerar en el alimento su accion sobre el plexo solar al mismo tiempo que su valor químico; el primer punto no ha sido tratado nunca, porque no se ha estudiado. De él partirán todas las reglas del régimen alimenticio. Los principios de los alimentos están diseminados con profusion en los dos reinos animal y vegetal, á la disposicion del hombre, pero éste no tiene la libertad de tomarlos al acaso; puede nutrirse muy sencillamente, de pan y queso, de leche y vegetales ó de carne; pero es necesario conocer la accion de las diversas especies de alimentos sobre el sistema nervioso, para establecer un régimen que convenga á la química del organismo y á las exigencias de los centros nerviosos.

1.° *Accion de la carne sobre el plexo solar.*—La carne tiene una accion fisiológica

que le es exclusiva sobre el plexo solar; le excita más fuertemente que todas las otras especies de alimentos, y esta excitacion es inmediatamente trasmitida al cerebro. William Edwards ha establecido, por medio del dinamómetro, que despues de una comida de carne la fuerza muscular aumenta inmediatamente, y no hay que pensar que el aumento de fuerza resulte del valor de la sustancia nutritiva, puesto que si se administra un alimento más rico bajo el punto de vista químico, judías ó lentejas, el fenómeno no se produce. La fibra muscular de la carne, excitando el plexo, excita la célula cerebral que obra sobre los nervios motores, y la contraccion muscular es más poderosa: despues de una comida de carne, el vigor intelectual y muscular es mayor, el individuo está en condiciones de emprender largas marchas, trabajos manuales más fatigosos; cuando se alimenta de alubias ó de un vegetal cualquiera, está en realidad mejor nutrido, pero el cerebro es menos estimulado y la actividad es menor. Por este motivo muchas personas no se consideran alimentadas sino cuando han comido carne, y creen que los vegetales

son insuficientes. Estas personas están habituadas al estímulo que da la carne y que les falta cuando comen sólo pan y queso, y confunden la nutricion con la excitacion de los centros nerviosos.

Todas las carnes no tienen en igual grado la propiedad de excitar los centros: la carne de vaca la tiene en grado máximo, y la menos excitante es la carne de pescado (lenguado, pescadilla); entre estos extremos deben colocarse la ternera y el carnero; con frecuencia enfermos que tienen el cerebro sensible, impresionable, me han dicho que la ingestion de carne de vaca era seguida de dolor de cabeza, y que la de carnero no tenia en ellos accion alguna sobre el cerebro.

¿Por qué la fibra muscular de la vaca es más irritante para el plexo y el cerebro que la fibra del carnero, del pescado y del pollo? No lo sé, y la química no nos lo enseña. Es necesario guardarse del abuso de la carne de vaca en las personas afectadas de la neurosis: la influencia de esta carne es temible. Observo diariamente la accion de la carne, influencia directa, y es necesario tenerla en cuenta en el régimen de los niños y de los nerviosos: el

abuso de la carne puede traer consigo el desarrollo de la neurosis.

Y que no se crea que en la carne se debe sólo considerar la fibra muscular, sino que hay que contar tambien con la grasa que contiene. Así, la carne de puerco irrita el plexo por su gran cantidad de grasa ; por igual motivo la carne de salmon es más irritante que la del lenguado.

La disposicion de las fibras musculares, su densidad, su grado de cohesion, tienen igualmente importancia ; la carne de la langosta, del cangrejo, irritará el plexo más que la del carnero.

En resúmen, la fibra muscular irrita el plexo; la grasa de la carne lo irrita tambien, y la densidad, la cohesion de las fibras puede ser causa de irritacion.

2.° *Accion de los vegetales, de la leche, del huevo sobre el plexo.*—Los vegetales, la leche, el huevo, tienen un efecto inverso al de la carne sobre el centro nervioso del estómago, no alterando su calma, no excitándolo; y para clasificarlos bajo el punto de vista de su accion sobre el plexo, colocaríamos la leche en primera línea, el huevo despues y por último los vegetales.

Me refiero á los vegetales, lentejas, judías, guisantes, etc., machacados, cuando la película celulosa que los recubre, y que es nociva al estómago, ha sido triturada.

Los alimentos deben dividirse en dos categorías, unos que encierran todos los principios de que tiene necesidad el organismo: leche, huevos, lentejas, judías, etc.; otros, compuestos por la fibra muscular, que encierran los principios azoados; uno y otro grupo se distinguen completamente por la influencia que ejercen sobre los centros nerviosos.

El uso exclusivo de la carne determina prontamente la neurosis por la irritacion repetida del plexo solar, y todas las enfermedades que derivan de la neurosis, la litiasis, la gota, el reuma, la obesidad, el enflaquecimiento, etc. El uso exclusivo de la leche no da un estímulo suficiente al plexo solar, que se irrita lo mismo por exceso que por falta de estímulo, de modo que la leche, administrada sola y durante mucho tiempo, producirá la dispepsia ó la hará persistir si ya existe.

En resúmen, el régimen animal, el régimen lácteo y aun el régimen vegetal exclusivos son nocivos, atormentan el es-

tómago y por consiguiente todo el sistema nervioso.

Estudiemos con estos datos fisiológicos, deducidos de la clínica, el tratamiento que debe aplicarse á la neurosis en los diversos casos, cuando se trata del cerebro profundamente afectado, del estómago enfermo en particular ó, en fin, cuando todos los centros y las diversas vísceras están atacados. Ante todo, presentaré al lector un tipo de este último género.

Un sacerdote, de treinta y cinco años, viene á consultarme por la primera vez hace muchos meses, y me hace la historia siguiente de su padecimiento:

Sufre desde la edad de cinco años, época en que tuvo una fiebre tifoidea; en los años siguientes volvió á tener dos fiebres tifoideas (ya he dicho que la neurosis se confunde á menudo con esta fiebre, y esto es lo que me parece haber sucedido con nuestro enfermo). Hace doce años que se le trata como anémico; de diez y seis á veinticuatro años estudia derecho; á los veinticinco se hace religioso y entra en un convento; todas las mañanas se levanta á las cuatro, ayuna á menudo, consagra todo

su tiempo á la oracion y al trabajo; al terminar el noviciado ha perdido el apetito y el sueño: la neurosis, que empezó á la edad de cinco años, ha aumentado con la mala higiene; la excitacion religiosa, los estudios de colegio, del derecho la han llevado á su completo desarrollo; seis años despues de su entrada en el convento, las facultades intelectuales y morales están deprimidas, la vista debilitada, no tiene atencion ni memoria, está triste, no puede seguir una conversacion ni hacer sus oraciones; el estómago está dilatado de un modo enorme; el enfermo no tiene fuerzas para andar ni para llevar á cabo ningun trabajo físico.

El médico del convento no ve en este estado de depresion moral y física otra cosa más que la anemia: he hablado de la anemia, y he mostrado que es una consecuencia de la irritacion de los centros y no una causa. Desde hace cincuenta años, desde Broussais, por razon de anemia, se impone á los enfermos un régimen que les quita la poca salud que les queda.

El régimen que se le prescribe para curarlo es el siguiente: la carne cruda le es administrada muchas veces por día, toma

además diez huevos, dos tazas de arroz, pan, agua de Bussang, etc.

Si la alimentacion debe restablecer, curar á un enfermo, no se puede decir que le haya faltado; sin embargo, al cabo de algunas semanas de este tratamiento el sistema nervioso habia llegado al paroxismo del desórden; las jaquecas habian aumentado y aparecian todas las semanas, los cólicos con expulsion de mucosidades eran diarios; el enfermo estaba completamente anonadado y enflaqueció, á pesar de esta alimentacion exuberante, 20 libras.

Es imposible demostrar mejor, incluso con un experimento de fisiología, el efecto de la alimentacion sobre el sistema nervioso de este enfermo; á pesar de la carne cruda, de los diez huevos, del arroz, del agua ferruginosa, el paciente pierde de su peso. No se engorda, pues, porque se introduce alimentos en el estómago; los alimentos son inútiles, en efecto, cuando el sistema nervioso no consiente en servirse de ellos, y la alimentacion hace enflaquecer. Ya lo he demostrado en uno de los capítulos precedentes.

Cuando este desgraciado abate habia sido completamente aniquilado por el ex-

ceso de alimento se le prescribió el lavado del estómago, que hecho fuera de tiempo y repetido á menudo tiene la misma influencia que la alimentacion excesiva y arruina el sistema nervioso. Más tarde hablaremos del lavado del estómago. Nuestro enfermo lo practicó treinta días consecutivos, y su estado de debilidad habia llegado al colmo. Despues de algunos días de reposo se puso en camino para París, con el objeto de consultarme.

Prescribí á este enfermo el reposo del cuerpo y del espíritu; compuse su régimen alimenticio sin carne, y no le permití el uso de ésta hasta algunas semanas despues, dos ó tres veces, y le ordené 1 gramo de bromuro de sodio: cada día el cerebro se calmaba, el sueño reapareció y el enfermo engordó 8 libras en el espacio de algunas semanas; su estado se mejoró. Su neurosis curará ciertamente por el tratamiento, despues de haber durado treinta años, y este individuo podrá ejercer su ministerio, pero uno ó dos años serán necesarios para obtener este resultado. Su médico, que lo alimentaba con exceso, no hacia más que aumentar el mal. Esto sucede todos los días con la neurosis, que es tan

comun en todas las clases de la sociedad. El temor de la anemia atormenta el espíritu de los médicos, y les hace cometer tantos errores terapéuticos como la inflamacion hizo cometer á Broussais.

No sólo el exceso de carne habia irritado el plexo solar, sino además el agua de Bussang, el vino que se le prescribia con el objeto de darle fuerzas, el pan, los diez huevos que tomaba al dia; todas estas sustancias constituian una alimentacion más que suficiente para su conservacion. La cantidad de huevos no tiene ninguna importancia y nunca es nociva: algunos de mis enfermos añaden á la racion de carne permitida hasta doce huevos por día en la alimentacion ordinaria, sin inconveniente alguno; otros toman un litro de leche, además de los alimentos, en cada comida y el estómago lo soporta; pero este órgano no tolera ni la carne, ni las grasas, ni los aceites, ni el vino, ni ninguna otra bebida fermentada, ni la manteca, cuando el plexo está fuertemente irritado.

Cuando el sistema nervioso está perturbado, el enfermo se queja de debilidad, de dificultad para andar, para trabajar; esta debilidad real no proviene de la ali-

mentacion insuficiente, puesto que si el enfermo aumenta su alimentacion, como sucedió al sacerdote de que hablamos, la debilidad aumenta tambien: la debilidad proviene de los desórdenes nerviosos; no podemos sentirnos fuertes sino cuando los centros nerviosos están en reposo; ellos son los que nos comunican la sensacion de fuerza, y el equilibrio del sistema nervioso no se restablece con un régimen formulado al acaso sin conocimiento exacto de las exigencias del plexo solar y de los otros centros.

He hecho ver por experimentos en el perro, detallados en uno de los capítulos precedentes, la accion de las bebidas, de las aguas minerales, de los medicamentos sobre el plexo solar, la susceptibilidad de éste y hasta qué punto es impresionado por los medicamentos y las bebidas fermentadas; su sensibilidad es tal, que llega con la mayor facilidad á la irritacion. Una vez establecida, el estómago no tolera la carne todos los días, y no puede en absoluto soportarla cuando la irritacion es muy considerable; ocho ó quince días son necesarios en ciertos casos, antes que el médico pueda permitirse prescribir la carne; luego, cuando la tranquilidad haya sido ob-

tenida, la carne será administrada una ó dos veces por semana, teniendo cuidado de alimentar en cantidad suficiente con sustancias que pasan desapercibidas para el plexo solar; la cantidad de litro y medio de leche y tres ó cuatro huevos realizan las exigencias de la economía.

Tan pronto como el centro nervioso se calma, los fenómenos del estómago disminuyen; los dolores, la hinchazon, los gases, las náuseas, los vómitos, todos los síntomas abdominales se atenúan; los cólicos intestinales, la constipacion ó la diarrea, ceden poco á poco; el volúmen del hígado congestionado disminuye; los cólicos hepáticos, nefríticos, los espasmos de la vejiga, el catarro vesical, la leucorrea, la espermatorrea, desaparecen sucesivamente. Lo mismo sucede con los síntomas de las vísceras torácicas: la angina faríngea, los accesos de tos, los de asma, los de angina de pecho, las palpitaciones, pierden su intensidad y finalmente se curan.

El médico puede aliviar con algunos medicamentos no dañinos al estómago (el bromuro de sodio en la dosis de 40, 50 centígramos ó 1 gramo, la valeriana, la quinina en la dosis de 20 ó 30 centigra-

mos), los padecimientos de las diversas vísceras, porque estos medicamentos contribuyen á calmar el sistema nervioso; pero toda medicacion que se dirige al órgano directamente es infructuosa. No hay medicamentos para curar la constipacion ó la diarrea, todos son nocivos; ninguno puede disminuir la congestion hepática, destruir los cálculos del hígado ó del riñon, hacer cesar el espasmo de la vejiga, su catarro, la espermatorrea, la leucorrea. Al plexo solar debe aplicarse el tratamiento para que el enfermo cure de estas diversas enfermedades. Lo mismo diré á propósito de la angina faríngea, de los accesos de tos, del asma, de las palpitaciones. La medicacion directa es empírica é infructuosa; por este motivo cada día se preconizan medicamentos nuevos, cuyo efecto, se dice, es maravilloso, pero que no duran, y los terapeutas tienen por costumbre decir: "Haced uso del medicamento mientras obra„, y, en efecto, las ilusiones á propósito de sustancias medicamentosas se pierden pronto; los remedios nuevos serán rápidamente olvidados é irán á reunirse con millares de medicamentos inútiles ó nocivos que han visto la luz du-

rante algunas semanas ó algunos meses solamente. ¿Qué poder tiene el medicamento para restablecer el mecanismo nervioso? Éste no se reconstituye con una sustancia; se puede disminuir momentáneamente el dolor con un medicamento del sistema nervioso, pero aquél es uno de los mil fenómenos que éste produce, y sigue funcionando imperfectamente despues de haber sido aliviado por el medicamento. En cuanto el plexo se calma, el dolor de cabeza, el vértigo, se moderan y se atenúan paralelamente; los zumbidos de oídos disminuyen, la vista se recobra, las crisis con pérdida de conocimiento ó las crisis nerviosas con angustias, temblores, contracturas, disnea, desaparecen; lo mismo sucede con la hiperestesia de la piel, de los músculos, de las articulaciones. Todas estas complicaciones nerviosas que tienen su orígen en la irritacion del plexo son mantenidas por él y con él se curan.

¡Cuántos medicamentos han sido imaginados para curar la jaqueca y el dolor de cabeza, y el jaquecoso, el vertiginoso, han continuado teniendo jaqueca y vértigo á pesar de todos los remedios! El médico aurista examina el fondo del oído con

la lámpara, sonda la trompa de Eustaquio buscando la causa del zumbido de oídos y de la sordera, tan frecuente en el dispéptico, y no encuentra nada; todos sus esfuerzos para curar directamente el oído por medios mecánicos ó con remedios quedan sin efecto.

Cuando el individuo tiene crisis nerviosas con contractura, temblor, angustia, disnea, seguidas ó no de pérdida del conocimiento, el médico lo clasifica entre los histéricos, lo cual es un error grave. No conocemos la patogenia de la histeria, afeccion muy poco frecuente, y estas crisis nerviosas, provocadas por el plexo solar, son muy comunes y enteramente distintas de la histeria y de la epilepsia, aunque desgraciadamente para el enfermo se las confunde siempre con una ú otra de estas afecciones.

¿Cuál es la medicacion en boga contra las crisis del sistema nervioso? La hidroterapia, imaginada por un empírico ruso y adoptada por la terapéutica. La piel, las articulaciones, los músculos del cuerpo, dolorosos, son percutidos durante un tiempo más ó menos largo por el agua fría á 9 grados, con el objeto de dar fuerzas; el

agua, mal tolerada, da escalofríos al enfermo, y proporciona á algunos la sensacion de fuerza momentáneamente, pero que desaparece en breve; ni la percusion, ni la temperatura del agua, pueden ser toleradas; si se emplea un agua de temperatura más elevada, la percusion sola es suficiente para aumentar la perturbacion del sistema nervioso. La mayor parte de los enfermos que vienen á consultarme han empleado la hidroterapia durante muchos meses; muchos de entre ellos, y podria decir el mayor número, han visto su estado agravarse con este tratamiento; la hidroterapia, practicada con el agua á 9 grados, es nociva al nervioso y le procura sólo un estímulo momentáneo, al que sucede en breve la debilidad. Esta medicacion no puede dar buenos resultados sino con la condicion de que el agua esté á una temperatura bastante elevada en relacion con el estado del sistema nervioso, y de que se aplique durante algunos segundos solamente y cuando los centros nerviosos han recuperado algun vigor. A un sistema nervioso profundamente turbado sólo le conviene el agua caliente, y muy caliente, á 45 ó 50 grados. He suprimido en mi

hospital las duchas frías, y las he reemplazado por duchas de agua caliente, que los enfermos desean, mientras que tienen horror del agua fría, que conviene sólo á un sistema nervioso bien equilibrado y vigoroso. En este último caso, la hidroterapia fría es útil y puede emplearse.

Sucede con los baños prolongados lo que con la hidroterapia ; un baño prolongado, de una ó dos horas, aniquila el sistema nervioso ; un baño corto, de cinco, diez minutos, á una temperatura de 36 ó 37 grados , sea cualquiera su composicion, me ha parecido siempre calmar el sistema nervioso y serle útil; pero cuando los centros nerviosos están violentamente irritados , el baño , incluso en extremo corto, no tiene indicacion alguna y es nocivo: hay enfermos que experimentan angustias en el baño ó tienen una crisis. En las estaciones termales, los enfermos tienen por costumbre prolongar el baño, sumergirse horas enteras en el agua sin malestar ; beben el agua termal , comen con exceso, frecuentan los teatros, los juegos, hacen excursiones, y este mismo enfermo, que en su casa no puede ni comer ni andar, tiene apetito, se nutre, se pasea desde

que llega al nuevo medio. Es, por decirlo así, una resurreccion súbita; todas sus miserias han desaparecido: antes de empezar el tratamiento, se siente aliviado, es feliz; su estómago hace proezas, á las que no estaba acostumbrado; la constipacion ó la diarrea han cedido como por obra de encantamiento, y el enfermo, llevado de sus ilusiones, comete toda especie de errores de régimen: anda demasiado, come con exceso, bebe demasiada agua y toma baños demasiado largos. Todas sus miserias reaparecen dobles, triples, desde su vuelta al domicilio; y el paciente maldice las aguas que lo habian hecho tan feliz, y forma el designio de hacer uso á la estacion siguiente de otras que un amigo le ha recomendado. El enfermo recorre así todos los establecimientos balnearios sin llegar á restablecerse.

Los errores que comete en su primera cura son debidos á que, siendo su enfermedad de orígen nervioso, y siendo todos los síntomas la expresion de los sufrimientos del sistema nervioso, el mal desaparece tan pronto como el enfermo se encuentra en otro medio atmosférico: no tiene ningun malestar ni dolor alguno desde que

ha salido del medio en que sus centros nerviosos estaban aclimatados; el nervioso resiente las variaciones barométricas, sufre de ellas y con frecuencia se siente aliviado al cambiar de clima y encontrarse bajo otro cielo; su sistema nervioso no deja, sin embargo, de estar enfermo, pero no acusa sensacion alguna. Si hubiera proporcionado la duracion de los baños á su sistema nervioso, si se hubiese alimentado como lo exigia su plexo, si hubiera andado segun la sensibilidad de su médula, habria obtenido excelentes resultados de su estancia en los baños, que, por el contrario, le ha sido perjudicial por razones múltiples que es incapaz de apreciar.

La hidroterapia y los baños muy prolongados, aconsejados en las crisis nerviosas, no convienen cuando el sistema nervioso está enfermo. Hay otras medicaciones empleadas contra los accesos de neuralgia intensa, los accesos de hiperestesia, motivados por los centros nerviosos irritados: los grandes vejigatorios por ejemplo, los masajes, etc.

Los vejigatorios de 10 y 15 centímetros no hacen en general más que agravar las

neuralgias y las hiperestesias; los vejigatorios de 4 y 5 centímetros, de pequeña dimension, son sólo útiles; con frecuencia el masaje, hecho intempestivamente ó demasiado violento, exagera la neuralgia ó la hiperestesia.

III

Lo que acabo de decir á propósito de la alimentacion exagerada, de la alimentacion hecha al acaso, sin contar con el sistema nervioso, nociva no sólo al estómago sino á todos los centros; lo dicho á propósito de las medicaciones generales empleadas para curar los fenómenos nerviosos, hidroterapia, baños prolongados, medicamentos que se dirigen á tal ó cual víscera, nos muestra nuevamente que en la nutricion es necesario no preocuparse sólo del alimento. El médico no obtiene ningun buen resultado en el alivio del enfermo si sólo tiene presente las nociones que le da la fisiología experimental; debe tener en cuenta además la evolucion natural de los fenómenos nerviosos, contar día por día con el estado del sistema nervioso, observarlo y modificar constantemente los

ejercicios del cuerpo y el régimen alimenticio, segun el grado de sufrimiento por que pasan los centros.

He hecho ver con la observacion que antecede lo que vale, bajo el punto de vista de la neurosis, un régimen alimenticio compuesto de carne en exceso, de pan, etcétera, que agrava la enfermedad y hace enflaquecer.

¿Cuál es el efecto del régimen alimenticio compuesto de líquidos no dañinos al estómago por sí mismos, por su composicion? Me refiero á la leche en altas dosis, en cantidad más que suficiente para la nutricion.

Un enfermo de cuarenta y seis años tiene desde hace cuatro irritacion de la médula, que se caracteriza por crisis dolorosas de los nervios intercostales, crisis diarias que duran cinco horas, de una á seis; su estómago, dilatado, arroja cada día 3 litros poco más ó menos de líquido ácido.

Desde hace cinco meses el enfermo está sometido al régimen lácteo, y toma cada día de 7 á 9 litros de leche, cantidad que sobrepuja notablemente la necesaria para vivir y representa más del triple de dicha cantidad. No vomita nunca la leche,

pero los síntomas de la dispepsia no se han modificado; las crisis de los nervios intercostales no han perdido ni su intensidad ni su duracion. Cinco meses de este tratamiento han sido incapaces de disminuir ni la irritacion del plexo ni la de la médula. El médico le aconseja entonces empezar los lavados del estómago; de febrero á julio se le hace un lavado por día. ¿Qué hicieron cuatro meses de lavado? Nada bueno, y no podian producir nada útil sobre los centros irritados, como lo demostraremos más adelante. Las crisis dolorosas continúan, el estómago permanece enfermo. Así, pues, el régimen lácteo, bien que dando al organismo todos los materiales nutritivos necesarios, no disminuye un punto los sufrimientos de los centros, no modifica su estado, y el lavado del estómago repetido sirve sólo para mantener la irritacion de dichos centros.

Un jóven de veinte años, empleado en una oficina, trabaja nueve horas por día y ha sido afectado hace dos años por aumento de fatiga, de irritacion cerebral; experimenta un violento aturdimiento y la neurosis se desarrolla: en la actualidad, la piel del cuello y sus músculos, la piel del

dorso, del tórax y sus músculos están hiperestesiados; el plexo y los centros periumbilicales derecho é izquierdo son dolorosos á la presion; tiene náuseas, arroja gases y sufre de constipacion.

Su régimen, desde hace meses, consiste en leche, huevos, pan, y su estado no se mejora; el cerebro, la médula, el plexo, permanecen irritados y los fenómenos nerviosos no disminuyen de intensidad.

Citaré aún la observacion de un hombre de cuarenta y ocho años que sufre sólo de insomnio; el estómago está dilatado hasta 8 centímetros por bajo del ombligo, tiene dolores despues de las comidas, arroja gases y vomita 2 litros de líquido cada día. Este enfermo se nutre desde hace muchos meses con 2 litros de leche, seis ú ocho huevos y una papilla; el alimento es suficiente, pero la enfermedad no es influida por el régimen, y lejos de curar, el estado se agrava.

Ni la alimentacion excesiva es provechosa al sistema nervioso, ni la alimentacion líquida es suficiente para restablecer el equilibrio perdido de los centros nerviosos.

Las razones son múltiples. La alimen-

tacion excesiva irrita los centros nerviosos; el régimen líquido prolongado los irrita tambien. Para curar el plexo, el médico no debe sólo preocuparse del régimen alimenticio, es decir, del tratamiento del estómago, sino que tambien debe pensar en el régimen que debe imponer al cerebro y á la médula; el estómago cura por el régimen cuando está solo comprometido; pero en el mayor número de casos, el cerebro y la médula participan de la irritacion, y entonces la del plexo se mantiene mientras los otros centros no se calman; es, pues, necesario contar igualmente en el tratamiento de la dispepsia, sobre todo si es intensa, con los otros centros nerviosos que intervienen siempre para hacer durar la enfermedad del estómago: todos los centros están ligados entre sí, tanto en el estado de enfermedad como en el estado fisiológico.

El primero de los enfermos, cuya observacion acabo de resumir, presenta crisis de neuralgias intercostales; el segundo tiene insomnio, como solo síntoma de irritacion cerebral; el tercero, en fin, sufre de dolores de cabeza y de vértigos; el médico debe fijar la duracion del trabajo intelec-

tual y la suma de ejercicios físicos que convienen á estos diferentes enfermos.

La cuestion de los ejercicios físicos, del trabajo manual y del trabajo cerebral ha sido tratada hasta el presente por los higienistas de un modo general; se aconseja el ejercicio porque, se dice, facilita las combustiones é impide ciertas enfermedades, la gota, la obesidad; la marcha se aconseja al dispéptico porque el movimiento activa la digestion; el trabajo cerebral ha sido apreciado bajo el punto de vista del cerebro mismo y no con respecto á sus reacciones sobre los otros centros nerviosos.

El ejercicio exige la intervencion del cerebro y de la médula; así, pues, si el primero de los enfermos citados hace demasiado ejercicio, si marcha con exceso, mantendrá la irritacion de la médula, y por consiguiente la del plexo, y entonces las crisis de los nervios intercostales, así como el estómago, no se curan; esto es lo que ha sucedido. El segundo enfermo, que escribe nueve horas por día, mantiene la irritacion del cerebro y de la médula y su estado estomacal no se mejora; en fin, lo mismo diremos del tercer enfermo. Los médi-

cos químicos están en un error al aconsejar el movimiento para curar la dispepsia; el reposo, la inmovilidad convienen solos: conozco médicos que aconsejan la gimnasia despues de las comidas ó por la mañana en ayunas.

La mujer que borda ó toca el piano inmediatamente despues de comer, no se restablece. Hay médicos que aconsejan al enfermo ir al mar, al campo, para respirar un aire más vivo; hay enfermos que espontáneamente pasan el invierno en Niza ó en la playa, y todos vuelven, si no peor, por lo menos tan mal como á su ida. Su sistema nervioso no soporta el aire vivo, los vientos que reinan en el mar. Los movimientos de los brazos, de las piernas, irritan el plexo; además, todo el mundo sabe que una emocion triste daña el estómago, que la gran atencion de espíritu repercute directamente en el estómago. El aire demasiado vivo excita un sistema nervioso turbado. Es necesario, pues, prescribir al dispéptico, no sólo el alimento que le conviene, sino indicarle además la cantidad de trabajo físico ó intelectual que puede ejecutar, el medio atmosférico en que debe vivir. Diariamente recibo enfermos

que han pasado dos meses en la playa y cuyo estómago está peor. Cuando las diversas células nerviosas no están reglamentadas en sus operaciones, es inútil esperar que el alimento sólo sea suficiente para curar.

Pocos enfermos he encontrado en quienes el régimen del estómago haya bastado para calmar los síntomas nerviosos de los otros centros. Sin el concurso del estómago, el enfermo no tiene ninguna mejoría; el plexo solar es, por decirlo así, la llave maestra de todo el edificio nervioso, y tan pronto como este centro se calma, la disminucion simultánea de todos los síntomas que han sido evocados por la enfermedad se hace sentir: la clínica sola puede hacernos ver su influencia; el médico nada puede sin su concurso. En cuanto el enfermo toma un alimento ó una bebida que lo irrita, la agravacion es inmediatamente general: todos los órganos, todos los nervios que habian sido primitivamente afectados, presentan fenómenos más violentos, y la agravacion se detiene tan pronto como se vuelve estrictamente al régimen. No hay víscera que obedezca mejor que el estómago á la accion de la higiene.

Ciertas enfermedades del corazon, del pulmon, del hígado, etc., dejan al médico sin recursos bien á menudo; pero éste lo puede todo en presencia del estómago, que corresponde siempre exactamente á la intervencion de la ciencia: la dispepsia crece fatalmente á cada error de alimentacion ó de terapéutica.

Es necesario guardarse de introducir al acaso medicamentos en el estómago; la mayor parte le son nocivos; he probado que muy pocos pueden serle útiles: el fosfato de cal, el bismuto, el sulfato de sosa, el bromuro de sodio, el bromhidrato de quinina, el bicarbonato de sosa. La dosis de estos últimos no deberá pasar de 15 á 20 centígramos. La administracion de medicamentos practicada sin tener cuenta de la delicadeza del órgano, trae consigo los más serios accidentes.

Lo mismo diremos del alimento: los alimentos deben darse con conocimiento exacto de sus propiedades, bajo el punto de vista del estómago; los alimentos que contienen principios irritantes, setas, trufas, coles, etc., deben ser proscritos; no puedo citar todos los que pueden tomarse sin inconveniente: los alimentos son irri-

tantes por sí mismos, ó por las preparaciones culinarias; la cocina, hecha con aceite, con manteca, con grasa, no conviene al estómago que sufre; el modo de preparacion inglesa de las legumbres se adapta mejor al órgano afectado.

La carne es más congestionante que todos los demás alimentos. Debe prescribirse con gran precaucion en la neurosis, una ó dos veces por día, ó una vez cada dos ó tres días, segun la intensidad de la dispepsia, ó sólo una vez por semana. Acompañándose cada comida de una congestion de la mucosa, hay siempre una recrudescencia al cabo de algunos días, á pesar de que los alimentos se tomen con precaucion, y entonces los síntomas del estómago ó ajenos á éste son más intensos durante un día ó dos; es necesario prever la agravacion momentánea que se presenta cada tres días al principio, cada cuatro despues y que se aleja cada vez más; el enfermo deberá estar prevenido de esta agravacion que ocasiona siempre cierta inquietud, y el médico deberá suprimir este día los alimentos dados en los precedentes y que serán nocivos el tercero ó el cuarto día.

El estómago no marcha directamente hácia la salud como las otras vísceras, sufre detenciones regulares, intermitentes, que le son impuestas por su estructura y por su centro nervioso. En la mujer cada período menstrual trae los accidentes del estómago con toda su intensidad; pero pasado el período, la mejoría, que precedia las reglas, reaparece ordinariamente; durante este período, el régimen será impuesto con la mayor severidad. Si no se toman todas las precauciones, se puede asistir á una recaida; la mujer se desconsuela por la detencion sobrevenida en su curacion, y debe ser informada de antemano de la recrudescencia pasajera.

Así, pues, ninguna enfermedad presenta una evolucion semejante á la de la dispepsia; las descripciones que los autores han dado de ella no la hacen conocer, son incompletas; la dispepsia no ha sido nunca seguida y observada sériamente.

La dispepsia trae consigo la enfermedad de todo el organismo, y éste se restablece al mismo tiempo que el estómago. Cuando se la abandona, se hace cada vez más séria, y entonces produce las crisis que he descrito, crisis de los centros

nerviosos, crisis de los nervios, de las vísceras. ¿Cómo deberá conducirse el terapeuta para hacer desaparecer estas crisis que reaparecen sólo cuando el enfermo no se cuida?

Las crisis no reaparecen sino cuando hay exceso de fatiga, cuando el régimen alimenticio está mal ordenado, etc.

La señora de un director de escuela de París cae sin conocimiento en la calle tres veces en el espacio de un mes, y no se atrevia á salir más, era dispéptica; le anuncié que sus crisis eran producidas por el estómago, y que no reaparecerian en cuanto el órgano se curase. Las crisis desaparecieron, en efecto, por el tratamiento.

Una jóven de quince años perdia el conocimiento cuatro, cinco veces por día, cada vez que tomaba un alimento, y la pérdida de conocimiento era seguida de contractura de los miembros; su médico, que le habia ordenado una alimentacion exagerada, carnes y preparaciones ferruginosas, viendo que los accesos se hacian cada vez más frecuentes, me llamó en consulta; los padres estaban muy alarmados, y el médico en extremo indeciso para caracterizar estas crisis múltiples con pér-

dida de conocimiento, que se repetian muchas veces por día y que podian determinar la muerte. ¿Era epilepsia, histeria ó síncopes? No se trataba de ninguna de estas afecciones; este género de crisis tan comunes, que observo á cada instante, no está descrito en la patología actual, ó bien corresponde al diagnóstico de las enfermedades que acabo de indicar. Existe, pues, un vacío muy grave en lo que atañe al enfermo, y que desconcierta al médico. La crisis se presenta cuando el cerebro y el plexo están irritados. Hice cesar las crisis de esta jóven condenándola al reposo absoluto durante quince días, alejada de toda sociedad y proscribiendo todo trabajo: fué alimentada con leche durante este período; la alimentacion aumentó más tarde. Dos meses despues, esta jóven, cuyas crisis eran tan frecuentes y se repetian cada día, estaba perfectamente curada.

Cada centro nervioso, cada nervio, puede tener , en individuos cuyo sistema nervioso está perturbado de antiguo, sus crisis, que durarán indefinidamente si no se trata el sistema nervioso.

He hablado en mi anterior libro y en el presente de una señora de cuarenta y ocho

años que sufria, tres meses hacia, de dolores atroces de cabeza que la privaban en absoluto de sueño y la impedian alimentarse; tres meses hacia que un médico de los hospitales, creyendo que se trataba de congestion cerebral, le aplicaba sanguijuelas, vejigatorios y le administraba purgativo sobre purgativo; la enferma estaba desesperada y moribunda; fuí llamado al cabo de esos tres meses, é inspirándome en mis nuevos conocimientos clínicos empecé á tratarla, y en menos de diez días logré calmarla; esta señora está bien hace tres años.

En los casos de vértigo intenso, en que el enfermo no puede hacer el menor movimiento de cabeza sin tener náuseas y vómitos, en que el cerebro está de tal modo vertiginoso que el enfermo no puede volver los ojos sin sentir náuseas, es necesario condenarlo á la inmovilidad absoluta durante cierto tiempo y administrarle alimentos que le permitan nutrirse, evitando los que puedan excitar el plexo; la leche será exclusivamente prescrita en los primeros días; debe calmarse la cabeza con aplicaciones repetidas de cantáridas, el sistema nervioso con pequeñas dosis de

bromuro de sodio repetidas muchas veces en el día, de modo que no se fatigue el plexo solar. Si en lugar de vértigos el cerebro está tan irritado que el sueño haya desaparecido y que su ausencia persista meses ó años, no hay que esperar hacerlo volver con medicamentos; todos son nocivos; el enfermo que no duerme, hace con frecuencia largos paseos para recuperar el sueño; pero éste se aleja tanto más cuanto que los ejercicios físicos aumentan la irritacion cerebral: los mismos principios generales de tratamiento deben guiar al médico para que el sueño aparezca nuevamente. Dolores de cabeza, vértigos, insomnios, tienen la misma significacion y exigen los mismos cuidados.

Las crisis del plexo solar son denominadas crisis de gastralgia por la patología clásica, y se combaten con las preparaciones de opio, con el éter, y cuando son en extremo violentas, se recurre á las inyecciones subcutáneas de morfina; la crisis es así atajada ó se detiene por sí sola, espontáneamente, para reproducirse; nada se dice del régimen alimenticio que conviene, y las crisis se hacen cada vez más frecuentes y más intensas. Algun tiempo despues,

si el tratamiento ha sido irracional, se hace sumamente difícil detenerlas y el terapeuta se encuentra sin recursos. La crisis del plexo es idéntica en su naturaleza á una crisis cerebral; con el tiempo, el dolor de cabeza se hace constante; en ciertos enfermos el plexo presenta una sensacion constante de peso, que si dura largo tiempo se instala en permanencia y cura difícilmente. A menudo las crisis del plexo se confunden con cólicos hepáticos por médicos instruidos; las aguas alcalinas que se aconsejan entonces sirven sólo para mantener las crisis.

Los otros centros nerviosos del abdómen, periumbilicales y subumbilical, están sujetos á crisis no menos frecuentes que las del plexo solar, y regularmente se asemejan á otras enfermedades, confundiéndose con cólicos hepáticos, cólicos del riñon, y si son intensas y ocasionan hiperestesia de la piel y de los músculos del abdómen, son siempre diagnosticadas de peritonitis, sobre todo cuando la fiebre viene á complicar estos síntomas. El médico se encuentra entonces completamente desconcertado, porque desconoce estos centros nerviosos y sus crisis.

Presto mis cuidados á una jóven española que, desde hace seis años, tiene sin interrupcion todos los días crisis de los dos centros periumbilicales; ha sido enviada á Vichy, y de antemano se comprenderá cuáles han sido las consecuencias de una cura de aguas alcalinas.

He sido llamado esta semana á provincias cerca de un enfermo de cincuenta y cinco años, que presentó hace veinticinco fenómenos de irritacion medular, dolores de los nervios, de los músculos del cuello y del brazo; desde hace cinco años sufre crisis que se propagan del plexo al centro izquierdo y recíprocamente; he sido llamado cuando una de esas crisis duraba desde hacia diez días; el enfermo acababa de seguir, á pesar de mi prohibicion, un tratamiento termal en que se le prescribian baños de una hora y duchas calientes, baños y duchas que han exasperado sus centros y las crisis se han hecho mucho más tenaces é intensas; le he prescrito la inmovilidad absoluta durante quince días con prohibicion de leer, mover los brazos, de tomar él mismo sus alimentos, no consistiendo éstos más que en litro y medio de leche en veinticuatro horas: la cri-

sis abdominal ha disminuido prontamente.

Podria repetir, á propósito de los accesos de neuralgia, de hiperestesia, lo antes dicho sobre los centros nerviosos; estos accesos ceden cuando se trata el sistema nervioso siguiendo las indicaciones generales que acabamos de enunciar. La crisis es el resultado de una irritacion prolongada, provocada por excesos de toda especie, trabajo intelectual y físico, mal régimen alimenticio, por la menstruacion, etc. La crisis no se reproducirá si los centros nerviosos se calman, y el reposo es indispensable al sistema nervioso. El cerebro no descansa realmente sino en la posicion horizontal y suspendiendo toda lectura, todo trabajo, toda preocupacion por hechos del mundo exterior; la médula descansa con la suspension de todo trabajo, de toda marcha, y los centros nerviosos abdominales, unidos á la médula, á los nervios de los miembros inferiores, no experimentan bienestar sino en la posicion horizontal; importa, además, que el alimento no ocasione excitacion alguna en el plexo, y entonces el sistema nervioso encuentra la calma, el reposo que le son necesarios para su restablecimiento; sin estas condiciones

el mal se prolonga indefinidamente, se agrava sin cesar, el enfermo continúa sufriendo y muere.

El conocimiento del sistema nervioso que debemos á la fisiología experimental no nos ha enseñado nada preciso sobre sus enfermedades; la clínica sola nos muestra con toda evidencia sus manifestaciones cuando sufre, su evolucion morbosa, revelándonos tambien cómo puede el médico llegar á restablecerlo de suerte que vuelva á su silencio y que recupere su funcionamiento sin ser sentido por el sujeto.

Sucede con las crisis de las vísceras lo que con las del sistema nervioso. Las crisis de palpitaciones, de angina de pecho, el asma, los espasmos de la vejiga, etc., no cederán á los medicamentos; es necesario que los centros nerviosos se calmen, y el médico observará entonces que todas las complicaciones de la irritacion de los centros resentidas por las vísceras se atenúan poco á poco y desaparecen. Algunas veces los centros nerviosos, que han producido crisis hace más ó menos tiempo, se habitúan, por decirlo así, á renovar estas crisis en los mismos días y á las mismas horas; las precauciones de régimen y de re-

poso no son siempre suficientes para conjurarlas, y en ese caso el médico triunfa de ellas á menudo añadiendo al tratamiento el lavado del estómago.

El enfermo que sufre de dolores de cabeza, de vértigos, de insomnios por crisis, no se calma siempre con las indicaciones que acabo de formular; la curacion será más pronta si se lava el estómago. Al hospital han venido enfermos que no dormian desde hacia seis meses ó un año. El bromuro de sodio, el reposo, la leche, las cantáridas aplicadas en la apófisis mastoidea, no hacian venir el sueño, pero éste aparecia en la noche que seguia al lavado del estómago. Una señora de veintiocho años tenia náuseas continuas día y noche desde hacia dos años; me he visto obligado á empezar el lavado del estómago al cabo de doce días de tratamiento, porque las náuseas no disminuian; practiqué dos lavados en el intervalo de ocho días, y las náuseas disminuyeron y cesaron. La enferma curó al cabo de cuatro meses.

Es necesario explicar ahora al lector la accion del lavado, por qué y en qué casos debe intervenir y lo que se puede esperar

de él en la neurosis; el lavado es empleado actualmente por los médicos todos los días, y con frecuencia dos veces por día durante un tiempo indefinido; es necesario hacer conocer su verdadera accion y decir por qué puede utilizarse.

IV

LAVADO DEL ESTÓMAGO

El lavado del estómago es una operacion que se practica sobre todo desde hace quince años; pero se ha aplicado tan mal á propósito en muchas personas, que ya ha caido en descrédito, y sin embargo puede prestar servicios tales, que no es posible reemplazarlo por ninguna medicacion. Se hace por medio de un tubo de cautchuc blando, un embudo de vidrio y un líquido alcalino, sea agua de Vichy calentada, sea agua tibia, á la cual se añade por litro 6 gramos de bicarbonato de sosa, 4 gramos de sulfato de sosa y 50 centígramos de cloruro de sodio. El tubo de cautchuc ha sufrido ciertas modificaciones que no presentan ningun interés: el tubo blando ha sido terminado por otro tubo más resistente; se

han adaptado dos tubos colocados paralelamente uno al lado del otro, para permitir una doble corriente de agua, el uno que introduce el líquido en el estómago y el otro que permite su salida al exterior, de tal suerte, que este órgano pueda ser atravesado por gran cantidad de líquido, 8 ó 10 litros á la vez. Los médicos que han hecho estas modificaciones al tubo pensaban que el lavado sirve para lavar el estómago, limpiarlo de sus inmundicias, de sus vibriones, de los restos de alimentos, de productos irritantes; ahora bien, nada hay de menos cierto. He hecho gran número de lavados; cuando lo practico por la mañana en un estómago no dilatado, el agua introducida sale clara y pura; sólo cuando la víscera está dilatada, el agua se ensucia con los líquidos contenidos en el estómago y las partículas alimenticias.

El lavado del estómago no está, pues, destinado á lavar el estómago, á limpiarlo; el principio del lavado, de la limpieza del estómago, ha sido formulado por los médicos que profesan que la dispepsia consiste en una química defectuosa, una insuficiencia de jugo gástrico, por lo que suponen que la dispepsia puede ser de orí-

gen microbiano, y consideran el estómago como una retorta sucia que es necesario limpiar, y por eso hacen el lavado todos los días y aun dos veces por día. La enseñanza oficial hecha de lo alto de la cátedra esparce rápidamente estas ideas, y los discípulos que las aplican con todo su rigor hacen pasar corrientes de agua en cantidad indefinida por el estómago, 10 litros á la vez. De este modo aniquilan el órgano y quedan convencidos que la tarea es tanto más provechosa; si, en efecto, se trata de limpiar el estómago, éste quedará tanto más limpio cuanto mayor sea la cantidad de líquido que se emplee, más limpio mientras más se lave; pero el estómago no es una retorta que sea necesario limpiar, sino un órgano nervioso, cubierto de una mucosa muy sensible, riquísima en nervios, que produce el jugo gástrico cuando el plexo solar no está irritado y en el que no se hacen reacciones químicas como en una retorta; la química que se efectúa en su interior es elemental y consiste sólo en una sencilla transformacion molecular; excepcionalmente se encuentra ácido butírico y láctico; el estómago más enfermo está vacío por la mañana en ayunas, está

limpio, y sin embargo, existen fenómenos dispépticos múltiples: no se trata, pues, de lavar, de limpiar el estómago. Un hecho singular es que sucede con el lavado lo que con las inyecciones subcutáneas de morfina; en muchos enfermos la operacion es seguida de un alivio inmediato, y están dispuestos á repetirla diariamente y aun varias veces en el día; toman gusto al lavado del estómago como á las inyecciones de morfina, y mantienen la enfermedad por el lavado, la agravan y con frecuencia mueren. El lavado repetido sin medida es en extremo peligroso.

He sido consultado por el director del colegio Stanislas, que desde hacia tres años se lavaba él mismo el estómago todos los días antes de recibir á los parientes de los alumnos; este señor tenia una dilatacion sencilla del estómago, vomitaba cada día gran cantidad de líquido, 2 ó 3 litros, y por no verse expuesto á vomitar en medio de las recepciones y de las conversaciones con las visitas, lavaba su estómago. El líquido se formaba de nuevo al día siguiente, y la operacion comenzaba de nuevo. Un órgano tan nervioso se excita por la sonda que hace ex-

cretar líquido, lo reproduce. Tres años hacia que este órgano no habia cesado de ser irritado; hice esfuerzos para convencer al director de los inconvenientes de una operacion de este género renovada diariamente; pero este distinguido prelado, más preocupado de la direccion de su colegio que del peligro de los lavados múltiples, de vigorosa constitucion, y no sintiéndose debilitado, continuó á pesar de mis consejos y murió algunos meses más tarde.

He citado ya en mi precedente libro á un arquitecto de París que estaba moribundo á consecuencia de once lavados del estómago hechos en once dias consecutivos; suspendí el lavado, impuse al enfermo el reposo absoluto, fué alimentado con las mayores precauciones, se restableció y pudo emprender de nuevo sus tareas.

El lavado del estómago es mucho más peligroso cuando el enfermo hace la operacion él mismo, porque debe intervenir con gran esfuerzo de voluntad, aumentando así los desórdenes de su sistema nervioso. Los médicos que confian esta operacion al enfermo demuestran no haber comprendido sus efectos.

¿Cuál es, pues, su accion y por qué puede

ser nocivo? Es necesario tener cuidado de introducir la sonda lentamente: hay enfermos nerviosos en quienes la lengua no puede ser comprimida sin que se produzcan inmediatamente esfuerzos de vómito, y la sonda provoca contracciones violentas de los músculos de la lengua; cuando la sonda ha pasado fácilmente la boca, el espasmo puede tener lugar á su paso por la faringe y en su marcha hácia el estómago. El espasmo es con frecuencia tan violento, que la sonda es expulsada y el enfermo sufre mucho; su introduccion debe intentarse de nuevo, previniendo al enfermo que esta operacion será tanto más útil cuanto más intensos son los espasmos. Cuando éstos se presentan espontáneamente despues de las comidas, desaparecen por la sonda. Ésta determina una sensacion de estrangulacion al nivel de la laringe; el paciente cree ahogarse y morir; grita, y el operador dejará entonces la sonda inmóvil un instante, hasta que la disnea haya disminuido; hay pacientes que se cianosan súbitamente. En el esófago, en fin, aparecen nuevos espasmos, que serán disminuidos por el tubo; la sonda llega al estómago; su paso determina en algunos

enfermos, por excitacion del plexo, una crisis nerviosa, temblor de las manos y de las piernas, castañeteo de dientes, fenómenos que no deben detener la operacion. He observado algunas veces que el agua introducida en el aparato no penetra en el estómago porque el espasmo del esófago aplasta el tubo y no deja pasar el líquido; es necesario esperar en este caso algunos segundos, y el agua bajará; en otros casos, el espasmo persiste, y el agua no llega al estómago; la operacion será renovada ocho dias más tarde; esta primera introduccion del tubo, sin que el líquido haya tocado el estómago, es tambien útil y disminuye ciertos fenómenos nerviosos.

En algunos casos, enfermos muy nerviosos han caido por tierra, perdiendo el conocimiento cuando la sonda habia llegado al estómago; la crisis es seguida de contractura de los miembros, pero no debe inquietar al médico. Yo retiro entonces inmediatamente la sonda, y dejo al enfermo por tierra. Incluso en estos casos, que indican el neurosismo en su más alto grado, el cateterismo es provechoso.

Una mujer de veinticinco años, dispéptica, sufria tales vértigos muchas semanas

hacia, que le era imposible abandonar el lecho; vino á mi hospital, y diez días despues, viendo que el vértigo no se calmaba, practiqué el lavado del estómago; en medio de la operacion, la enferma cayó de la silla y rodó por tierra presa de violentas convulsiones; algunos días más tarde el vértigo comenzó á ceder, pero no renové el lavado: es preciso evitarlo cuando el enfermo está muy débil ó muy excitado; conviene entonces dejarlo reposar algunos días antes de practicar la operacion.

El agua debe permanecer en el estómago quince á veinte segundos, y el enfermo la devolverá; sale sin esfuerzo ó despues de un esfuerzo de tos, estando el individuo inclinado hácia adelante.

El lavado engendra un estado de fatiga enorme, que dura cuarenta y ocho horas, y la mejoría se siente entonces, ó bien es seguido de una mejoría inmediata sentida el mismo día ó veinticuatro horas más tarde; el apetito, perdido desde hace tiempo, puede volver; los espasmos del estómago, las náuseas, los vómitos, disminuyen; el estómago no experimenta siempre la influencia del lavado, pero sí el cerebro ó la médula; los dolores de cabeza, los vér-

tigos, se calman; el insomnio, refractario á todos los medicamentos, al régimen, cede; las neuralgias, que tambien resistian á los remedios y al régimen, son menos vivas, pierden su intensidad; los síntomas cerebrales son, sobre todo, felizmente modificados por el lavado.

Esta operacion obra sobre el plexo solar, y por medio de éste sobre el cerebro y la médula; el sistema nervioso recoge su efecto útil. Cuando el enfermo es aliviado por el primero, un segundo lavado será practicado ocho dias despues por el médico y nunca por el enfermo, que no puede apreciar el momento oportuno; la operacion será practicada preferentemente por la mañana en ayunas, cuando el estómago está vacío, cuando los restos de alimentos no vienen á obstruir el tubo; la operacion puede ser renovada tres ó cuatro veces, ó de tiempo en tiempo, á quince dias ó tres semanas de intervalo, cuando los síntomas nerviosos hayan reaparecido por un motivo cualquiera.

Si el primer lavado no ha producido nada bueno, es necesario abandonar la operacion; el enfermo enterará al médico del efecto producido por el primero. Reno-

vada todos los días y dos veces por día, esta operacion aniquila el sistema nervioso; es necesario guardarse de hacerla cuando el enfermo la pide, pues no puede juzgar la oportunidad de la operacion; su accion termina, en general, siete ú ocho días despues y entonces debe renovarse.

Hay casos en que el lavado del estómago es indispensable; los dolores de estómago de antigua fecha no curan á menudo más que por la operacion del lavado; pero tan pronto como se observe una mejoría, es preciso no renovarla, porque puede determinarlos lo mismo que los hizo cesar. En los casos de vómitos violentos, si éstos no disminuyen por el primer lavado el segundo puede aumentarlos. Cuando el estómago está dilatado, es necesario hacer uso de él con las mayores precauciones, ó la dilatacion aumenta. Una señora de setenta y un años va á pasar una temporada á Vichy, y el médico le aconseja lavarse el estómago; la operacion es practicada todos los días durante cinco meses consecutivos; al cabo de este tiempo la enferma es trasportada moribunda á mi consulta. El estómago habia llegado á 8 ó 10 centímetros por bajo del ombligo; la en-

ferma vomitaba 5 á 6 litros de líquido por día, tenia náuseas constantes y estaba atormentada por una sed ardiente. Hice cesar todo lavado del estómago, y muchos meses han sido necesarios para restablecerla.

El lavado, renovado con demasiada frecuencia, es peligroso en los casos de dilatacion del estómago, porque irritando el plexo tiende á aumentar la dilatacion debida á este centro nervioso.

Es tambien peligroso en el cáncer del estómago, porque parece activar su evolucion; por el contrario, prestará los mayores servicios cuando se trata sólo de crisis del plexo. El cuñado de mi amigo el doctor Jullien sufria quince días hacia de crisis atroces del plexo, y á pesar de sus dolores viene precipitadamente de Lyon á París para hacerse asistir. Diez días de tratamiento habian servido sólo para disminuir la violencia de las crisis; pero éstas reaparecian siempre, y no cesaron completamente hasta despues de practicar un lavado del estómago.

Este no sirve, pues, para limpiar el estómago, sino que modifica el estado de los centros nerviosos y calma su irritacion,

como lo demuestra la observacion continua durante muchos años. Es imposible prever cuál será su efecto sobre tal ó cual enfermo. El lavado puede prestar grandes servicios si se le practica oportunamente, y será muy nocivo si se hace al acaso y sin indicaciones bien precisas; es un arma útil entre las manos del que sabe manejarla, y peligrosa cuando se emplea sin el conocimiento de sus efectos reales.

CAPÍTULO XVIII

EDUCACION

El estudio de la neurosis me conduce á tratar brevemente la cuestion de la educacion, que tanto interés presenta bajo el punto de vista de la salud y de la vida del individuo.

El objeto de la educacion es proteger y fortalecer el sistema nervioso del niño; gracias al sistema nervioso, el sér intelectual, moral y físico llegará al desarrollo á que está predestinado. Este desarrollo puede ser incompleto si la suma de ejercicio físico, de instruccion ó si la alimentacion exceden la medida que conviene á los centros nerviosos, ó si, por el contrario, no llegan á ella.

La educacion puede, pues, ser defectuosa por muchas razones.

Los padres, imbuidos de preocupaciones y de errores, aunque animados todos de las mejores intenciones, hacen á menudo el mayor daño á sus hijos por ignorar absolutamente los principios fundamentales de una sana educacion.

Debo, pues, llamar la atencion sobre algunos puntos de los más interesantes de la cuestion.

En los primeros años de la vida sólo puede tratarse de ejercicios físicos, de marchas, de paseos y de alimentacion.

Los padres, con el objeto de estimular á los tiernos niños y habituarlos á la marcha para desarrollar el cuerpo, tienen tendencia á hacerlos pasear diariamente, á hacerlos jugar dias enteros sin tregua ni reposo, obligándolos á salir á pesar de los vientos, de las aguas y con los fríos más intensos so pretexto de aguerrirlos; los cubren insuficientemente, dejan las piernas y los brazos desnudos por seguir las prácticas de países extranjeros. Ignoran que la fatiga física repetida diariamente es causa de dolores, de fiebre, y algunas veces de convulsiones que no se piensa en atribuir al ejercicio excesivo. La desnudez de las piernas y los brazos expone el sis-

tema nervioso periférico á las intemperies de las estaciones y determina el coriza, la angina, la bronquitis, la diarrea. El tierno niño debe permanecer encerrado, como el viejo, en los tiempos húmedos y fríos. En los paseos públicos, los niños contraen las bronquitis y las pulmonías, que arrebatan gran número de ellos.

Hasta la edad de cinco ó seis años, el día de actividad física debe ser interrumpido por una hora ó dos de reposo en la posicion horizontal, importando poco que el niño duerma ó no, y éste no tiene necesidad de salir todos los días para respirar el aire. El aire vivo de los grandes espacios es causa de excitacion del sistema nervioso; renovada diariamente, esta causa puede tener por efecto la enfermedad. Desde la edad de siete años, mayor libertad podrá ser acordada al sistema muscular, y el niño podrá moverse más sin perjudicar á la salud, así como soportará mejor las intemperies de las estaciones. La alimentacion debe ser particularmente vigilada al principio; mal compuesta produce muy á menudo la dispepsia con todas sus consecuencias, las complicaciones ce-

rebrales, pulmonares, las convulsiones, la meningitis, la pulmonía, etc.

El niño no será nunca sometido á la dieta, incluso en caso de enfermedad; deberá siempre ingerir 1 litro de leche y sopas en veinticuatro horas; en ningun caso se le hará tomar ni purgativos ni vomitivos, que los padres administran con tanta facilidad temiendo las anginas, el crup, la fiebre; estas sustancias son nocivas y pueden ser reemplazadas por otros medios terapéuticos que no turban el sistema nervioso de los tiernos niños. No hay que hablar de ellos aquí.

La alimentacion del primer año se compondrá de leche, de sopas; la del segundo será completada con huevos y féculas; hácia la mitad del segundo año figurará la carne picada en la comida del niño una ó dos veces por semana, no con el objeto de nutrirlo, sino como estimulante del plexo solar. Sólo á la edad de cuatro años la carne puede ser administrada tres veces por semana ó una vez por día; en los otros días será reemplazada por el pescado blanco.

El temor de la anemia, de la debilidad, hace cometer los más graves errores en el régimen de los niños. Tratamos á los niños

como carnívoros, y les hacemos tomar la carne y aun el vino muchas veces por día con la idea de fortalecerlos con esta alimentacion exuberante en que la carne ocupa el primer puesto; el niño permanece pálido, débil, flaco, se hace nervioso, irritable, caprichoso, desagradable, perezoso; su memoria, su voluntad, permanecen débiles; es incapaz de trabajar y pierde toda actividad cerebral.

Es preciso evitar dar demasiado á menudo las carnes como la de vaca, la carne poco cocida y la cruda sobre todo; ésta última sirve sólo para producir la ténia y no presenta ninguna utilidad como sustancia nutritiva.

Deben evitarse igualmente todos los alimentos que irritan el plexo, las grasas, los frutos crudos, etc., y que sólo toleran los individuos que tienen un plexo bien equilibrado.

Mientras el cerebro está en vías de desarrollo, es necesario no abusar de la carne, que irrita el sistema nervioso más que todos los otros alimentos. En cuanto al vino, conviene suprimirlo completamente.

Numerosas veces me ha sido dado comprobar lo justo de estos datos generales en

el tratamiento de los enfermos; muchas veces he sido consultado á propósito de niños de quienes los padres tenian motivos de queja, bajo el punto de vista del carácter y del trabajo, pues eran perezosos, holgazanes, de humor irascible; todos eran dispépticos. Unos, impacientes, no comian; otros tenian apetito sólo por la carne y se nutrian exclusivamente de ella, teniendo horror por las legumbres que no probaban nunca.

Citaré uno solo de estos numerosos enfermos: se trata de un jóven de diez y siete años que me fué presentado por su padre. Este jóven era indisciplinado, estaba siempre agitado y no podia hacer su trabajo con constancia. Nunca habia comido legumbres y vivia exclusivamente de carne de vaca. Modifiqué completamente su régimen; prohibí la carne durante algunos meses y la reemplacé en parte por vegetales. Despues de dos meses de régimen, el enfermo me fué presentado nuevamente, y el padre me dió las gracias por las felices modificaciones que se habian operado en el carácter del niño con el nuevo régimen, que fué continuado.

He obtenido felices resultados en gran

número de jóvenes enfermos, cuyo carácter he transformado calmando el plexo solar.

Hácia la edad de ocho ó diez años muchos niños son admitidos en internatos que los padres tienen cuidado de escoger bien ventilados, situados en medio de grandes jardines, con vastas salas de estudio, grandes dormitorios; nada falta en apariencia para conservar la salud; hasta las mesas, los bancos, están bien dispuestos en vista de la higiene del cuerpo; todas las condiciones de una buena higiene parecen reunidas para el bienestar del niño; pero lo que los padres ignoran es que la regla uniforme impuesta á todos, alimentacion, ejercicios físicos, trabajo intelectual, convienen á los niños que tienen un sistema nervioso tranquilo, pero fatigará al que no tiene centros nerviosos resistentes; éste no podrá tolerar ni el demasiado número de horas de juego repetidas todos los días, ni el gran número de horas de estudio, ni la alimentacion instituida sin regla y sin principio, y enfermará pronto, perderá la memoria, se hará incapaz de atencion y de aprender sus lecciones. Padres y maestros se quejan, pero el niño no es culpable; está

fatigado, y aquéllos ignoran que el nuevo régimen no es adecuado á su sistema nervioso. Con mucha frecuencia he reintegrado en el hogar paterno, retirado del colegio, á niños enfermos á consecuencia del régimen erróneo, que se han restablecido reglamentando las horas de trabajo, de juego, la alimentacion, y que han podido continuar su educacion interrumpida por la enfermedad.

Las teorías fisiológicas erróneas sobre la alimentacion, los ejercicios corporales, la influencia atmosférica, han conducido á fatigar el sistema nervioso de los niños por el abuso de la alimentacion animal, el abuso de la gimnasia, de los viajes á orillas del mar, etc.; el régimen seguido generalmente ha producido el gran número de nerviosos que se presenta á la atencion del médico.

Lo dicho sobre los niños se aplica á los adultos y á los hombres maduros. Todos comen y beben con exceso; nadie muere de hambre en la sociedad actual, porque el cuerpo puede sustentarse con pan y queso; pero muchas personas, pertenecientes á todas las clases de la sociedad, mueren por abuso de bebidas y de alimentos.

El niño rico de las ciudades consume carne, vino y dulces en exceso, y es pálido, flaco y nervioso; el hijo del labriego, que se alimenta con sopas y pan, está sonrosado y fresco y tiene gran fuerza física; estas diferencias no son imputables al medio atmosférico, porque si se conduce al niño del rico al campo, y si su régimen no cambia, continuará siendo pálido y delicado.

En lo que concierne el órden intelectual y emotivo, es necesario que las mayores precauciones, los mayores cuidados presidan su formacion.

En el principio de la vida, la intervencion es inútil; el niño, activo, lleno de espontaneidad, busca con los ojos, el oído, la mano, los cuerpos que están á su alcance y se penetra de las impresiones que éstos producen; él mismo alimenta el campo intelectual y emotivo con todas las sensaciones que experimenta, siendo de este modo su propio maestro: el niño mira, escucha, toca, prestando á cada objeto una atencion pasajera á causa de su necesidad incesante de movimiento; de este modo forma sus facultades, memoria, voluntad, etcétera, y se duerme tan pronto como el

cerebro ha hecho un esfuerzo. Es necesario abandonarlo á menudo á sí mismo, no tener sus sentidos demasiado tiempo atentos sobre los objetos que le rodean, temiendo fatigarle, no ocupar demasiado su espíritu con la intencion de iniciarlo al mundo exterior. La verdadera educacion del espíritu no debe empezar hasta la edad de siete ú ocho años, y debe graduarse segun la edad, segun el sujeto, recordando que el cerebro del nervioso no tolera la misma cantidad de trabajo que un cerebro tranquilo y vigoroso. No hay igualdad en la naturaleza, y la instruccion integral, aplicada al acaso á todos igualmente, enfermará á muchos, cuyo cuerpo quedará debilitado; toda fatiga cerebral es dañosa al desarrollo del cuerpo, pero es igualmente dañosa al desenvolvimiento de las diversas facultades que deben aparecer simultáneamente; ninguna de ellas debe ser favorecida; el cerebro no será sobrecargado con lecciones demasiado largas, con ciencia demasiado abstracta que exige gran esfuerzo de atencion, con deberes que lo ocupen más allá de un tiempo racional, puesto que el ejercicio excesivo de cada una de las facultades dañará la expan-

sion de las otras; sobrecargar la memoria, la atencion ó alguna otra facultad, es disminuir la potencia de receptibilidad cerebral. Al niño conviene el trabajo regular, moderado, sin las excitaciones que le dan en las escuelas los exámenes repetidos, las oposiciones.

El gran defecto de la organizacion actual de la enseñanza está en imponer al jóven, antes de veinte años, toda la suma de trabajo de que depende su carrera, su porvenir. Muchos de ellos están fatigados, aniquilados á esta edad, y no pueden ya desplegar actividad alguna teniendo el sistema nervioso arruinado. ¡Cuántas nobles inteligencias apagadas porque el trabajo de la juventud fué exagerado! ¡Cuántos enferman por no haber cuidado suficientemente el cerebro!

Usando de todas las precauciones sugeridas por la experiencia, el maestro llegará á dar á la inteligencia toda su potencia innata.

El tierno niño no tiene más que movimientos violentos del alma, deseos incesantes: quiere poseer todos los objetos situados á su alcance; los padres no deben concederle sino los que la razon permite; si,

por debilidad de carácter, por bondad excesiva, los padres conceden al niño todo lo que pide, si éste no se habitúa á encontrar fuera de sí un freno que lo domine, se excita, se encoleriza fácilmente, se hace irritable, nervioso, y aquéllos preparan para el porvenir un sér enfermizo; el niño debe ser sometido desde el principio á una disciplina que servirá á calmar su sistema nervioso.

Hácia la edad de seis ó siete años, cuando la inteligencia nace, la sensibilidad moral exige una primera cultura. La salud del individuo dependerá en el porvenir de su moralidad; el individuo sin moralidad será un libertino que destruirá su espíritu y su cuerpo; es necesario, pues, cultivar en los niños los sentimientos nobles y generosos, la nocion del deber; es necesario tenerlos alejados de las conversaciones, de los espectáculos que puedan herir la delicadeza de sus corazones, y presentarles sólo modelos de virtud y de valor.

Esta cultura del espíritu, dada por el mundo, que favorecerá la expansion del organismo, no es suficiente al hombre llegado á la edad madura.

El organismo humano está atravesado por corrientes nerviosas incesantes que

producen sensaciones y apetitos; el hombre está continuamente agitado, atormentado, y satisface sus sensaciones, sus apetitos, con la fortuna, la mesa, el placer; mas pronto habrá agotado todos los goces, habrá hartado su cerebro y su estómago, y entonces se sentirá triste, escéptico, aburrido. El hombre tiene aspiraciones innatas hácia el infinito, á quien llama Dios; la nocion de Dios es el solo freno capaz de calmar sus pasiones desordenadas, nocivas al cuerpo, y este freno exterior es necesario para mantener la salud: sólo penetrado de la idea divina el hombre vivirá moralmente, sobrio y tranquilo, y encontrará el reposo necesario al equilibrio del sistema nervioso.

La idea de Dios es indispensable á la salud humana. Sin ella la vida es acortada por excesos de todo género, á que fatalmente lleva el organismo.

La idea religiosa dará vitalidad al individuo como á la sociedad; esta idea será, pues, inculcada al niño; suprimirla de la educacion, como lo piden ciertos doctrinarios, es desconocer las leyes del funcionamiento del organismo, es un atentado contra la vida.

¿Cómo se forman los órdenes intelectual y moral? ¿Cómo, con las sensaciones, se produce el sér inteligente y moral?

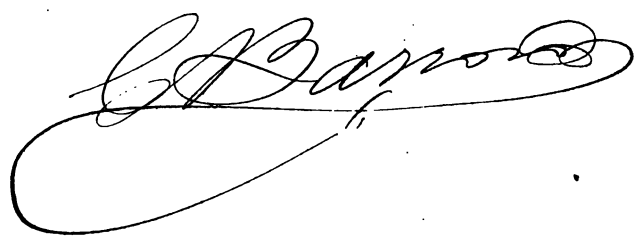
Yo no sé cómo la leche, el huevo que introduzco en mi estómago, va á formar el músculo, el hueso y el nervio. Respondemos que la vida los transforma, poniendo en juego fuerzas múltiples, químicas, físicas, eléctricas, etc.

No sabemos tampoco cómo las impresiones del mundo exterior componen la idea, el juicio, etc. Respondemos que la fuerza innata, el espíritu impregnado en el cuerpo que vive, se sirve de esas impresiones para componer el sér espiritual.

Las causas primeras permanecen desconocidas.

He demostrado que el organismo tiene necesidad, para desarrollarse, de cierto órden de alimentos, y que debe evitar ciertos otros; del mismo modo, el espíritu requiere cierto órden de conocimientos proporcionado á la edad, á la potencia de receptibilidad cerebral: si la cantidad, la especie de alimento son mal adecuados; si la suma de ciencia enseñada no está en relacion con la edad, la capacidad del cerebro; si los ejercicios físicos son insuficien-

tes ó exagerados, todo el organismo sufre, la educacion es defectuosa, el sistema nervioso enferma, la vida será cruzada por afecciones sinnúmero que la hacen miserable y la interrumpen antes de tiempo.



FIN

TABLA DE MATERIAS

Páginas.

PREFACIO. 1-4

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

Definicion de la neurosis. 5-12

CAPÍTULO II

FISIOLOGIA PATOLÓGICA. — *Cerebro*, *médula*, *gran simpático*. — Irritacion de los centros nerviosos.— Irritacion de la célula nerviosa. — Trasporte de la irritacion de un centro nervioso á otro centro . . . 13-23

CAPÍTULO III

ETIOLOGÍA DE LA NEUROSIS. — *Etiología de la irritacion del cerebro*. — Trabajo intelectual: emociones, disgustos, pasiones. — Trabajo físico. 25-28

Etiología de la irritacion de la médula. 28-30

Etiología de la irritacion del plexo solar. — Alimentos. — Carne.— Leche, etc.— Bebidas. — Alcohol, bebidas heladas, calientes, medicamentos. — Pepsina. — Papaína. — Extracto de quina. — Cuasia amara. — Sulfato de quinina. — Hierro reducido.— Aguas alcalinas.— Vichy.— Carlsbad. — La Bourboule.— Aguas-Buenas. — Agua de Pulna. — Fosfato de cal. — Sulfato de sosa. — Estricnina — Ioduro de potasio.—Copaiba, etc.—Masticacion.— Irregularidad en las horas de comer. — Lactacion. 30-52

Páginas.

Causas indirectas de la irritacion de los centros nerviosos. — Fiebre. — Enfermedades de las vísceras abdominales y torácicas. 53-54

Etiología de la irritacion de los centros nerviosos periumbilicales y del plexo lumbo-aórtico. 55-56

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO IV

SINTOMATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 57-59

I. — *Síntomas de la célula cerebral irritada.* — Cefalalgia. — Vértigo y aturdimiento. — Apoplejía nerviosa. — Insomnio. — Jaqueca. — Estado intelectual y moral. 59-81

II. — *Síntomas de la célula de la médula irritada.* — Dolor. — Sensacion de quemadura, de calor, de frío, etcétera. 82-85

TERCERA PARTE

Sistema nervioso abdominal.

CAPÍTULO V

IRRITACION DE LOS CENTROS NERVIOSOS DEL ABDÓMEN. 87-89

Síntomas de la célula del plexo solar irritada. — Alteracion del hambre, de la sed. — Dolor. — Peso. — Quemadura. — Bola. — Disnea. — Calambres de estómago. 89-100

Síntomas de la célula del centro nervioso periumbilical y subumbilical irritada. — Dolor. — Peso. — Quemadura. — Calor. 100-102

CUARTA PARTE

Sistema nervioso periférico.

CAPÍTULO VI

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. — *Organo de la vista.* — Dolores oculares. — Estrabismo. — Alteracion de la vision. — Alucinaciones. — *Organo del oído.* — Dolores auriculares. — Zumbido de oídos. — Sor-

Páginas.

dera. — Alucinaciones. — *Organo del tacto.* — *Organo del olfato.*— Abolicion del sentido del olfato. — Alucinaciones. — *Organo del gusto.* — Errores de sensacion. 103-110

CAPÍTULO VII

NERVIOS SENSITIVOS PERIFÉRICOS.—NEURALGIAS. —HIPERESTESIAS. 111-120

II.— *Nervios de la piel.* — Herpetismo. — Eczema — Urticaria, etc. 121-123

III.— *Nervios viscerales.* 124-125

IV.— *Nervios motores.* 126-127

V.— *Nervios vaso-motores.* — Edema. — Flebitis. — Clorosis. 128-133

VI.— *Nervios de las glándulas de la piel, de las mucosas.* —Glándula tiroides, serosas. — Ovarios. — Testículos. — Riñones. — Litiasis. 134-152

CAPÍTULO VIII

FIEBRE. 153-157

CAPÍTULO IX

EVOLUCION DE LA IRRITACION DE LOS CENTROS NERVIOSOS. 159-166

I.— *Origen cerebral.* 167-169

II.— *Origen medular.* 170-171

III.— *Origen en los centros nerviosos abdominales.* . . 172-179

QUINTA PARTE

CAPÍTULO X

SINTOMAS VISCERALES.— *Nariz.* — *Boca.* — *Faringe.*— *Esófago.* — *Estómago.* — *Intestino grueso.* . . 181-198

CAPÍTULO XI

ESTÓMAGO.— Hinchazon. — Espasmo.— Náuseas.— Regurgitaciones. —Vómitos. —Dilatacion.— Gases. —Hipo. — Cáncer. 199-219

CAPÍTULO XII

INTESTINO GRUESO. — Constipacion. — Diarrea. — Hemorroides. — Fisura. — Prolapsus del recto. . . 221-231

Páginas.

CAPÍTULO XIII

VISCERAS ABDOMINALES Y TORÁCICAS.—Hígado.—Organos genito-urinarios, etc. 233-240
Visceras torácicas. 241-246

CAPÍTULO XIV

CRISIS DE LOS CENTROS NERVIOSOS Y DE LOS NERVIOS. 247-252

SEXTA PARTE

CAPÍTULO XV

REUMA Y GOTA. 253-275

CAPÍTULO XVI

OBESIDAD. — ENFLAQUECIMIENTO. 277-295
RESÚMEN. 296-306

CAPÍTULO XVII

TERAPÉUTICA. 307-312
Higiene de los centros nerviosos. — Alimento. . . . 313-320
Propiedades funcionales del plexo solar. — Alimento de orígen animal, vegetal. 320-326
Accion de la carne sobre el plexo solar. 326
Accion de los vegetales, de la leche, del huevo, sobre el plexo solar. 329
Tratamiento de la neurosis. 331
Hidroterapia. 342
Baños prolongados.—Vejigatorios. 344
Régimen lácteo. 347
Tratamiento de las crisis de los centros nerviosos y de los nervios. 356
Tratamiento de las crisis de las vísceras. 364
Lavado del estómago. 367

CAPÍTULO XVIII

EDUCACION. 379-393

HAYEM (Georges). *Lecciones de terapéutica*, por **Georges Hayem**, profesor de Terapéutica y de Materia médica en la Facultad de Medicina de París; traducidas por D. FRANCISCO GARCÍA MOLINAS, doctor en Medicina y Cirugía.—**Las Grandes Medicaciones.**—Madrid, 1888. Un tomo en 8.°. Precios: en Madrid, en rústica, 8 pesetas; en pasta, 9,50; en provincias, en rústica, 8,50 pesetas; en pasta, 10.

DUJARDIN-BEAUMETZ. *Lecciones de clínica terapéutica* dadas en el Hospital de San Antonio, por el doctor **Dujardin-Beaumetz**, médico del Hospital de San Antonio; recogidas por el doctor E. CARPENTIER MÉRICOURT y revisadas por el profesor.—Obra premiada por la Facultad de Medicina (premio Chateauvillard).—Vertida al castellano, de la última edicion francesa, por D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS, médico numerario por oposicion de la Beneficencia municipal de esta Corte.—*Segunda edicion española* (segunda tirada).—Madrid, 1888. Tres tomos en 8.°; tomo I (*Enfermedades del corazon y de la aorta, del estómago y de los intestinos*), acompañado de un magnífico cuadro y grabados en el texto; tomo II (*Enfermedades del hígado, de los riñones, de los pulmones, de la pleura, de la laringe y faringe*), con dos láminas y grabados en el texto; tomo III (*Tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, de las enfermedades generales y de las fiebres*), ilustrado con 16 figuras intercaladas en el texto y 2 láminas cromolitografiadas. Precios: en Madrid, en rústica, 46 pesetas; en pasta ó tela, 50,50; en provincias, en rústica, 49 pesetas; en pasta ó tela, 53,50.

DUJARDIN-BEAUMETZ. *Las nuevas medicaciones*, conferencias terapéuticas del hospital Cochin (1884-1885), por el doctor **Dujardin-Beaumetz**, médico del hospital Cochin, con 7 figuras en el texto.—Traducidas de la última edicion francesa, por don GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS, médico numerario por oposicion de la Beneficencia municipal de esta Corte.—*Cuarta edicion española.*—Madrid, 1888. Un tomo en 8.°. En rústica, 6 pesetas; en pasta, 7,50.

Continuacion de la *Clínica terapéutica.*

DUJARDIN-BEAUMETZ. *Higiene terapéutica.—La higiene alimenticia.* Conferencias de terapéutica del hospital Cochin (1885-1886), por el doctor **Dujardin-Beaumetz**, médico del hospital Cochin.—Vertida al castellano, de la última edicion francesa, por D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS, médico numerario por oposicion de la Beneficencia municipal. Con 4 figuras en el texto y una lámina cromolitografiada.—*Tercera edicion española.*—Madrid, 1888. Un tomo en 8.°. En rústica, 6 pesetas; en pasta, 7,50.

Continuacion de la *Clínica terapéutica* y de las *Nuevas medicaciones.*

SCHMITT (J). *Microbios y enfermedades*, por el doctor **J. Schmitt**, profesor agregado á la Facultad de Medicina de Nancy, version castellana de D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS.—Madrid, 1887. Un tomo en 12.°, ilustrado con 24 grabados intercalados en el texto.—Precios: en Madrid, en rústica, 3,50 pesetas; en pasta ó tela, 4,50; en provincias, en rústica, 4 pesetas; en pasta ó tela, 5.

BOURRU (H.) y BUROT (P.). *La Sugestion mental* y la accion á distancia de las sustancias tóxicas y medicamentosas, por los doctores **H. Bourru y P. Burot**, profesores de la Escuela de Medicina de Rochefort. Con figuras intercaladas en el texto; vertida al castellano por D. AGUSTIN FÓSTER FERNANDEZ, licenciado en Medicina y Cirugía, socio corresponsal de varias corporaciones científicas, etc. —Madrid, 1888. Un tomo en 12.°. Precios: en Madrid, en rústica, 3,50 pesetas; en pasta ó tela, 4,50; en provincias, en rústica, 4 pesetas; en pasta ó tela, 5.

BEAUNIS (H.). *El Somnambulismo provocado*. Estudios fisiológicos y psicológicos, por **H. Beaunis**, profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de Nancy; version española de la última edicion francesa, por D. ENRIQUE SIMANCAS Y LARRÉ, licenciado en Medicina y Cirugía.—*Cuarta edicion española*.—Madrid, 1888. Un tomo en 8.°, ilustrado con 6 figuras intercaladas en el texto. Precios: en Madrid, en rústica, 3 50 pesetas; en pasta ó tela á la inglesa, 4,50; en provincias, en rústica, 4 pesetas; en pasta ó tela á la inglesa, 5.

CULLERRE (A.). *Magnetismo é hipnotismo*, exposicion de los fenómenos observados durante el sueño nervioso provocado, bajo el punto de vista clínico, psicológico, terapéutico y médico-legal, con un resúmen histórico del magnetismo animal, por el doctor **A. Cullerre**, miembro corresponsal de la Sociedad Médico-psicológica; version española de la última edicion francesa, por D. ENRIQUE SIMANCAS Y LARRÉ, licenciado en Medicina y Cirugía.—*Tercera edicion española*.—Madrid, 1888. Un tomo en 8.°, con láminas. Precios: en Madrid, en rústica, 3,50 pesetas; en pasta ó tela, 4,50; en provincias, en rústica, 4 pesetas; en pasta ó tela, 5.

ANUARIO DE MEDICINA Y CIRUGIA. Revista semestral dedicada al exámen retrospectivo de todos los descubrimientos y adelantos prácticos en las ciencias médicas, tomado en parte del *Retrospect of Medicine* del doctor **Braithwaite**; completado con artículos de publicaciones de otros países por los doctores G. REDOLES Y CAMPOS y F. GARCÍA MOLINAS, ilustrado con 26 grabados intercalados en el texto.—*Segunda série*.—**Tomo VI.—Julio á Diciembre de 1887.** —**ANUARIO INTERNACIONAL.**—Madrid, 1888. Un tomo en 12.°, en rústica, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias; en pasta ó tela, 6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias.

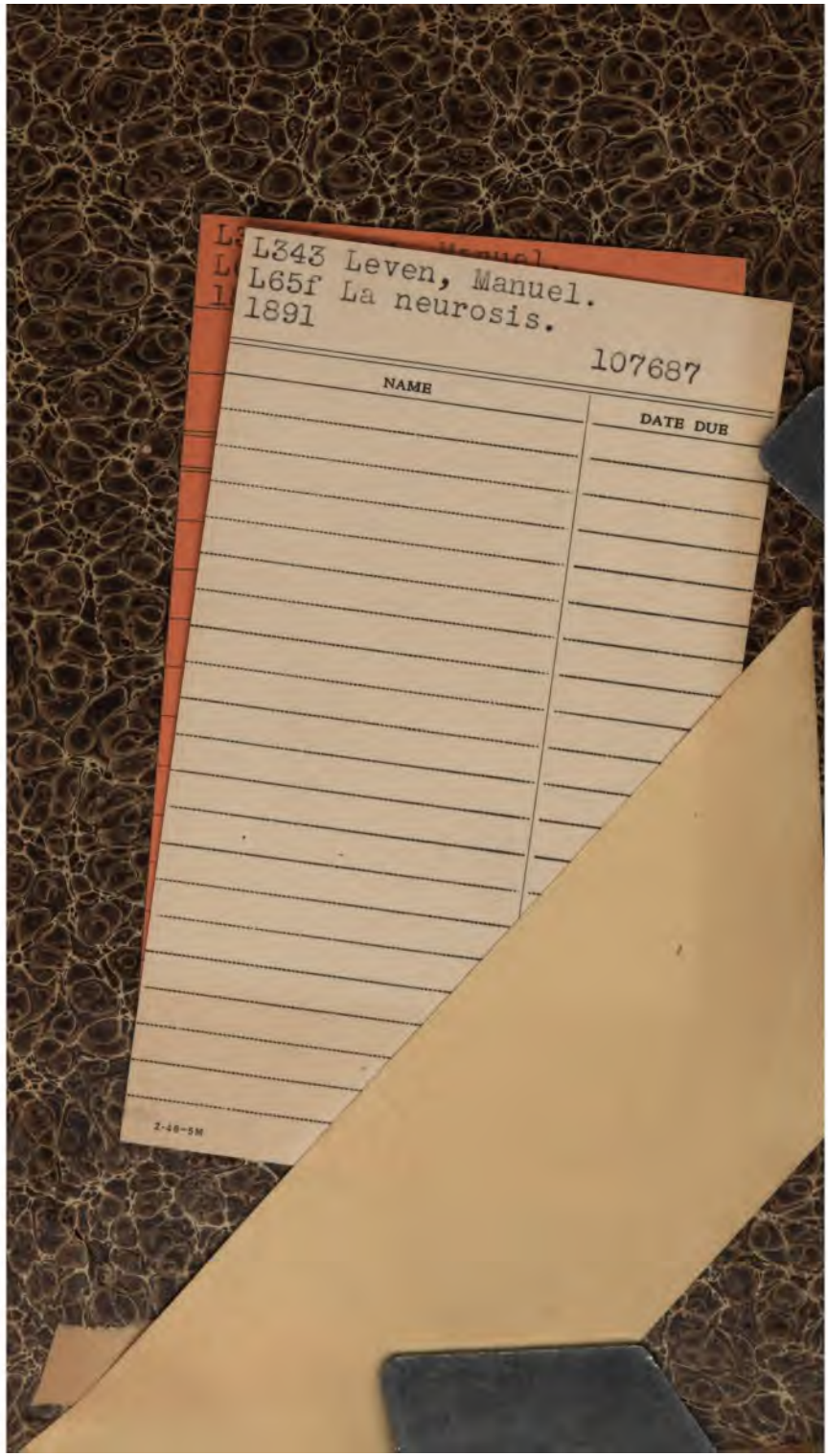
Tenemos la gran satisfaccion de poner en conocimiento de nuestros suscritores que esta publicacion ha recibido una mejora de gran importancia; este tomo no es la traduccion del *Anuario* inglés, y sí una parte de éste, aumentado con artículos de los autores más distinguidos de Alemania, América, Austria, Bélgica, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Rusia, lo que le hace un verdadero ANUARIO DE MEDICINA INTERNACIONAL, en el que aparecen las notabilidades médicas de todas las naciones; parece inútil decir que esta publicacion es indispensable á todas las personas amantes de su profesion que deseen estar al tanto de la marcha de la ciencia; para esto sirven los Anuarios.

Tetuan de Chamartin.—Imprenta de D. C. Bailly-Bailliere.

LANE MEDICAL LIBRARY

This book should be returned on or before
the date last stamped below.

10M—4-49—63290


L343 Leven, Manuel.
L65f La neurosis.
1891
107687
NAME
DATE DUE
2-48-5M